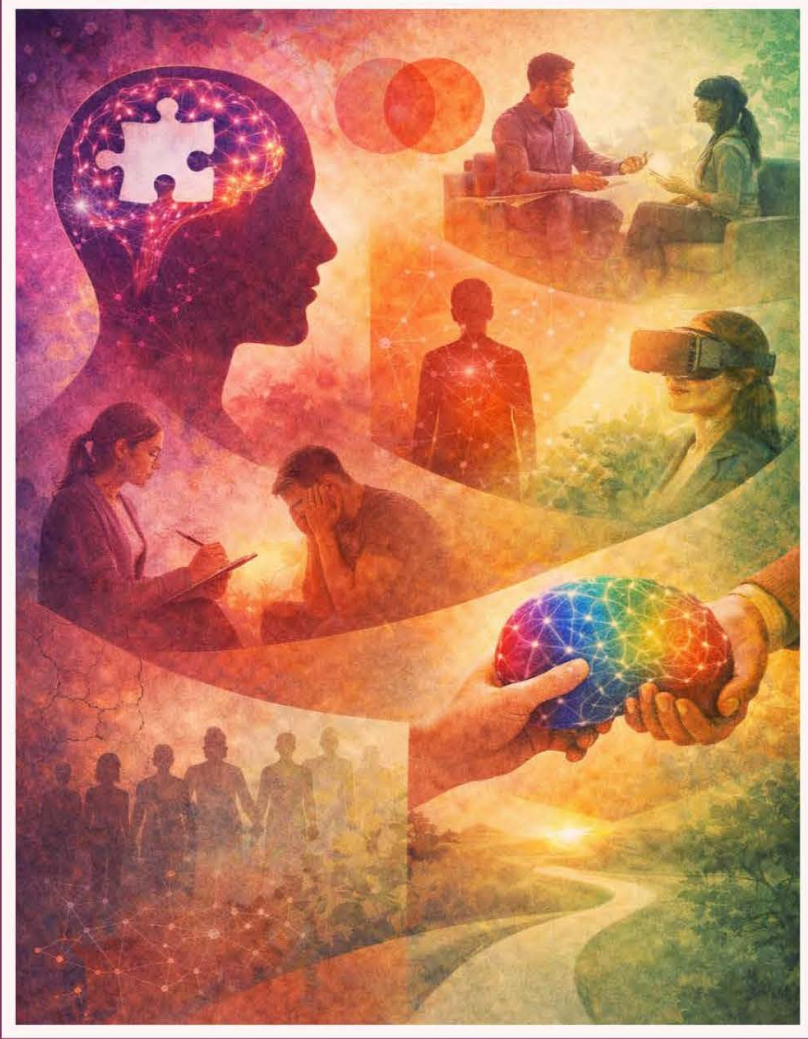


MODERN RUH SAĞLIĞI UYGULAMALARI: KLİNİK BULGULAR, TERAPÖTİK YÖNTEMLER VE PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER



EDİTÖRLER
DOÇ. DR. ÖZGÜR ALTINDAĞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM KILIÇ

**Modern Ruh Saėlıėı Uygulamaları: Klinik
Bulgular, Terapötik Yöntemler ve Psikososyal
Müdahaleler**

Editörler

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Adem KILIÇ

İmtiyaz Sahibi
Platanus Publishing®

Editör
Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ & Dr. Öğr. Üyesi Adem KILIÇ

Kapak & Mizanpaj & Sosyal Medya
Platanus Yayın Grubu

Birinci Basım
Aralık, 2025

Yayımcı Sertifika No
45813

ISBN
978-625-8519-48-3

©copyright
Bu kitabın yayım hakkı Platanus Publishing'e aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, izin alınmadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Adres: Natoyolu Cad. Fahri Korutürk Mah. 157/B, 06480, Mamak,
Ankara, Türkiye.

Telefon: +90 312 390 1 118
web: www.platanuspublishing.com
e-mail: platanuskita@gmail.com



Platanus Publishing®

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1	5
<i>Toplumsal Baskıdan Dayanıklılığa: Trans Bir Bireyde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu ve OKB İlişkisi</i>	
Nezihe Gül & İlay Dalkıran & Fatma Seher Kocaayan & Aslıhan Polat	
BÖLÜM 2	15
Trans Bireylerde Azınlık Stresiyle Başa Çıkma: Dayanıklılık ve Grup Psikoterapisi Üzerine Klinik Bulgular	
Nezihe Gül & İlay Dalkıran & Fatma Seher Kocaayan & Aslıhan Polat	
BÖLÜM 3	29
İlkokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri ile Annelerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi	
Zeynep Örnek & Mustafa Özçetin & İsmail Yıldız	
BÖLÜM 4	43
Postpartum Depresyonda Telepsikiyatrinin Etkinliği: Yüz Yüze Taramalarla Karşılaştırmalı Bir Çalışma	
Fatma Seher Kocaayan & İlay Dalkıran & Nezihe Gül & Mehtap Güngör & Elif Tatlıdil & Aslıhan Polat	
BÖLÜM 5	53
Nefes Egzersizlerinin Bağımlılık Tedavisinde Nörolojik Fizyolojik ve Ruhsal Boyutları	
Penbe Nur Görgülü	
BÖLÜM 6	65
21. Yüzyılın Sessiz Krizi: Sigara Bağımlılığına Grup Terapisiyle Müdahale Deneyimi	
İsmail Emre Ak & Narmin İsayeva & Bahadır Geniş	
BÖLÜM 7	79
Trans Bireylerde Cinsiyet Uyumlandırma Sürecinde Telepsikiyatri: Klinik Deneyim ve Avantajlar	
İlay Dalkıran & Nezihe Gül & Fatma Seher Kocaayan & Aslıhan Polat	

BÖLÜM 8.....91

**Metakognitif Grup Terapisinin Şizofreni ve Şizoaffectif Bozuklukta Duygu
Düzenleme Üzerindeki Etkisi**

Narmin İsayeva & İsmail Emre Ak

BÖLÜM 9.....107

**Çocuk Ruh Sağlığının Desteklenmesinde Doğa Temelli Müdahaleler: Bir
Derleme**

Öznur Elçelik & Nigar Çankaya & Nesrin Arslan & Nurcan Gebeşoğlu

BÖLÜM 1

Toplumsal Baskıdan Dayanıklılığa: Trans Bir Bireyde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu ve OKB İlişkisi*

Nezihe Gül¹ & İlay Dalkıran² &

Fatma Seher Kocaayan³ & Aslıhan Polat⁴

* Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

¹ Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID: 0009-0008-6554-7054

² Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID: 0009-0009-6433-2681

³ Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID: 0009-0001-7183-2002

⁴ Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID: 0000-0001-9649-8701

1. GİRİŞ

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon ve kompulsiyonların görüldüğü, işlevsellik kaybına yol açan kronik bir psikiyatrik hastalıktır. Obsesyonlar, kişinin kontrol etmekte zorlandığı, tekrarlayıcı ve kaygı uyandırıcı düşünce ya da imgeler iken; kompulsiyonlar bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıyı azaltmak amacıyla yapılan yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Yaygınlığının toplumda %1–3 arasında olduğu tahmin edilmektedir (Brock, Rizvi, & Hany, 2025).

Cinsiyet hoşnutsuzluğu, bireyin biyolojik cinsiyeti ile deneyimlediği cinsiyet kimliği arasında uyumsuzluk yaşamasıyla karakterizedir. Bu durum, sıklıkla toplumsal damgalanma, ayrımcılık ve kişilerarası çatışmalara neden olarak depresyon, anksiyete, madde kullanım bozuklukları, düşük yaşam doyumu, özsaygı kaybı, kendine zarar verme ve intihar riskinde artışla ilişkilidir (Garg, Elshimy, & Marwaha, 2025).

Son yıllarda görünürlüğü artan trans bireyler, toplumsal önyargılar ve ayrımcılığın yanı sıra ruhsal açıdan da ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda sosyal destek, ruhsal iyilik halini güçlendiren en önemli koruyucu faktörlerden biridir. Türk toplumu gibi aile bağlarının sıkı olduğu ve aile onayının yüksek değer taşıdığı kültürlerde aile desteği, bireyin ruhsal iyilik hâlini güçlendiren ve tedavi süreçlerini kolaylaştıran belirleyici bir faktördür.

Bu çalışmada, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ve OKB semptomları bulunan bir trans erkek bireyin, ailesine kimliğini açıklaması ve aile desteğini kazanmasının ardından obsesif kompulsif belirtilerinde belirgin ve ani gerileme gözlemlendiği özgün bir vaka sunulmaktadır. Bu durum, sosyal destek ve aile kabulünün hem azınlık stresiyle baş etmede hem de psikiyatrik semptomların iyileşmesinde kritik rolünü göstermesi bakımından önemlidir.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, tek olgu üzerinden hazırlanmış niteliksel bir vaka bildirimidir. Hastaya ait klinik öykü, psikiyatrik muayene bulguları ve tedavi süreçleri dosya kayıtları ve doğrudan görüşmeler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Olgu sunumu için hastadan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Veriler, cinsiyet hoşnutsuzluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk ilişkisini incelemek amacıyla azınlık stresi ve psikanalitik kuramsal çerçeveye yorumlanmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

Biyolojik cinsiyeti kadın, cinsiyet kimliği erkek olan 22 yaşındaki hastada, şikâyetlerinin 4–5 yaşlarında başladığı; bu dönemde erkek kıyafetleri giymek isteme, erkek oyunlarına yönelme, erkeklerle arkadaşlık kurma, kendini kızlardan farklı hissetme ve ‘erkek gibi olma’ arzusu yaşadığı öğrenilmiştir. Ergenlik

döneminde vücudundaki değişikliklerle birlikte bedeninden rahatsızlık duyduğu ve regl olmak istemediğini belirtmiştir.

Hasta, 14 yaşına kadar yaşadığı duruma bir anlam verememiş, lise döneminde dedesinin ve ardından dört ay içinde babaannesinin vefatı sonrası “Herkes bir gün ölecek, kimseyi dinlememeliyim, kendimi tanımalıyım ve kendi istediğim gibi yaşamalıyım” düşüncelerini geliştirmiştir. Bu süreçte, bedensel aidiyet hislerini sorgulamaya başlamış ve yas süreci nedeniyle evde geçirdiği zamanın artmasıyla sosyal medya üzerinden “transseksüalizm” terimini öğrenmiş ve bunun kendi yaşadığı durumu tanımladığını fark etmiştir.

Kendi kimliği ile ilgili farkındalığının artması, “Eğer trans bir bireysen toplum beni dışlar, Allah beni affetmez” şeklinde dini ve toplumsal içerikli suçluluk ve kaygı düşüncelerine yol açmıştır. Bu suçluluk ve kendini kirli hissetme duygularının etkisiyle, ellerini çamaşır suyuyla yıkama, yinelenen şekilde abdest alma, eşyaları üç kez yıkama ve sayma, birine zarar verdiği endişesiyle tekrar tekrar güvence arama, kapı-ocak-fiş gibi nesneleri defalarca kontrol etme ve emin olabilmek için fotoğraf çekerek kontrol etme davranışları ortaya çıkmıştır.

Psikiyatriye başvurduğunda cinsiyet hoşnutsuzluğuna ilişkin şikâyetinden bahsetmeyen hasta, yalnızca OKB belirtileri nedeniyle fluoksetin 20 mg/gün tedavisi başlanmış, kısmi düzelme üzerine ilaç kesilmiş; sonrasında semptomların yinelenmesiyle sertralin 150 mg/gün tedavisi düzenlenmiş, kısmi iyileşmeye rağmen hasta kendi isteğiyle tedaviyi sonlandırmıştır. Ardından psikolog görüşmelerine başlamış, kısa süreli kısmi bir iyilik hali tariflemiş ancak semptomları yeniden artış göstermiştir. Yaklaşık 14–15 yaşlarında başlayan şikâyetler nedeniyle iki yıl boyunca medikal tedavi ve psikiyatrik destek almış; 16–19 yaşları arasında ise tedavisiz kaldığı dönemde işlevselliğini belirgin şekilde bozan OKB belirtileri devam etmiştir.

Hastanın yaşamında kritik dönüm noktası, 19 yaşında bir düğün öncesinde “kadın gibi” giyinip makyaj yapmadığı için ailesiyle yaşadığı şiddetli tartışma olmuştur. Bu olayın ardından saçlarını kestirerek kendini “trans erkek” olarak ailesine ve çevresine açıklamıştır. Açıklama sonrası herhangi bir farmakoterapi veya psikiyatrik müdahale olmaksızın OKB belirtilerinde belirgin bir gerileme gözlenmiş ve yaklaşık iki yıl boyunca aktif semptom görülmemiştir. Ancak ailesinin onay vermemesi nedeniyle mastektomi ameliyatının ertelendiği dönemde OKB belirtileri yeniden ortaya çıkmıştır. Hastanın, bu durumun geçici bir heves olmadığına ve kimliği konusundaki kararlılığına ilişkin ailesiyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra, ameliyatı gerçekleştirecek hekim tarafından yapılan tıbbi açıklamalar sonrasında ailesinin kabulü sağlanmış; mastektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Ameliyatın ardından OKB belirtileri tamamen gerilemiş ve takiplerde tekrar gözlenmemiştir.

2024 yılında cinsiyet hoşnutsuzluğu nedeniyle başvuran hastanın muayenesinde OKB'ye ilişkin bulgu saptanmamıştır. Cinsiyet hoşnutsuzluğuna yönelik yaklaşık 1,5 yıldır düzenli psikiyatrik izlem altında olan, son bir yıldır da hormon tedavisi kullanan hastanın takiplerinde OKB belirtileri gözlenmemiştir.

Bu olgu, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan bireylerde obsesif-kompulsif belirtilerin ortaya çıkışında toplumsal baskı, dini inançlar ve aile desteğinin kritik rolünü göstermesi açısından dikkat çekicidir. Azınlık stresi modeli, trans bireylerin yalnızca günlük yaşam stresörlerinden değil; aynı zamanda kimlik temelli damgalanma ve ayrımcılıktan kaynaklanan özgün stresörlerden de etkilendiklerini vurgulamaktadır (Bockting et al., 2013). Bu model, trans bireylerde stresin süregelenleşmesiyle ruhsal semptomların şiddetlendiğini öne sürer (Meyer, 2015). Bu süreç, dışsal damgalanma ile içselleştirilmiş suçluluğun etkileşimi sonucu bireyin ruhsal dengesini bozan bir 'azınlık stresinin çift yönlü etkisi' olarak tanımlanabilir. Bu etkileşim, özellikle dinsel ve kültürel bağlamın güçlü olduğu toplumlarda, obsesif-kompulsif temalar üzerinden bedenselleşebilir.

Bu bağlamda, hastamızda kimliğine ilişkin farkındalığın artmasıyla birlikte gelişen "toplum tarafından dışlanma" ve "Allah tarafından affedilmeme" düşünceleri, azınlık stresinin bir yansıması olarak obsesif-kompulsif belirtileri tetiklemiştir. Literatürde, trans ve non-binary bireylerde depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozuklukların toplum ortalamasına kıyasla daha yüksek oranlarda görüldüğü bildirilmektedir (Expósito-Campos et al., 2023). Olgumuzda da suçluluk ve kirlenmişlik duyguları kompulsif temizlik ve kontrol davranışlarına yol açmıştır.

Son yıllarda, stresin yalnızca bilişsel düzeyde değil, nörofizyolojik düzeyde de etkiler yarattığı kabul edilmektedir. Kronik stresin hipotalamo-hipofizer-adrenal (HHA) aksı üzerinden kortizol düzeylerini sürekli olarak yükseltmesi, kompulsif davranışlardan sorumlu orbitofrontal korteks–striatum devresinde aşırı duyarlılığa yol açabilmektedir. Bu biyolojik mekanizma, bireyin sürekli tehdit algısı altında yaşamasının obsesif-kompulsif belirtileri pekiştiren bir fizyolojik zemin oluşturduğunu düşündürmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, hastamızın toplumsal kabul görmeme ve dini açıdan affedilmeme korkusu, yalnızca bilişsel bir çarpıtma değil, kronik stres yanıtı üzerinden nörofizyolojik bir aşırı uyarılma biçimi olarak da ele alınabilir. Bu durum, azınlık stresinin yalnızca psikososyal bir deneyim değil, aynı zamanda biyolojik bir yük olarak da değerlendirilebileceğini göstermektedir.

Bilişsel-davranışçı açıdan bakıldığında, hastamızın dini temelli suçluluk ve temizlik obsesyonları, ahlaki sorumluluk şemalarının aşırı genelleştirilmesiyle ilişkilendirilebilir. Salkovskis'in modeline göre, OKB'de birey, zihninden geçen düşüncelerin ahlaki değerine aşırı önem atfeder. Bu "düşünce-eylem birleşmesi" olarak bilinen bilişsel hata, bireyin yalnızca düşünmekle günah işlediğine

inanmasına yol açabilir. Bu durum, bireyin dini veya kültürel değerlerle çatıştığında ortaya çıkan aşırı suçluluk duygularının, tehlikeyi abartma ve kontrol ihtiyacını artırmasıyla açıklanabilir (Salkovskis, 1999). Bu vaka özelinde “Allah beni affetmez” inancı, düşünce-eylem birleşmesinin kültürel ve dini bir varyasyonu olarak görülebilir. Bu düşünce biçimi, bireyin zihnindeki “günahkâr” temayı kompulsif arınma davranışlarıyla nötralize etmeye çalışmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, temizlik ve tekrar davranışları yalnızca kaygı azaltıcı değil, ahlaki telafi işlevi gören ritüeller olarak da değerlendirilebilir.

İçselleştirilmiş transfobi, bu olguda dikkat çeken bir ara değişkendir. Toplumun olumsuz yargılarını içselleştiren bireyler, kendi kimlikleriyle çatışma yaşarken suçluluk ve cezalandırılma temalarını pekiştirirler. Bu içselleştirme, dini inançlarla birleştiğinde “affedilmeme” ve “kirlenme” temalarını güçlendirerek obsesif-kompulsif belirtileri derinleştirebilir. Bu tür düşünceler, bireyin süperegosu tarafından cezalandırıcı bir iç ses haline getirilir ve suçluluk duygusu kompulsif eylemlerle “temizlenmeye” çalışılır. Dolayısıyla içselleştirilmiş transfobi, OKB semptomlarının ahlaki içerikli biçimlerini anlamada kritik bir kavramsal çerçeve sunar.

Kültürel psikiyatri perspektifinden değerlendirildiğinde, Türkiye gibi kolektivist toplumlarda bireyin kimlik gelişimi, aile ve sosyal onayla yakından bağlantılıdır. Kolektivist kültürlerde bireyin benlik değeri yalnızca kişisel özelliklerle değil, ait olduğu topluluk tarafından kabul görme düzeyiyle belirlenmektedir (Kagitcibasi, 2017). Bu nedenle aile reddi, yalnızca bir dışlanma biçimi değil, aynı zamanda kimlik bütünlüğüne yönelen bir tehdit olarak deneyimlenir. Hastamızda bu durum açık biçimde gözlenmiştir: kimlik açıklaması sonrası ailesi tarafından reddedilme korkusu, OKB belirtilerini yoğunlaştırmış; ancak aile kabulüyle birlikte belirtiler belirgin biçimde azalmıştır. Hastanın başlangıçta ailesi tarafından reddedileceğine dair geliştirdiği kaygılar, süperego baskısının ve içsel cezalandırılma beklentisinin bir yansımasıdır. Ancak bu beklentilerin asılsız çıkması ve tam tersine ailenin kabulü, hastanın içsel çatışmasını hafifletmiş; suçluluk ve kaygı duygularında çözülmeye, dolayısıyla obsesif-kompulsif belirtilerde belirgin gerilemeye yol açmıştır. Hastanın ifadesiyle, ‘sanki üstümden bir yük kalktı’ sözü bu süreci en iyi biçimde özetlemektedir. Bu bağlamda aile kabulü, yalnızca sosyal destek açısından değil, aynı zamanda süperego baskısının çözülmesi ve ego-süperego çatışmasının yatışması bakımından da klinik olarak önem taşımaktadır.

Psikanalitik bakış açısından değerlendirildiğinde obsesif-kompulsif bozukluk, sıklıkla katı süperego baskısı ve bunun doğurduğu yoğun suçluluk duyguları ile ilişkilendirilmektedir (Leichsenring & Steinert, 2016). Toplumsal normlar ve dini otoriteyi temsil eden dışsal figürler bireyin süper egosunu biçimlendirmekte; kabul görmeme ya da dışlanma tehdidi içsel bir suçluluk ve cezalandırılma ihtiyacını tetiklemektedir. Bu açıdan hastamızın kompulsif temizlik ritüelleri,

suçluluk duygularını telafi etmeye ve kendini cezalandırmaya yönelik davranışlar olarak düşünülebilir. Bu durum, bireyin kendi süperegosuyla olan çatışmasının bedensel bir dışavurumu olarak da değerlendirilebilir; kişi, içsel kirlenmişlik hissini “temizlik” davranışları aracılığıyla arındırmaya çalışır. Shakespeare’in *Macbeth* oyununda Lady Macbeth’in suçluluk duygusunu ellerini defalarca yıkayarak gidermeye çalışması gibi, hastamızda da suçluluk ve kirlenmişlik hisleri temizlik kompulsiyonlarına dönüşmüştür. Bu benzetme, suçluluk duygusunun yalnızca bilinç düzeyinde değil, bedensel düzeyde de deneyimlendiğini ve tekrarlayıcı davranışlarla sembolik bir şekilde “arınma” arayışına dönüştüğünü vurgular. Freud’un “tekrarlama zorlantısı” kavramı, bu ritüellerin bilinçdışı bir özcezalandırma biçimi olduğunu açıklamak için uygun bir çerçeve sunmaktadır.

Klinik açıdan dikkat çekici nokta, farmakoterapi ve psikiyatrik desteğin yalnızca kısmi düzelme sağlamasına rağmen, kimliğin açıklanması ve aile desteğiyle OKB belirtilerinin tam ve kalıcı biçimde gerilemesidir. Psikanalitik açıdan bu süreç, bireyin süperego baskısını dönüştüren ve içsel çatışmayı yatıştıran bir “onarım edici kabul” dinamiğiyle açıklanabilir. Ailenin bireyin kimliğini tanıması, dışsal otorite figürünün içselleştirilmiş cezalandırıcı yönünü dönüştürür; bu dönüşüm ego’nun bastırılmış dürtülerle daha uyumlu bir ilişki kurmasını sağlar. Bu süreç, yalnızca belirtilerin azalmasına değil, aynı zamanda benlik bütünlüğünün yeniden kurulmasına da katkı sağlar. Literatür, sosyal destek ve aile kabulünün trans bireylerde psikolojik dayanıklılığı artırarak ruhsal belirtileri azalttığını göstermektedir (Budge et al., 2024; Goetz et al., 2025). Aile kabulü, süperego baskısının kaynağı olan reddedilme korkusunu ortadan kaldırarak içsel dengeyi yeniden kuran bir psikodinamik düzenleyici olarak değerlendirilebilir.

Türk toplumu gibi güçlü aile bağlarının korunduğu kültürlerde aile kabulü, bireyin kendi kimliğini kabullenmesini kolaylaştırmakta; OKB gibi psikiyatrik belirtilerin gerilemesine ve ruhsal iyilik hâlinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Benzer biçimde, kolektivist kültürlerde bireyin benlik algısı, aile tarafından sağlanan “aitlik” duygusuyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle, aile onayı yalnızca duygusal bir destek değil, benlik sınırlarının yeniden inşasında temel bir yapı taşıdır. Hendricks ve Testa’nın azınlık stresi modelinde de vurgulandığı gibi, çevresel kabul ve sosyal destek, kimlik temelli stresin nötralize edilmesinde merkezi bir rol oynar (Hendricks & Testa, 2012). Olgumuzda da kimlik kabulü ve aile onayı, yalnızca stresin azalmasına değil, OKB belirtilerinin tamamen çözülmesine aracılık etmiştir.

Klinik uygulamalar açısından bakıldığında bu vaka, cinsiyet kimliğiyle ilişkili psikopatolojilerin yalnızca farmakolojik müdahalelerle sınırlı kalmaması gerektiğini göstermektedir. Terapötik süreçte kültüre duyarlı yaklaşımlar, aile danışmanlığı ve bilişsel yeniden yapılandırma stratejilerinin eklenmesi, kimliksel

ve ruhsal bütünlüğü aynı anda destekler (American Psychological Association, 2015).

Toplumsal düzeyde, trans bireylerin ruh sağlığı üzerindeki damgalanmanın azaltılması, bireysel tedavi süreçlerinin başarısını doğrudan etkileyebilmektedir. Cinsiyet çeşitliliğine saygı gösteren ve kapsayıcı yaklaşımları benimseyen sağlık politikaları, ruh sağlığı göstergelerinde belirgin iyileşmelere katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bireysel iyileşmenin sürdürülebilmesi için toplumsal kabulün yapısal düzeyde güçlendirilmesi gerekmektedir.

4. SONUÇLAR

Bu olgu, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan bireylerde obsesif-kompulsif belirtilerin yalnızca biyolojik ya da bilişsel mekanizmalarla açıklanamayacağını; toplumsal baskı, dini inanç sistemleri ve aile ilişkilerinin bu belirtilerin şekillenmesinde merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Hastada gözlenen suçluluk, kirlenmişlik ve affedilmeme temaları, azınlık stresinin psikanalitik düzeyde nasıl bedenselleştiğini ve içselleştirilmiş toplumsal normların obsesif-kompulsif belirtiler üzerinden nasıl yeniden üretilebildiğini ortaya koymaktadır.

Bu vaka, bireysel ruhsal süreçlerin toplumsal yapıdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Trans bireylerin maruz kaldığı dışsal damgalanma, dini ve kültürel değerlerle iç içe geçmiş ahlaki ikilemleri tetiklemekte; bu durum bireyin süpereo baskısını güçlendirerek obsesif-kompulsif davranışlara zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla, bu olgu yalnızca bir psikopatoloji örneği değil; toplumsal cinsiyet, inanç ve psikodinamik süreçler arasındaki karmaşık etkileşimin klinik bir yansımasıdır.

Olguda en dikkat çekici bulgulardan biri, kimlik açıklaması ve aile desteğinin sağlanmasıyla birlikte obsesif-kompulsif belirtilerde tam ve kalıcı bir iyileşmenin gözlenmiş olmasıdır. Ailenin kabul edici tutumu, bireyin süpereo baskısını dönüştürmüş, içsel cezalandırılma beklentisini azaltmış ve ego-süpereo çatışmasını çözümleme yönünde güçlü bir psikodinamik etki yaratmıştır. Bu süreç, yalnızca semptomatik düzelmeyi değil, aynı zamanda benlik bütünlüğünün yeniden inşasını da mümkün kılmıştır. Bu bulgu, aile kabulünün klinik açıdan yalnızca sosyal destek değil, içsel bütünleşmeyi sağlayan bir “onarım edici kabul” (reparative acceptance) işlevi görebileceğini ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, azınlık stresi modelinin psikanalitik, bilişsel ve kültürel yaklaşımlarla birlikte ele alınması, cinsiyet kimliği temelli ruhsal bozuklukların anlaşılmasında önemli bir bütüncül çerçeve sunmaktadır. Trans bireylerde obsesif-kompulsif belirtilerin yalnızca intrapsişik çatışmaların değil; aynı zamanda toplumsal dışlanma, dinsel suçluluk ve kimliksel reddedilmenin de sonucu olabileceği anlaşılmaktadır. Bu çok katmanlı yapı, tedavi planlarının yalnızca bireyin iç dünyasına değil, aynı zamanda çevresel destek sistemlerine odaklanmasını zorunlu kılmaktadır.

Kültürel açıdan, Türkiye gibi kolektivist toplumlarda bireyin ruhsal iyilik hali, ait olduğu sosyal çevre ve aile sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Bu kültürel bağlamda aile kabulü, bireyin kendi kimliğini kabullenme sürecini kolaylaştırmakta; reddedilme korkusunu azaltarak psikolojik dayanıklılığı güçlendirmektedir. Bu olguda da aile desteği, yalnızca bir sosyal destek unsuru değil; aynı zamanda süperego baskısını çözerek kimliksel bütünleşmeyi mümkün kılan bir terapötik araç işlevi görmüştür.

Klinik açıdan değerlendirildiğinde, bu vaka; cinsiyet kimliğiyle ilişkili psikopatolojilerin tedavisinde çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğine işaret etmektedir. Farmakoterapi ve bireysel psikoterapiye ek olarak, kültüre duyarlı terapötik teknikler, aile danışmanlığı ve bilişsel yeniden yapılandırma yöntemlerinin entegre edilmesi, hem semptomların çözülmesini hem de kimliksel bütünlüğün güçlenmesini destekleyebilir. Bu çok katmanlı yaklaşım, hem içsel çatışmaların çözümünü hem de toplumsal düzeyde onarım süreçlerini kapsar.

Sonuç olarak, bu olgu; bireysel psikopatolojinin yalnızca biyolojik ya da psikodinamik açıklamalarla sınırlandırılmayacağını, toplumsal bağlamın da ruhsal iyileşmede belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Kimliğin kabulü, sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal damgalamanın azaltılması, azınlık stresinin yarattığı çok boyutlu yükü hafifletebilir. Bu bağlamda, ruh sağlığı hizmetlerinin bireysel iyileşmenin ötesine geçerek sosyal adalet, kapsayıcılık ve eşitlik ilkeleriyle bütünleştirilmesi, hem klinik hem de toplumsal iyileşmenin temelini oluşturacaktır.

KAYNAKÇA

- American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. *American psychologist*, 70(9), 832-864.
- Bockting, W. O., Miner, M. H., Swinburne Romine, R. E., Hamilton, A., & Coleman, E. (2013). Stigma, mental health, and resilience in an online sample of the US transgender population. *American Journal of Public Health*, 103(5), 943–951. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301241>
- Brock, H., Rizvi, A., & Hany, M. (2025). Obsessive-compulsive disorder. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31985955>
- Budge, S. L., Tebbe, E. A., & Love, D. (2024). The development and pilot testing of a minority stress psychoeducation tool for transgender and nonbinary people. *Transgender Health*, 9(3), 275–279. <https://doi.org/10.1089/trgh.2022.0038>
- Expósito-Campos, P., Pérez-Fernández, J. I., & Salaberria, K. (2023). Empirically supported affirmative psychological interventions for transgender and non-binary youth and adults: A systematic review. *Clinical Psychology Review*, 100, 102229. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102229>
- Garg, G., Elshimy, G., & Marwaha, R. (2025). Gender dysphoria. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335346>
- Goetz, T. G., Kishton, R., & Wolk, C. B. (2025). Integrating Psychiatric Care With Gender-Affirming Primary Care to Meet Transgender, Non-Binary, and Gender Expansive Mental Health Needs: A Pilot Study. *Journal of Primary Care & Community Health*, 16, 21501319251357728.
- Hendricks, M. L., & Testa, R. J. (2012). A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. *Professional psychology: Research and practice*, 43(5), 460.
- Kagitcibasi, C. (2017). *Family, self, and human development across cultures: Theory and applications*. Routledge.
- Leichsenring, F., & Steinert, C. (2016). Psychodynamic therapy of obsessive-compulsive disorder: principles of a manual-guided approach. *World Psychiatry*, 15(3), 293.
- Meyer, I. H. (2015). Resilience in the study of minority stress and health of sexual and gender minorities. *Psychology of sexual orientation and gender diversity*, 2(3), 209.
- Salkovskis, P. M. (1999). Understanding and treating obsessive—compulsive disorder. *Behaviour research and therapy*, 37, S29-S52.

BÖLÜM 2

Trans Bireylerde Azınlık Stresiyle Başa Çıkma: Dayanıklılık ve Grup Psikoterapisi Üzerine Klinik Bulgular*

**Nezihe Gül² & İlay Dalkıran³ &
Fatma Seher Kocaayan³ & Aslıhan Polat⁴**

*¹ Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

² Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID: 0009-0008-6554-7054

³ Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID: 0009-0009-6433-2681

³Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID:0009-0001-7183-2002

⁴Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, ORCID: 0000-0001-9649-8701

1. GİRİŞ

Cinsiyet hoşnutsuzluğu, bireyin biyolojik cinsiyeti ile deneyimlediği cinsiyet kimliği arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan klinik bir durumdur. Bu tanıyı alan bireyler, sıklıkla toplumsal damgalanma, ayrımcılık ve dışlanma gibi “azınlık stresi”ne maruz kalmaktadır. Yapılan çalışmalar, trans ve non-binary bireylerin depresyon, anksiyete ve intihar davranışlarını toplum ortalamasına kıyasla daha yüksek oranlarda yaşadığını ortaya koymaktadır (Bockting et al., 2013).

Azınlık stresi modeli, bu bireylerin yalnızca günlük yaşam stresörlerinden değil; aynı zamanda kimlik temelli damgalanma ve ayrımcılıktan kaynaklanan özgün stresörlerden de etkilendiklerini vurgulamaktadır (Bockting et al., 2013). Bununla birlikte, sosyal destek, aile desteği ve olumlayıcı sağlık hizmetleri bu olumsuz etkileri hafifletebilmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar, psikososyal destek ve grup temelli müdahalelerin damgalanma ile baş etme becerilerini artırarak psikolojik dayanıklılığı güçlendirdiğini göstermektedir (Expósito-Campos et al., 2023).

Son dönemde geliştirilen azınlık stresi psiko-eğitim araçları, trans bireylerin yaşadıkları stresörleri tanımlamalarına ve bu deneyimlerin içselleştirilmiş etkilerinden uzaklaşmalarına yardımcı olmuştur (Budge et al., 2024). Bu tür müdahalelerin bireylerin öz yeterliliğini ve baş etme stratejilerini artırarak psikoterapi süreçlerine olumlu katkı sunduğu bildirilmiştir. Ayrıca, cinsiyet azınlıklarına yönelik bütüncül psikiyatrik bakım modelleri, depresyon ve anksiyete semptomlarında anlamlı azalma sağlayarak bu yaklaşımın klinik etkinliğini desteklemektedir (Goetz et al., 2025).

Bu bağlamda, düzenli psikiyatrik izlem ve grup psikoterapisi uygulamaları, kişilerin sorunlarını paylaşabildiği, benzer deneyimlere sahip bireylerle iletişim kurabildiği, destek alabildiği ve psikolojik güçlenme sağlayabildiği önemli müdahaleler olarak değerlendirilmektedir. Grup psikoterapilerinin, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan bireylerde azınlık stresi düzeylerini azaltmaya ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmaya katkı sağlayarak toplumsal sağlık ve eşitlik açısından olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Polikliniği’ne cinsiyet hoşnutsuzluğu nedeniyle başvuran ve en az bir yıldır grup psikoterapisi sürecine devam eden bireylerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Grup psikoterapisinde; azınlık stresiyle baş etme, zorluklarla mücadele, sürecin yönetimi, eğitim ve iş yaşamında ilerleme, sosyal destek sağlanmasının faydaları gibi konular ele alınmaktadır. Bu çalışmada, grup psikoterapisinin azınlık stresi düzeylerine olası etkisi tartışılmıştır.

2. YÖNTEM

Bu çalışmaya, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Polikliniği'ne başvuran ve grup psikoterapilerine en az 1 yıldır devam 28 birey dahil edilmiştir. Katılımcılardan iki kişi çalışmaya devam etmek istemediği, bir kişi ise ölçekleri eksik/yanlış doldurduğu için değerlendirme dışında bırakılmıştır. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Bireylerin yaşadığı azınlık stresini ve dayanıklılığı değerlendirmek amacıyla Cinsel Azınlık Stresi ve Dayanıklılık Ölçeği (CASDÖ; Şahin ve ark., 2023) uygulanmıştır. Ölçek; distal stres (cinsiyet ilişkili ayrımcılık, reddedilme, mağduriyet, kimliğin olumlanmaması), proksimal stres (içselleştirilmiş transfobi, olumsuz gelecek beklentileri, gizlilik) ve dayanıklılık (onur, topluluk bağı) olmak üzere dokuz alt boyuttan oluşmaktadır. Her bir alt boyut farklı sayıda madde içermekte olup, puan aralıkları değişmektedir: Cinsiyet ilişkili ayrımcılık (0–5), Cinsiyet ilişkili reddedilme (0–6), Cinsiyet ilişkili mağduriyet (0–6), Cinsiyet kimliğinin olumlanmaması (0–24), İçselleştirilmiş transfobi (0–32), Onur (0–32), Gelecek ile ilgili olumsuz beklentiler (9–45), Gizlilik (5–25) ve Topluluk Bağı (5–25). Distal ve proksimal stres alt ölçeklerinde yüksek puanlar daha fazla algılanan stres düzeyini, dayanıklılık alt ölçeklerinde yüksek puanlar ise koruyucu faktörleri göstermektedir. Ek olarak Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği de uygulanmıştır. Elde edilen ölçek puanları SPSS 25.0 yazılımı kullanılarak analiz edilmiş ve tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkları incelemek için parametrik varsayımlar sağlanmadığından Kruskal–Wallis testi uygulanmıştır. Anlamli bulunan değişkenler için farkın yönünü belirlemek amacıyla Mann–Whitney U post-hoc testleri yapılmıştır ($p < 0.05$ anlamlı kabul edilmiştir).

3. BULGULAR VE YORUM

Çalışmaya toplam 25 birey katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 25.16 ± 4.50 yıl (19–38) olup katılımcıların %52'si hormon tedavisi kullanmaktadır; ortalama kullanım süresi 24.0 ± 17.7 ay (2–60) olarak saptanmıştır. (Tablo 1). Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%72) trans erkek olması, mevcut literatürde de vurgulanan bir eğilimi desteklemektedir. Klinik ortamlarda trans erkeklerin yardım arama ve tedaviye erişim oranlarının daha yüksek olduğu, bunun da görünürlük farkı ve sosyal destek dinamikleriyle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Budge et al., 2024; Goetz et al., 2025).

Tablo 1. Katılımcıların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Özellik		n	%	Ortalama $\pm$ SS (Min–Maks)
Yaş (yıl)		25	-	25.16 $\pm$ 4.50 (19–38)
Cinsiyet kimliği	Trans erkek	18	72.0	
	Trans kadın	7	28.0	
Eğitim düzeyi	Ortaokul	3	12.0	
	Lise	11	44.0	
	Üniversite	11	44.0	
Çalışma durumu	Çalışıyor	15	60.0	
	Çalışmıyor	10	40.0	
Gelir düzeyi	Asgari ücret altı	7	28.0	
	Asgari ücret	7	28.0	
	Asgari ücretin 2 katı	4	16.0	
	Asgari ücretin 2 katından fazla	6	24.0	
Hormon kullanımı	Var	13	52.0	
	Yok	12	48.0	
Hormon kullanım süresi (ay)		13	-	24.0 $\pm$ 17.7 (2–60)
Birlikte yaşadığı kişi	Aile	19	76.0	
	Yalnız	1	4.0	
	Arkadaş	3	12.0	
	Partner	2	8.0	
Aile desteği	Var	17	68.0	
	Yok	8	32.0	
Partner durumu	Var	12	48.0	
	Yok	13	52.0	
Sigara kullanımı	Var	20	80.0	
	Yok	5	20.0	
Alkol kullanımı	Yok	7	28.0	
	Ara sıra	16	64.0	
	Düzenli	2	8.0	
Madde kullanımı	Yok	25	100.0	
Bedensel hastalık	Var	3	12.0	
	Yok	22	88.0	
Psikiyatrik tanı	Var	5	20.0	
	Yok	20	80.0	
Psikiyatrik ilaç kullanımı	Var	2	8.0	
	Yok	23	92.0	

Psikiyatrik belirti düzeyleri incelendiğinde, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ortalaması 9.58 ± 7.79 , Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ortalaması 9.52 ± 8.61

bulunmuş; genel olarak hafif düzeyde depresyon ve anksiyete belirtileri gözlenmiştir. Bu oranlar toplum ortalamasına kıyasla yüksek olup, trans bireylerde depresyon ve anksiyetenin yaygın olduğunu gösteren önceki bulgularla paraleldir (Bockting et al., 2013; Goetz et al., 2025). Bu durum, örneklem grubundaki bireylerin sürmekte olan azınlık stresi ve toplumsal dışlanma deneyimlerinden kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda bu düzeylerin “hafif” aralıkta seyretmesi, grup temelli terapilerin düzenli olarak sürdürüldüğü klinik örneklemelerde beklenen bir eğilimdir. Grup terapileri, bireylerin sosyal destek algılarını güçlendirerek depresif belirtilerin azalmasına katkı sağlamaktadır.

Cinsel Azınlık Stresi ve Dayanıklılık Ölçeği (CASDÖ) alt boyutları değerlendirildiğinde en düşük ortalamanın Cinsiyet ilişkili mağduriyet alt boyutunda (0.80 ± 1.04) olduğu; görece yüksek değerlerin ise Gelecek ile ilgili olumsuz beklentiler (15.40 ± 7.91) ve Topluluk Bağı (16.68 ± 4.86) boyutlarında görüldüğü belirlenmiştir. Alt boyutların puan aralıkları birbirinden farklı olduğundan, bu yorum “ham ortalamalar” yerine bağlam içinde okunmalıdır: Gelecek ile ilgili olumsuz beklentiler alt boyutlarındaki yükseklik olumsuz beklentilerle ilişkili stresin görece yüksekliğine, Topluluk Bağı alt boyutundaki yükseklik ise dayanıklılığın/koruyucu faktörlerin görece gücüne işaret etmektedir (Tablo 2). Bu sonuç, azınlık stresi modelinde yer alan “sosyal destek → dayanıklılık → ruh sağlığı” bağlantısını destekler niteliktedir (Meyer, 2015; Barr et al., 2016). Topluluk bağının yüksek olması, sosyal destek mekanizmalarının bireyin stresle başa çıkma kapasitesini artırdığını ve ruhsal iyi oluşu koruyucu bir tampon olarak güçlendirdiğini göstermektedir. Grup terapilerinde kurulan etkileşimsel ilişkiler, bireylerin benzer deneyimlerle empati kurmasını sağlayarak hem öz-kabulü hem de dayanıklılığı artırmaktadır. Bu bağlamda, grup terapilerinin yalnızca klinik belirtileri azaltmakla kalmayıp, topluluk aidiyetini ve psikososyal dayanıklılığı pekiştirdiği söylenebilir.

Tablo 2. Katılımcıların Tanımlayıcı İstatistikleri

Değişken	N	Ortalama $\pm$ SS	Gözlenen Min-Maks
Yaş (yıl)	25	25.16 $\pm$ 4.51	19 – 38
Hormon kullanım süresi (ay)	13	24.00 $\pm$ 17.74	2 – 60
BDÖ	25	9.58 $\pm$ 7.79	0 – 29
BAÖ	25	9.52 $\pm$ 8.61	0 – 29
Cinsiyet ilişkili ayrımcılık (A)	25	2.32 $\pm$ 1.57	0 – 5
Cinsiyet ilişkili reddedilme (B)	25	1.68 $\pm$ 1.52	0 – 5
Cinsiyet ilişkili mağduriyet (C)	25	0.80 $\pm$ 1.04	0 – 3
Cinsiyet kimliğinin olumlanmaması (D)	25	7.00 $\pm$ 5.87	0 – 21
İçselleştirilmiş transfobi (E)	25	7.68 $\pm$ 8.67	0 – 28
Onur (F)	25	14.64 $\pm$ 9.79	0 – 31
Gelecek ilgili olumsuz beklenti (G)	25	15.40 $\pm$ 7.91	9 – 41
Gizlilik (H)	25	10.44 $\pm$ 4.26	5 – 23
Topluluk Bağı (J)	25	16.68 $\pm$ 4.86	6 – 25

Kruskal–Wallis analizleri, bazı sosyodemografik ve klinik değişkenlere göre ölçek puanlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (Tablo 3). Cinsiyet kimliği; Cinsiyet ilişkili ayrımcılık, reddedilme, mağduriyet ve Gelecek ile ilgili olumsuz beklentiler alt boyutlarında anlamlı fark yaratmıştır. Bu farkın trans kadınlar lehine olması, literatürde sıklıkla vurgulanan toplumsal görünürlük ve damgalanma düzeyiyle uyumludur (Hendricks & Testa, 2012). Trans kadınların iş, barınma ve sağlık alanlarında daha yüksek düzeyde dışlanma yaşadığı çeşitli çalışmalarda da rapor edilmiştir (Reisner et al., 2016; Budge et al., 2013). Çalışma durumu, BDÖ ve BAÖ puanlarının yanı sıra Cinsiyet ilişkili mağduriyet ve Gelecek ile ilgili olumsuz beklentiler alt boyutlarında anlamlı fark yaratmış; istihdamın hem ruhsal belirtiler hem de azınlık stresi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, istihdamın psikolojik iyi oluşu desteklediği ve azınlık stresini azalttığı literatürde de vurgulanmaktadır (Puckett et al., 2018). Bu durum, ekonomik bağımsızlık ve sosyal kimlik onayının ruhsal iyilik haline katkı sunduğunu göstermektedir.

Birlikte yaşadığı kişi değişkenine göre Cinsiyet ilişkili ayrımcılık alt boyutunda anlamlı farklılık saptanmış; ancak gruplardaki örneklem sayılarının çok düşük olması nedeniyle post-hoc testler güvenilir bulunmamıştır. Bu bulgu, sosyal destek biçimlerinin farklı türlerinin (aile, partner, arkadaş) azınlık stresi üzerindeki etkisinin daha geniş örneklemelerde incelenmesi gerektiğini düşündürmektedir (Kcomt & Gorey, 2019).

Tablo 3. Kruskal-Wallis Analizi

Değişken	BDÖ	BAÖ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Cinsiyet kimliği	0.949	0.505	0.028*	0.020*	0.004*	0.903	0.483	0.060	0.044*	0.583	0.831
Eğitim düzeyi	0.507	0.518	0.701	0.827	0.086	0.425	0.933	0.287	0.761	0.469	0.844
Çalışma durumu	0.009*	0.048*	0.295	0.307	0.002*	0.200	0.070	0.803	0.023*	0.342	0.147
Gelir	0.475	0.387	0.140	0.683	0.291	0.207	0.963	0.517	0.987	0.447	0.568
Birlikte yaşadığı kişi	0.150	0.427	0.006*	0.753	0.282	0.579	0.777	0.557	0.075	0.241	0.311
Sigara	0.846	0.785	0.267	0.531	0.824	0.142	0.811	0.247	0.754	0.289	0.013*
Alkol	0.826	0.781	0.531	0.510	0.816	0.668	0.498	0.488	0.169	0.363	0.946
Bedensel hastalık	0.126	0.209	0.096	0.521	0.217	0.900	0.933	0.276	0.157	0.673	0.705
Psikiyatrik tanı	0.025*	0.276	0.176	0.118	0.034*	0.453	0.218	0.634	0.018*	0.431	0.393
Psikiyatrik ilaç	0.047*	0.071	0.609	0.051	0.100	0.035*	0.034*	0.292	0.064	0.096	0.159
Hormon kullanımı	0.027*	0.076	0.101	0.486	0.976	0.020*	0.622	0.913	0.616	0.324	0.382
Aile desteği	0.007*	0.243	0.372	0.371	0.824	0.619	0.977	0.381	0.169	0.883	0.208
Partner	0.027*	0.165	0.127	0.781	0.372	0.662	0.171	0.567	0.042*	0.511	0.978

Not: $p < 0.05$ olan değerler yıldız (*) ile işaretlenmiştir.

Ancak Kruskal-Wallis testi yalnızca gruplar arasında fark olup olmadığını göstermektedir. Bu nedenle anlamlı çıkan değişkenler için Mann-Whitney U post-hoc testleri yapılmıştır.

Post-hoc bulgulara göre; trans kadınlar, trans erkeklere kıyasla ayrımcılık, reddedilme, mağduriyet ve gelecekle ilgili olumsuz beklentiler boyutlarında daha yüksek puanlar almıştır. Bu fark, toplumsal cinsiyet rolleri ve görünürlük dinamiklerinin azınlık stresine etkisini açıkça yansıtmaktadır. Trans kadınların medyada ve kamusal alanda daha fazla görünür olmaları, onları hem görünürlük hem de ayrımcılığa açıklık açısından daha savunmasız hale getirmektedir.

Çalışmayan bireylerde depresyon, anksiyete, mağduriyet ve gelecekle ilgili olumsuz beklentiler puanları çalışanlara göre daha yüksektir. Çalışma durumu açısından, işsizliğin depresyon ve anksiyeteyi artırdığı bilinmektedir. Trans bireylerde iş bulma güçlüklerinin azınlık stresini tetiklemesi, çalışmayanlarda hem psikiyatrik belirtilerin hem de stres puanlarının yüksek çıkmasını açıklayabilir. Bu bulgu, sosyal dışlanmanın yapısal eşitsizliklerle birleştiğinde ruhsal sağlığı doğrudan etkilediğini gösteren azınlık stresi kuramı ile de uyumludur (Meyer, 2015).

Psikiyatrik tanısı olan bireylerde depresyon, mağduriyet ve gelecekle ilgili olumsuz beklentiler puanları tanısı olmayanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Psikiyatrik ilaç kullanan bireylerde depresyon ve içselleştirilmiş transfobi puanları daha yüksektir. Hormon tedavisi almayan bireylerde depresyon puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Hormon tedavisinin yalnızca biyolojik bir müdahale değil, kimlik bütünlüğünü destekleyen psikososyal bir araç olduğu çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır (Costa & Colizzi, 2016; Baker et al., 2021).

Aile desteği olmayan bireylerde depresyon puanları daha yüksek bulunmuştur. Partneri olmayan bireylerde depresyon ve gelecekle ilgili olumsuz beklentiler puanları partneri olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Aile ve partner desteği bulguları, azınlık stresi modelinde tanımlanan en güçlü koruyucu faktörlerle uyumludur. Bulgular, sosyal desteğin depresyon belirtilerini azalttığını ve koruyucu bir tampon mekanizma oluşturduğunu desteklemektedir (Barr et al., 2016).

Sigara kullanmayan bireylerde topluluk bağı puanlarının sigara kullananlara göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür ve dikkat çekicidir. Bu durum, topluluk aidiyeti güçlü olan bireylerin sağlıklı başa çıkma yollarını daha fazla tercih etmesi ve zararlı başa çıkma stratejilerine (örneğin sigara) daha az yönelmesiyle ilişkili olabilir. Birlikte yaşadığı kişi değişkeninde ise düşük örneklem sayısı nedeniyle post-hoc sonuçlar güvenilir bulunmamış, yalnızca tanımlayıcı düzeyde raporlanmıştır (Tablo 4)

Tablo 4. Mann–Whitney U post-hoc test sonuçları

Değişken	Alt Boyut	Farkın Yönü	p-değeri
Cinsiyet kimliği	Ayrımcılık (A)	Trans kadın > Trans erkek	0.028
	Reddedilme (B)	Trans kadın > Trans erkek	0.020
	Mağduriyet (C)	Trans kadın > Trans erkek	0.004
Çalışma durumu	Olumsuz beklentiler (G)	Trans kadın > Trans erkek	0.044
	Mağduriyet (C)	Çalışmayan > Çalışan	0.002
	Olumsuz beklentiler (G)	Çalışmayan > Çalışan	0.023
	Depresyon (BDÖ)	Çalışmayan > Çalışan	0.009
	Anksiyete (BAÖ)	Çalışmayan > Çalışan	0.048
	Mağduriyet (C)	Tanısı olan > Tanısı olmayan	0.034
Psikiyatrik tanı	Olumsuz beklentiler (G)	Tanısı olan > Tanısı olmayan	0.018
	Depresyon (BDÖ)	Tanısı olan > Tanısı olmayan	0.025
	Depresyon (BDÖ)	İlaç kullanan > Kullanmayan	0.047
	İçselleştirilmiş transfobi (E)	İlaç kullanan > Kullanmayan	0.034
	Onur (F)	— Anlamli değil	0.292
	Depresyon (BDÖ)	Kullanmayan > Kullanan	0.027
Hormon kullanımı	İçselleştirilmiş transfobi (E)	— Anlamli değil	0.622
	Depresyon (BDÖ)	Desteği olmayan > Desteği olan	0.007
Aile desteği	Depresyon (BDÖ)	Partneri olmayan > Partneri olan	0.027
Partner	Depresyon (BDÖ)	Partneri olmayan > Partneri olan	0.042
Sigara	Olumsuz beklentiler (G)	Partneri olmayan > Partneri olan	0.013
	Topluluk Bağ (J)	Sigara içmeyen > Sigara içen	0.013
Birlikte yaşadığı kişi*	Ayrımcılık (A)	— Anlamli değil (küçük n nedeniyle)	—

* Birlikte yaşadığı kişi’ alt gruplarında (yalnız n=1, partner n=2) istatistiksel güç düşüktür; sonuçlar tanımlayıcıdır.

Not: $p < 0.05$ anlamlı kabul edilmiştir. ‘—’ işareti anlamlı bulunmayan ya da güvenilir analiz yapılamayan karşılaştırmaları göstermektedir.

Alt ölçeklerin kendi puan aralıkları dikkate alındığında, katılımcıların distal stres boyutlarında görece düşük, dayanıklılık boyutunda ise görece yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. Her ne kadar bu ölçek için kesme (cut-off) değerleri bulunmasa da alt boyutların maksimum puanlarına oranlandığında bu bulgular, katılımcıların azınlık stresini beklenenden daha az yaşadıklarını ve koruyucu faktörlerden daha fazla yararlandıklarını düşündürmektedir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin en az bir yıldır düzenli olarak grup psikoterapisine devam etmeleri göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun grup temelli müdahalelerin dayanıklılığı artırıcı ve stresle baş etmede güçlendirici rolü ile ilişkili olabileceği klinik gözlem düzeyinde yorumlanabilir. Ancak, bu etkinin doğrudan ölçülmediği göz önünde bulundurulmalı ve bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Dayanıklılık boyutunun (Topluluk Bağ) görece yüksek oluşu, katılımcıların azınlık stresine karşı koruyucu faktörlere sahip olabileceğini ve stresörlere rağmen başa çıkma kapasitelerinin güçlü olabileceğini düşündürmektedir.

Bu bulgular, grup terapilerinin dayanıklılığı güçlendirici bir rol oynadığını desteklemektedir. Grup temelli psiko-eğitimlerin bireylerin farkındalığını artırarak içselleştirilmiş transfobiyi azalttığı, sosyal bağları güçlendirdiği ve psikolojik esnekliği artırdığı desteklenmiştir.

Kuramsal olarak değerlendirildiğinde, bu bulgular “azınlık stresi → dayanıklılık → ruh sağlığı” zincirinin kültürel bağlamda da geçerli olduğunu göstermektedir. Türkiye gibi kolektivist kültürlerde sosyal destek ve topluluk bağlılığı, bireysel dayanıklılığın merkezinde yer almakta ve bu nedenle dayanıklılık modellerinin kültürel uyarlamalarını gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle örneklem büyüklüğü görece küçüktür ve bazı alt gruplarda (örneğin yalnız veya partner ile yaşayanlar) katılımcı sayıları oldukça düşüktür; bu durum post-hoc analizlerin gücünü sınırlar. Ayrıca kesitsel tasarım nedeniyle nedensellik ilişkisi kurulamaz. Grup psikoterapilerinin olası katkıları bu çalışmada doğrudan ölçülmemiştir; bu nedenle bu yorumlar gözlemsel düzeyde ele alınmalı ve bulguların doğrulanması için ileriye dönük, daha büyük örneklemli ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Bulgular, azınlık stresini etkileyen çok sayıda faktörün bulunduğunu göstermekte; ancak bu çalışmada tüm olası etkenler (ör. sosyal medya kullanımı, sağlık hizmetlerine erişim) değerlendirilememiştir. Ek olarak, nitel verilerin dahil edildiği karma yöntemli çalışmalar, grup terapilerinin sürece dair öznel etkilerini daha iyi aydınlatılabilir.

4. SONUÇLAR

Elde edilen bulgular, toplumsal cinsiyet azınlıklarının ruh sağlığının yalnızca bireysel değil, sosyodemografik ve klinik değişkenlerle de yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Cinsiyet kimliği, çalışma durumu, psikiyatrik tanı, ilaç kullanımı, hormon tedavisi, aile desteği ve partner durumu gibi değişkenlerin depresyon, anksiyete ve azınlık stresi düzeyleri üzerinde anlamlı etkiler yarattığı bulunmuştur.

Post-hoc analizler, trans kadınların trans erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde azınlık stresi yaşadıklarını; çalışmayan, psikiyatrik tanısı bulunan, hormon tedavisi almayan, aile veya partner desteğinden yoksun bireylerde depresyon ve stres düzeylerinin belirgin biçimde arttığını ortaya koymuştur. Buna karşılık, sigara kullanmayan bireylerde daha yüksek topluluk bağı puanlarının saptanması, sağlık davranışları ile sosyal aidiyet duygusu arasındaki koruyucu ilişkiyi desteklemektedir.

Bu bulgular, toplumsal cinsiyet azınlıklarının ruh sağlığında hem risk hem de koruyucu faktörlerin bir arada işlediğini göstermektedir. Aile ve partner desteği, depresyon ve azınlık stresi puanlarıyla ilişkili bulunmuş; bu da sosyal destek mekanizmalarının ruh sağlığı üzerindeki koruyucu etkisini doğrulamaktadır. Katılımcıların dayanıklılık alt boyutlarında elde ettikleri yüksek puanlar, bireylerin maruz kaldıkları stresörlere rağmen güçlü başa çıkma becerileri geliştirdiklerini göstermektedir.

Klinik açıdan, bu bulgular sosyal destek ve psikoterapötik müdahalelerin önemini vurgulamaktadır. Kocaeli Üniversitesi Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Polikliniği'nde yürütülen grup psikoterapisi uygulamalarının, katılımcıların dayanıklılık puanlarına katkı sağlamış olabileceği düşünülmektedir. Grup terapisi süreçleri, bireylerin benzer kimlik deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştırarak içselleştirilmiş damgalanmanın etkisini azaltabilir ve azınlık stresine karşı psikososyal dayanıklılığı güçlendirebilir. Bununla birlikte, grup terapilerinin etkisi bu araştırmada doğrudan ölçülmediğinden, bu yorum klinik gözlemler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Sonuçlar, toplumsal cinsiyet azınlıklarının yalnızca günlük yaşam stresörlerinden değil, aynı zamanda kimlik temelli damgalanma, sosyal dışlanma ve yapısal eşitsizliklerden de etkilendiklerini göstermektedir. Bununla birlikte, yüksek dayanıklılık ve sosyal aidiyet düzeyleri, bu bireylerin azınlık stresine karşı koruyucu psikososyal kaynaklara sahip olabileceğini ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda, klinik uygulamalarda sadece bireysel psikiyatrik müdahalelere değil, aynı zamanda sosyal destek ağlarının güçlendirilmesine, aile ve partner ilişkilerinin desteklenmesine ve toplum düzeyinde damgalanmayı azaltıcı politikalara önem verilmelidir. Gelecekte yapılacak çalışmaların, grup terapilerinin ve sosyal dayanıklılık programlarının etkinliğini incelemesi, toplumsal cinsiyet azınlıklarının ruhsal iyilik hallerini desteklemeye yönelik bütüncül müdahale modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Baker, K. E., Wilson, L. M., Sharma, R., Dukhanin, V., McArthur, K., & Robinson, K. A. (2021). Hormone therapy, mental health, and quality of life among transgender people: a systematic review. *Journal of the Endocrine Society*, 5(4), bva011.
- Barr, S. M., Budge, S. L., & Adelson, J. L. (2016). Transgender community belongingness as a mediator between strength of transgender identity and well-being. *Journal of Counseling Psychology*, 63(1), 87–97. <https://doi.org/10.1037/cou0000127>
- Bockting, W. O., Miner, M. H., Swinburne Romine, R. E., Hamilton, A., & Coleman, E. (2013). Stigma, mental health, and resilience in an online sample of the US transgender population. *American Journal of Public Health*, 103(5), 943–951. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301241>
- Budge, S. L., Adelson, J. L., & Howard, K. A. (2013). Anxiety and depression in transgender individuals: The roles of transition status, loss, social support, and coping. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 81(3), 545–557. <https://doi.org/10.1037/a0031774>
- Budge, S. L., Tebbe, E. A., & Love, D. (2024). The development and pilot testing of a minority stress psychoeducation tool for transgender and nonbinary people. *Transgender Health*, 9(3), 275–279. <https://doi.org/10.1089/trgh.2022.0038>
- Costa, R., & Colizzi, M. (2016). The effect of cross-sex hormonal treatment on gender dysphoria individuals' mental health: A systematic review. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 12, 1953–1966. <https://doi.org/10.2147/NDT.S95310>
- Exposito-Campos, P., Pérez-Fernández, J. I., & Salaberria, K. (2023). Empirically supported affirmative psychological interventions for transgender and non-binary youth and adults: A systematic review. *Clinical Psychology Review*, 100, 102229.
- Goetz, T. G., Kishton, R., & Wolk, C. B. (2025). Integrating Psychiatric Care With Gender-Affirming Primary Care to Meet Transgender, Non-Binary, and Gender Expansive Mental Health Needs: A Pilot Study. *Journal of Primary Care & Community Health*, 16, 21501319251357728.
- Hendricks, M. L., & Testa, R. J. (2012). A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. *Professional Psychology: Research and Practice*, 43(5), 460–467. <https://doi.org/10.1037/a0029597>
- Kcomt, L., & Gorey, K. M. (2019). A systematic review of social stress and mental health among transgender and gender nonconforming people in the United States. *Clinical Psychology Review*, 73, 101–107. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2018.03.003>

- Meyer, I. H. (2015). Resilience in the study of minority stress and health of sexual and gender minorities. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 2(3), 209–213. <https://doi.org/10.1037/sgd0000132>
- Puckett, J. A., Cleary, P., Rossman, K., Mustanski, B., & Newcomb, M. E. (2018). Barriers to gender-affirming care for transgender and gender nonconforming individuals. *Sexuality Research and Social Policy*, 15(1), 48-59.
- Reisner, S. L., Poteat, T., Keatley, J., Cabral, M., Mothopeng, T., Dunham, E., Holland, C. E., Max, R., & Baral, S. D. (2016). Global health burden and needs of transgender populations: A review. *The Lancet*, 388(10042), 412–436. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00684-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00684-X)
- Şahin, A. B., Büyükgök, D., Uysal, Ö., & Kulaksızoğlu, I. B. (2023). *A preliminary validation of Gender Minority Stress and Resilience Measure in Turkish transgender individuals*. *Journal of LGBTQ Issues in Counseling*, 17(4), 271–288. <https://doi.org/10.1080/26924951.2023.2202353>

BÖLÜM 3

İlkokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri ile Annelerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi *

Zeynep Örnek² & Mustafa Özçetin³ & İsmail Yıldız⁴

*¹ Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

² Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 0000-0002-9107-6793

³ Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 0000-0003-0697-4271

⁴ Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 0000-0003-3570-8394

1. GİRİŞ

21. yüzyılın kriz ortamlarında çocukların psikolojik sağlamlıklarını artırmak, bireysel müdahalelerin ötesine geçerek aile temelli önleyici yaklaşımların önemini ortaya koymaktadır. Özellikle annelerin duygusal farkındalık ve duygularını düzenleyebilme becerileri, çocukların ruhsal dayanıklılığını artırmakta; öz düzenleme ve empati gibi sosyal-duygusal becerilerin gelişimini desteklemektedir (Yavuzer, 2021). Gelişimsel psikoloji literatürüne göre, yaşamın ikinci çocukluk dönemi olarak tanımlanan 6–12 yaş aralığı, bireyin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişiminin temellerinin atıldığı, gelişimsel görevlerin yoğun olarak yerine getirildiği kritik bir evredir (Bacanlı, 2010). Bu dönemde çocuklar; akran grupları, okul çevresi ve öğretmenler aracılığıyla sosyal rolleri öğrenir, değerler sistemi geliştirir ve benlik algısı oluşturmaya başlarlar. Ancak bu gelişimsel sürecin temelleri büyük ölçüde okul öncesi dönemde atılmaktadır. Bu erken evrede bireyin kişilik yapılanması, duygusal güvenlik hissi ve sosyal becerileri şekillenmekte; bu süreçte annenin empatik tutumu, ebeveynlik tarzı ve duygusal zekâ düzeyi kritik belirleyiciler arasında yer almaktadır (Yörükoğlu, 2011). Annenin duygusal zekâsı, çocuğun duygusal düzenleme, empati geliştirme ve sosyal ilişki kurma becerilerinde belirleyici olurken, bu alanlarda yaşanan yetersizlikler çocuğun ilerleyen dönemlerde şiddete maruz kalma ya da şiddet eğilimli davranışlar geliştirme riskini artırabilmektedir (Tsujino ve Oyama-Higa, 2007). Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO, 2002) göre şiddet, bireyin kendine, bir başkasına ya da bir topluluğa yönelik olarak kasıtlı şekilde fiziksel ya da psikolojik güç kullanması sonucu yaralanma, ölüm, gelişimsel bozulma veya yoksunlukla sonuçlanabilen davranışlar bütünüdür. Okullarda görülen şiddet, çoğunlukla “akran zorbalığı” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durum; çocukların psikolojik sağlığını, akademik başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek okul iklimini bozmakta, öğrenme ortamlarının güvenliğini tehdit etmektedir (Furlong ve Morrison, 2000). Erken dönemde bu tür riskli davranışların saptanması ve aile temelli müdahalelerle önlenmesi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ruh sağlığını korumada önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, annelerin duygusal zekâ düzeylerinin çocukların şiddet eğilimleri üzerindeki dolaylı etkilerini ortaya koymak, koruyucu ruh sağlığı politikaları geliştirmek ve toplumsal dayanıklılığı artırmak açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, çocukların en çok vakit geçirdiği kişiler olan annelerinin duygusal zeka düzeylerinin, çocukların şiddet eğilimleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmaları ve Etik Kurulu’nun 24/06/2024 tarihli ve 2606419 sayılı kararı ile etik açıdan uygun bulunmuştur. Araştırmaya katılan tüm anne ve çocuklardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

2. YÖNTEM

Bu araştırma 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan devlet ilkokullarına devam eden 3. sınıf öğrencisi 347 çocuk ve anneleri ile yürütülmüştür.

Araştırmada veri toplamak amacıyla demografik bilgiler için “Kişisel Bilgi Formu”, annelerin duygusal zeka düzeylerini belirlemek için “Duygusal Zeka Ölçeği Kısa Form” ve çocukların şiddet eğilimi düzeylerini ölçmek için “Şiddet Eğilim Ölçeği” ve çocukların duygusal zeka düzeyini ölçmek için “Çocukların için Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler nicel araştırma yaklaşımı kapsamında toplanmış ve ilişkisel tarama modeli kullanılarak analiz edilmiştir.

Verilerin analizinde SPSS 27.0 paket programı kullanılmış olup, $p<0.05$ değeri istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak esas alınmıştır. Örneklem ilişkini betimleyici istatistikler hesaplanmıştır. Gruplar arası farklılıkların incelenmesinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış, varsayımların sağlanamadığı durumlarda ise bunların non-parametrik karşılıkları olan Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

Çalışma 3. sınıf öğrencisi 347 çocuk ve anneleri ile yürütülmüştür. Öğrencilerin 169'u erkek, 178'i kız olup, cinsiyet dağılımı birbirine yakın olduğu görülmektedir. (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı

	N	%
Kız	178	51,3
Erkek	169	48,7
Toplam	347	100,0

Annelerin 206'sı (%59,4) 30-39 yaş aralığında iken, 107'si (%30,8) 40 yaş ve üstü ve 34'ü (%9,8) 18-29 yaş arasında idi (Tablo 2).

Tablo 2. Annelerin Yaş Aralıkları

	N	%
18-29 yaş	34	9,8
30-39 yaş	206	59,4
40 yaş ve üstü	107	30,8
Toplam	347	100,0

Annelerin 117'si (%33,7) lise mezunu olup, 70'i (%20,2) ilkokul mezunu, 59'u (%17,0) ortaokul mezunu, 38'i (%11,0) ön lisans mezunu, 36'ı (%10,4) lisans mezunu, 22'si (%6,3) okur-yazar ve 5'i (%1,4) lisansüstü mezunu idi (Tablo 3).

Tablo 3. Annelerin Eğitim Durumu

	n	%
Okur-yazar	22	6,3
İlkokul mezunu	70	20,2
Ortaokul mezunu	59	17,0
Lise mezunu	117	33,7
Ön lisans mezunu	38	11,0
Lisans mezunu	36	10,4
Lisansüstü mezunu	5	1,4
Toplam	347	100,0

Araştırmada veri toplamak amacıyla üç farklı ölçme aracı (Duygusal Zeka Ölçeği-Kısa Form, Çocuklar için Duygusal Zeka Ölçeği, Şiddet Eğilim Ölçeği) kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, araştırmacı tarafından hazırlanmış olup annelere ve çocuklara ait demografik özellikleri (çocuğun cinsiyeti, okul türü, annenin öğrenim durumu, annenin yaşı vb.) belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği, Petrides ve Furnham (2000, 2001) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından yapılmıştır. Yirmi maddeden ve dört alt boyuttan oluşan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.81, testtekrar test güvenilirliği ise 0.86'dır. Çocuklar için Duygusal Zeka Ölçeği, Küçükkaragöz ve Kocabaş (2012) tarafından geliştirilmiş olup 18 madde ve 4 alt boyuttan (empati, duygusal zeka, motivasyon, duyguları yönetme) oluşmaktadır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.72 olarak belirlenmiş, dörtlü Likert tipi bir yapıdadır. Şiddet Eğilim Ölçeği ise Göka, Bayat ve Türkçapar (1995) tarafından geliştirilmiş, 7-14 yaş arası çocukların şiddet eğilimlerini ölçmek üzere düzenlenmiştir. Yirmi maddelik 4'lü Likert tipi bu ölçekten alınan

puan yükseldikçe şiddet eğilimi artmakta, Cronbach alfa değeri 0.76 olarak hesaplanmıştır (Tablo 4).

Tablo 4. Ölçeklerin Cronbach's Alpha Güvenilirlik Katsayıları

	Cronbach's Alpha	Madde sayısı
Duygusal Zeka Ölçeği (Kısa form)	0,81	20
Çocuklar için Duygusal Zeka Ölçeği	0,72	18
Şiddet Eğilim Ölçeği	0,76	20

Annelerin yaş gruplarına göre duygusal zeka puanlarının farkı değerlendirildiğinde, annelerin Öz kontrol alt boyutları yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma 18-29 yaş arası ile 40 yaş ve üstü gruplar arasında ve yaşı büyük olan grubu lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum; yaş aldıkça öz kontrol becerilerinin geliştiği şeklinde yorumlanabilir (Tablo 5).

Tablo 5. Annelerin Yaş Grupları ile Öz Kontrol Alt Boyutu Post Hoc Analizi

Tukey HSD

Bağımlı Değişken			Ortalama Farkı (I-J)	Std. Hata	Sigma Değeri
Öz kontrol alt boyutu	18-29 yaş	30-39 yaş	-1,32939	0,67148	0,119
		40 yaş ve üstü	-1,96060*	0,71413	0,017*
	30-39 yaş	18-29 yaş	1,32939	0,67148	0,119
		40 yaş ve üstü	-0,63122	0,43226	0,311
	40 yaş ve üstü	18-29 yaş	1,96060*	0,71413	0,017*
		30-39 yaş	0,63122	0,43226	0,311

(p < 0.05)*

Annelerin eğitim durumlarına göre duygusal zeka puanlarının farkı değerlendirildiğinde, duygusal zeka toplam puan ve sosyallik alt boyutu boyutunda farklılaştığını (p<0.05) diğer alt boyutlarda ise anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür. Post Hoc analizine göre lisans mezunu annelerin duygusal zeka puanlarıyla okur yazar olan annelerin duygusal puanları arasındaki fark istatistiksel olarak (p<0.05) anlamlı olarak belirlenmiştir. Gruplar arasındaki ortalama farkın lisans mezunu anneler lehine olduğu görülmektedir (Tablo 6).

Tablo 6. Annelerin Eğitim Durumları ile Duygusal Zeka Puanları

Post Hoc Analizi

Bağımlı Değişken: Duygusal Zeka

Gruplar (I)	Gruplar (J)	Ortalama Farkı (I-J)	Std. Hata	Sig. Değeri
Okur yazar	İlkokul Mezunu	-1,5505	0,90803	0,611
	Ortaokul mezunu	-1,16585	0,92805	0,871
	Lise mezunu	-1,38068	0,86331	0,683
	Ön lisans mezunu	-2,12739	0,99526	0,333
	Lisans mezunu	-3,01957*	1,00535	0,045*
	Lisansüstü mezunu	-4,01818	1,84056	0,307

(p < 0.05)*

Öğrencilerin duygusal zeka empati ve duyguları yönetme alt boyut puanları cinsiyete göre anlamlı olarak (p<0.05) farklılaşmaktadır. Empati alt boyutundaki ortalamalara göre kız öğrencilerin puanları daha yüksek iken duyguları yönetme alt boyut puanlarında erkeklerin puanları kız öğrencilere göre daha yüksektir (Tablo 7).

Tablo 7. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Duygusal Zeka Puanları Arasındaki Farklılaşma için İlişkisiz Grup T Testi

Çocuğun cinsiyeti	N	Ortalama	Standart Sapma	t	Sigma Değeri
Duygusal farkındalık boyutu	Kız	178	7,0956	2,24406	1,635
	Erkek	169	6,7147	2,08692	1,638
Empati boyutu	Kız	178	9,3602	2,79983	2,475
	Erkek	169	8,5406	3,35588	2,464
Motivasyon boyutu	Kız	178	7,4181	2,06253	-0,298
	Erkek	169	7,4798	1,76600	-0,300
Duyguları yönetme boyutu	Kız	178	3,2629	2,68198	-2,576
	Erkek	169	4,0165	2,76617	-2,574
DZ Toplam	Kız	178	30,3781	7,05146	0,307
	Erkek	169	30,1299	7,98842	0,306

(p < 0.05)* DZ: Duygusal zeka

Çocukların duygusal farkındalık alt boyutundan elde ettikleri puanlar ile annelerinin öz kontrol (p < 0.01) ve sosyallik (p < 0.05) alt boyutlarından elde ettikleri puanlar arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde korelasyon tespit

edilmiştir. Katılımcı annelerin duygusal zekâ ölçeğinden elde ettikleri toplam puan ile çocuklarının empati alt boyutu puanları arasında da ($p < 0.05$) anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Katılımcı annelerin duygusal zeka iyi oluş ve sosyallik alt boyutlarından elde ettikleri puanlar ile çocukların duygusal zeka motivasyon alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0.05$) bir korelasyon görülmektedir (Tablo 8).

Tablo 8. Annelerin ve Çocuklarının Duygusal Zeka puanları Arasındaki Korelasyon analizi

		ÇDZ Duygusal farkındalık boyutu	ÇDZ Empati	ÇDZ Mo- tivasyon	ÇDZ Duyguları yönetme	ÇDZ Toplam
Anne DZ	R	0,053	0,043	,123*	-0,020	0,053
İyi oluş	Sig.	0,342	0,443	0,027*	0,717	0,344
Anne DZ	R	,144** 0,009**	0,105	0,042	-0,054	0,095
Öz kontrol	Sig.		0,059	0,456	0,331	0,090
Anne DZ	R	0,077	0,091	0,021	0,020	0,105
Duygusallık	Sig.	0,164	0,100	0,707	0,723	0,060
Anne DZ	R	,121*	0,089	,123*	-0,001	0,109
Sosyallik	Sig.	0,030*	0,109	0,028*	0,980	0,051
Anne DZ	R	0,053	,127*	0,080	-0,031	0,093
Toplam	Sig.	0,337	0,023*	0,150	0,574	0,097

($p < 0.05$)* DZ: Duygusal zeka, ÇDZ: Çocuk duygusal zeka

Öğrencilerin şiddet eğilim ölçeği ile elde ettikleri puanlar cinsiyet değişkenine göre erkek öğrenciler lehine yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0.05$) bulunmuştur (Tablo 9).

Tablo 9. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Şiddet Eğilim Puanları Arasındaki Farklılaşma için İlişkisiz Grup T Testi

Çocuğun cinsiyeti		N	Ortalama	Standart Sapma	T
Şiddet Eğilim Ölçeği	Kız	178	35,6144	-2,871	0,004**
	Erkek	169	38,3395	-2,870	

($p < 0.05$)*

Annelerin duygusal zekası ile 3. sınıfa giden çocuklarının şiddet eğilimleri arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmış, duygusal zekâ ve alt boyutlarının şiddet eğilimi ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır

(Tablo 10). Bu bulgular, örneklem grubuna özgü olabilir ve başka çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilebilir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda örneklem sayısı artırılarak ya da farklı veri toplama araçları kullanılarak daha güçlü ilişkiler test edilebilir.

Tablo 10. Annelerin Duygusal Zekası ile Çocuklarının Şiddet Eğilim Puanları Arasındaki Korelasyon

		Şiddet Eğilim Ölçeği
İyi oluş alt boyutu	R	-0,006
	Sig.	0,912
	N	347
Öz kontrol alt boyutu	R	0,002
	Sig.	0,967
	N	347
Duygusallık alt boyutu	R	0,044
	Sig.	0,414
	N	347
Sosyallik alt boyutu	R	-0,012
	Sig.	0,822
	N	347
Duygusal zeka alt boyutu	R	-0,041
	Sig.	0,450
	N	347

(p < 0.05)*

4. TARTIŞMA

Bu araştırmada, annelerin duygusal zekâ düzeyleri ile çocuklarının şiddet eğilimleri arasında doğrudan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu sonuç, ebeveyn duygusal zekâsının çocuk davranışları üzerindeki etkisinin dolaylı ve çok katmanlı bir yapı sergilediğini göstermektedir. Nitekim Çelik, Gençoğlu ve Kumcağız (2016) tarafından yapılan çalışmada da, ergenlerin şiddet eğilimlerinde duygusal zekânın etkisi dolaylı olarak açıklanmakta ve araya giren değişkenlerin (akran etkisi, okul ortamı vb.) rolü vurgulanmaktadır.

Çalışmada, annelerin yaşları arttıkça öz kontrol düzeylerinin de arttığı bulunmuştur. Bu bulgu, literatürdeki “yaşla birlikte duygusal olgunlaşma

artar” görüşü ile örtüşmektedir Ghiță (2023). Özellikle öz düzenleme gibi duygusal bileşenlerin yaşa bağlı gelişimi, çocukların sosyal öğrenme süreçlerinde model alma davranışını da etkileyebilir (Güney, 2019).

Araştırmada, cinsiyet faktörü hem duygusal zekâ hem de şiddet eğilimlerinde anlamlı farklılıklara yol açmıştır. Kız çocuklarının empati düzeylerinin daha yüksek olması, duygusal zekânın sosyal bileşenleri açısından toplumsal cinsiyet rollerinin etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu bulgu, Pektane Gülmez ve ark. (2019) çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Erkek çocuklarda daha yüksek şiddet eğilimleri ve duygu yönetimi skorları, Furlong ve Morrison (2000) tarafından ifade edilen toplumsal normların, özellikle erkek çocuklarda saldırgan davranışı ödüllendiren yapısına işaret etmektedir.

Buna ek olarak, annelerin bazı duygusal zekâ alt boyutları ile çocuklarının empati ve motivasyon gibi duygusal bileşenleri arasında düşük düzeyde fakat anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgular, Gunindi (2013) ve Kellam (2013) çalışmalarında da vurgulandığı gibi, duygusal zekâ gelişiminde ev ortamının kalitesi ve ebeveyn-çocuk etkileşimlerinin önemine işaret etmektedir.

Araştırmanın sınırlılıkları göz önünde bulundurulduğunda, örneklem grubu yalnızca İstanbul/Fatih ilçesiyle sınırlıdır. Bu durum, elde edilen sonuçların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Ayrıca, verilerin yalnızca anket formlarıyla toplanması, davranışsal gözlemleri dışarda bırakmıştır. Gelecek araştırmalarda nitel veri toplama yöntemleri ve daha geniş örneklem grupları kullanılarak daha derinlemesine analizler yapılması önerilmektedir.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmanın sonuçları, annelerin duygusal zekâ düzeyleri ile çocukların şiddet eğilimleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. Ancak duygusal zekânın bazı alt boyutları ile çocukların empati ve motivasyon düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu durum, çocukların sosyal-duygusal gelişiminde ebeveynin özellikle anne figürünün rolünün önemli ancak tek başına belirleyici olmadığını göstermektedir.

Çocukların şiddet eğilimlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında farklılaştığı; erkek çocukların şiddet eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve bu çocukların duygu düzenleme becerilerinde de anlamlı farklılıklar gözlemlendiği tespit edilmiştir. Bu

durum, **toplumsal normlar, çevresel faktörler ve okul ortamının** etkisini vurgulamaktadır.

Araştırmanın genel bulguları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir:

1. **Aile temelli duygusal eğitim programları**, özellikle annelerin öz düzenleme ve duygusal farkındalık becerilerini geliştirmeye yönelik olarak yaygınlaştırılmalıdır.
2. **Okullarda sosyal-duygusal öğrenme müfredatı**, duygusal zekâyı destekleyen içeriklerle güçlendirilmelidir.
3. **Toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı yaklaşımlar**, çocukların empati ve çatışma çözme becerilerini cinsiyet ayrımı yapmaksızın geliştirmelidir.
4. **Psiko-sosyal risk faktörleri** dikkate alınarak, çocukların bulunduğu çevreye özgü müdahale programları tasarlanmalıdır.

Sonuç olarak, duygusal zekâ çocukların gelişiminde önemli bir değişken olmakla birlikte, şiddet davranışlarının ortaya çıkışında çok boyutlu faktörlerin etkili olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu bağlamda, sadece ebeveynin değil; okul, medya ve sosyal çevre gibi unsurların da dahil edildiği çok paydaşlı politikalar geliştirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Aslanyürek, D., & Demircioğlu, H. (2024). Ergenlerin saldırgan davranışlarının incelenmesi. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences*, 57(3), 1053–1098. <https://doi.org/10.30964/auebfd.1438451>
- Bacanlı, H. (2010). *Eğitim psikolojisi*. Pegem Akademi.
- Bingöl, T. Y., & Erkek, Z. Y. (2020). Duygusal zekâ ve şiddet. *Meyad Akademi*, 1(2), 165–181.
- Brand, S., & Felner, R. D. (1996). Perceived ecological congruence across family/school environments: Implications for children's adjustment. *Journal of Community Psychology*, 24(2), 160–174. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-)
- Çelik, S., Gençoğlu, C., & Kumcağız, H. (2016). Ergenlerde şiddet eğiliminin yordayıcısı olarak duygusal zekâ. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(3), 121–134.
- Çomaklı, M., & Koçyiğit, S. (2021). *Primary school adaptation problems of children: Parental experiences and practices*. Biruni University Institutional Repository. [https://openaccess.biruni.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12445/2955/document%20\(29\).pdf](https://openaccess.biruni.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12445/2955/document%20(29).pdf)
- Cowan, P. A., Cowan, C. P., Ablow, J. C., Johnson, V. K., & Measelle, J. R. (2005). Family factors in children's adaptation to elementary school: Five-domain model. In *The family context of parenting in children's adaptation to elementary school* (pp. 221–246). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410612885-9>
- Dakal, C., & Ertem, H. Y. (2025). İlkokul öğretmenlerine göre akran zorbalığı ve çözüm yolları. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 13(2), 102–120. <https://dergipark.org.tr/en/pub/kebd/issue/92944/1576333>
- Deniz, M. E., Özer, E., & Işık, E. (2013). Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Short Form: Validity and reliability studies. *Education and Science*, 38(169), 407–419.
- Dilnozakhon, A., & Dilduza, J. (2023). *Problems of adaptation of children of primary school age to school and methods of their elimination*. Tashkent State University. https://tsuull.uz/sites/default/files/maqola_02._23_0.pdf
- Ezgin, M. A., & Akoğlu, B. (2023). Genç erişkin bireylerde algılanan ebeveyn tutumları ile duygusal zekâ ve öfke kontrolü arasındaki ilişki. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 199–213.
- Furlong, M., & Morrison, G. (2000). The school in school violence: Definitions and facts. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 8(2), 71–82. <https://doi.org/10.1177/106342660000800203>

- Ghiță, R. C. (2023). Parental influence on children's social and emotional intelligence: A gender-differentiated analysis. *Journal of Contemporary Approaches in Psychology and Psychotherapy*, 1(1), 33–47. <https://doi.org/10.57017/jcapp.v1.i1.03>
- Göka, E., Bayat, B., & Türkçapar, M. H. (1995). *Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık ve şiddet eğilimleri* [Araştırma raporu]. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Gunindi, Y. (2013). An evaluation of social adaptation skills of children with and without preschool education background based on their mothers' views. *Online Submission*, 3(2), 80–90.
- Güney, M. (2019). *60–72 ay okul öncesi dönem çocukların sosyal duygusal uyumu ile annelerinin duygusal zekâları arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi].
- Hogeveen, J., Salvi, C., & Grafman, J. (2016). Emotional intelligence: Lessons from lesions. *Trends in Neurosciences*, 39(10), 694–705. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2016.08.007>
- Hoglund, W. L. G., & Leadbeater, B. J. (2004). The effects of family, school, and classroom ecologies on changes in children's social competence and emotional and behavioral problems in first grade. *Developmental Psychology*, 40(4), 533–544.
- Hoşgörür, V., & Orhan, A. (2017). Okulda zorbalık ve şiddetin nedenleri ve önlenmesinin yönetimi (Muğla merkez ilçe örneği). *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(24), 859–880.
- Kellam, S. G. (2013). The social adaptation of children in classrooms: Family childrearing effectiveness. In T. P. Gullotta & G. M. Blau (Eds.), *Family influences on childhood behavior and development* (pp. 135–152). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203772737-7>
- Küçükkaragöz, H., & Kocabaş, A. (2012). Çocuklar için Duygusal Zekâ Ölçeğinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. *11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu*, Rize.
- Oymak, A., Karakuş, İ. Ö., & Şahin, E. K. (2024). İlkokul öğrencilerine teknoloji destekli akran zorbalığı bilinci kazandırma ve önleme. *Akyurt Bilim ve Sanat Merkezi Değerler Eğitimi Bildirisi*, 34–38.
- Pektane Gülmez, A., Gültekin Akduman, G., & Gündüz, A. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının annelerinin duygusal zekâ düzeyleri ile çocuklarının akran zorbalığı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of International Social Research*, 12(64), 611–618.

- Rehman, R., Tariq, S., & Tariq, S. (2021). Emotional intelligence and academic performance of students. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 71(12), 2777–2781. <https://doi.org/10.47391/JPMA.1779>
- Semiz, S., & Lindberg, E. (2022). Investigation of peer bullying in early years on the basis of emotional intelligence and family variables. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 37(2), 390–402.
- Seven, S. (2010). Attachment and social behaviors in the period of transition from preschool to first grade. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 38(3), 347–356.
- Shrivastava, S., Martinez, J., Coletti, D. J., & Fornari, A. (2022). Interprofessional leadership development: Role of emotional intelligence and communication skills training. *MedEdPORTAL*, 18, 11247. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.11247
- Sroufe, L. A., Egeland, B., & Kreutzer, T. (1990). The fate of early experience following developmental change: Longitudinal approaches to individual adaptation in childhood. *Child Development*, 61(5), 1363–1373. <https://doi.org/10.2307/1130748>
- Tsujino, J., & Oyama-Higa, M. (2007). The relationship between emotional intelligence of mothers and problem behavior in their young children: A longitudinal analysis. *Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health*, 21(3), 215–230.
- Uyaroğlu, B. (2011). *Üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren ilköğretim öğrencilerinin empati becerileri ve duygusal zekâ düzeyleri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>
- Yavuzer, H. (2021). *Çocuk psikolojisi* (45. baskı). Remzi Kitabevi.
- Yıldız, D. (2024). *İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin algılanan anne baba tutumları ve çatışma çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. <https://acikerisim.uludag.edu.tr/items/4550298f-37944f4d-968a-7cb5a48a19d2>
- Yörükoğlu, A. (2011). *Çocuk ruh sağlığı: Çocuk yetiştirme sanatı ve kişilik gelişimi*. Özgür Yayınları.
- Zupančič, M., & Kavčič, T. (2011). Factors of social adjustment to school: Child's personality, family, and preschool. *Early Child Development and Care*, 181(3), 345–359. <https://doi.org/10.1080/03004430903507175>

BÖLÜM 4

Postpartum Depresyonda Telepsikiyatrinin Etkinliği: Yüz Yüze Taramalarla Karşılaştırmalı Bir Çalışma*

**Fatma Seher Kocaayan² & İlay Dalkıran³ &
Nezihe Gül⁴ & Mehtap Güngör⁵ & Elif Tatlıdil⁶ &
Aslıhan Polat⁷**

*¹ Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

² Dr.Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli, Türkiye, 0009-0001-7183-2002

³ Dr.Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli, Türkiye, 0009-0009-6433-2681

⁴ Dr.Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli, Türkiye, 0009-0008-6554-7054

⁵ Psikiyatri Hemşiresi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli, Türkiye, 0009-0007-4441-8918

⁶ Prof. Dr, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli, Türkiye, 0000-0002-1157-7409

⁷ Prof. Dr, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli, Türkiye, 0000-0001-9649-8701

1. GİRİŞ

Postpartum depresyon (PPD), doğum sonrası dönemde anne ruh sağlığını derinden etkileyen ve küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen yaygın bir depresif bozukluktur. Dünya genelinde yaklaşık her 5 kadından 1'i doğumdan sonraki ilk yıl içinde PPD deneyimlemektedir (Wang et al., 2021). Türkiye'de yapılan sistematik derlemeler, PPD prevalansının yaklaşık %24 olduğunu; bu oranın büyük şehirlerde %21 civarında seyrederken kırsal bölgelerde %25'e kadar çıkabildiğini göstermektedir (Keser Özcan et al., 2017).

PPD, yalnızca yüksek görülme sıklığıyla değil, aynı zamanda anne ve bebek üzerindeki çok boyutlu olumsuz sonuçlarıyla da dikkat çeker. Tedavi edilmediği takdirde anne-bebek bağlanmasını zayıflatabilir, çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebilir ve ciddi vakalarda anne intiharına kadar varabilen sonuçlar doğurabilir (Goodman et al., 2016). Bu risklere rağmen PPD genellikle tanınmamakta; birçok ülkede vakaların yarısından fazlası tedavi almamaktadır (Bodnar-Deren et al., 2017; Smith et al., 2019).

Annelerin profesyonel yardım arayışını kısıtlayan temel faktörler arasında damgalanma korkusu, toplumsal beklentiler ve yapısal engeller yer almaktadır. Anneliğin "mutlu ve güçlü" olunması gereken bir dönem olduğuna dair kültürel inançlar, kadınların depresif duygularını gizlemelerine neden olabilmektedir (Smith et al., 2019). Ayrıca, kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve rutin doğum sonrası kontrollerde ruh sağlığı değerlendirmesine yeterli zaman ayrılamaması gibi sistemik sorunlar tedavi açığını büyütmektedir (Bodnar-Deren et al., 2017).

Bu bağlamda telepsikiyatri ve dijital sağlık uygulamaları, son yıllarda umut verici bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Uzaktan iletişim araçlarıyla psikiyatrik değerlendirme ve terapi hizmeti sunulması, özellikle ulaşım sorunu, bakım yükü veya damgalanma endişesi yaşayan anneler için önemli avantajlar sağlamaktadır. Güncel meta-analizler, telepsikiyatri tabanlı psikososyal müdahalelerin PPD belirtilerini ve anksiyeteyi anlamlı düzeyde azalttığını göstermektedir (Zhao et al., 2021). Dahası, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDÖ) gibi tarama araçlarının çevrimiçi uygulanması, anonimlik sağlayarak kadınların belirtilerini daha açık ifade etmelerine olanak tanımaktadır (Eisner et al., 2022; van den Heuvel et al., 2018).

Bu çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılında yayınladığı ve doğum sonrası depresyon risk değerlendirmesini bir kalite göstergesi olarak belirlediği direktif bağlamında, telepsikiyatrinin PPD taramalarındaki etkinliğini geleneksel yüz yüze yöntemlerle karşılaştırarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Deseni ve Örneklem

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda yürütülen bu retrospektif ve karşılaştırmalı çalışma, uygulanan veri toplama stratejisine ve hasta profiline göre iki farklı dönemi kapsamaktadır. Ocak–Mart 2024 tarihleri arasındaki ilk dönemde oluşturulan "Yüz Yüze-Poliklinik Grubu", hastanenin polikliniklerine rutin kontrol veya herhangi bir şikayet nedeniyle başvuran postpartum dönemdeki kadınlardan oluşmaktadır. Bu grupta veri toplama süreci poliklinik ortamında yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, tarama sonucunda depresyon riski saptanan hastalara (EPDÖ puanı ≥ 13) durum bildirilmesine rağmen, psikiyatrik başvuru süreci tamamen hastanın kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Buna karşılık, Ocak–Mart 2025 dönemini kapsayan "Telepsikiyatri Grubu", veri toplama stratejisindeki değişikliği yansıtacak şekilde iki aşamalı bir süreçle yönetilmiştir. Bu gruptaki katılımcıların sosyodemografik ve iletişim bilgileri, doğum sonrası ilk üç gün içinde henüz serviste yatışları devam ederken yüz yüze görüşülerek kayıt altına alınmıştır. Sürecin devamında, postpartum birinci ayda bu annelerle görüntülü görüşme (telepsikiyatri) sağlanarak tarama yapılmış ve bu grupta risk saptanan tüm vakalar, araştırmacılar tarafından aktif bir yaklaşımla psikiyatrik takibe yönlendirilerek randevu süreçleri bizzat organize edilmiştir.

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırma verilerinin elde edilmesi sürecinde araştırmacıların geliştirdiği sosyodemografik ve klinik özellikleri sorgulayan bilgi formu ve Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği olmak üzere iki temel araç kullanılmıştır.

2.2.1. Sosyodemografik ve Klinik Bilgi Formu

Katılımcılara ilişkin sosyodemografik nitelikleri ve tanıtıcı bilgileri saptamak üzere araştırmacılarca hazırlanan bu veri toplama formu, doğum sonrası ilk üç gün içinde yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Form; katılımcının yaşı, eğitim durumu, mesleği, medeni durumu ve gelir düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlerin yanı sıra; obstetrik öyküsü, mevcut doğumun özellikleri, kişisel psikiyatri öyküsü ve genel sağlık durumu gibi klinik bilgileri içeren sorulardan oluşmaktadır.

2.2.2. Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ)

Çalışmada PPD riskini ve şiddetini belirlemek üzere, Cox ve arkadaşları (1987) kaynaklı ve Engindeniz ve arkadaşları (1996) tarafından Türkçeye kazandırılan ölçek tercih edilmiştir. Öz-bildirim esasına dayalı, 10 soruluk ve 0-3 puanlı Likert tipi bir yapıya sahip olan bu araçta, maddelerin puanlanması soru yönelimine göre değişmektedir. Buna göre 1, 2 ve 4. maddeler artan , diğer maddeler ise azalan şekilde puanlanır. Ölçekten elde edilebilecek maksimum skor

30 olup, bu araştırmada 13 ve üzeri puan alan anneler depresyon riski altında değerlendirilmiştir.

2.3. Verilerin İstatistiksel Analizi

Veri analizi sürecinde IBM SPSS 29.0 paket programından faydalanılmıştır. Değişkenlerin dağılım özellikleri incelendiğinde verilerin normal dağılıma uyduğu saptanmıştır. Bu nedenle verilerin sunumunda ortalama ve standart sapma değerleri esas alınmış; nitel veriler ise sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde Ki-kare analizi ve parametrik testler tercih edilmiş olup, p değerinin 0.05'ten küçük olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Telesikiyatri Grubunun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Çalışmanın telesikiyatri grubunu oluşturan 62 annenin yaş ortalaması 29.1 ± 5.9 yıl olarak saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu evli (%95.2) olup, eğitim düzeyleri incelendiğinde %56.5'inin lise, %29.0'unun üniversite mezunu olduğu görülmüştür. Ekonomik durum algısı katılımcıların %58.1'i tarafından "orta", %37.1'i tarafından "iyi" olarak belirtilmiş; çalışma durumu sorgulandığında ise %80.6'sının çalışmadığı tespit edilmiştir.

Obstetrik ve klinik özellikler değerlendirildiğinde; katılımcıların %37.1'inin ilk gebeliği olduğu, %71.0'inin doğumunu sezaryen ile gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Sosyal destek mekanizmaları açısından katılımcıların %74.2'si aile desteğine sahip olduğunu bildirmiş, %51.6'sı eşiyle olan ilişkisini "çok iyi" olarak tanımlamıştır. Tıbbi ve psikiyatrik öykü incelendiğinde; annelerin %29.0'unun kronik bir hastalığı olduğu, %14.5'inin geçmişte psikiyatrik bir hastalık öyküsü bulunduğu görülmüştür. Sigara kullanım oranı %24.2 iken, alkol kullanımı %1.6 düzeyinde kalmıştır. Grubun detaylı sosyodemografik ve klinik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Telesikiyatri Grubunun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri (n=62)

Değişken	Kategori		
Yaş	Ortalama $\pm$ SS	29.1 ± 5.9	—
		n	%
Medeni Durum	Evli	59	95.2
	Dini nikâhlı	1	1.6
	Bekâr	2	3.2
Eğitim Düzeyi	İlkokul	9	14.5
	Lise	35	56.5
	Üniversite	18	29.0
Sosyal Güvence	Var	57	91.9
	Yok	5	8.1
Ekonomik Durum	Yüksek	23	37.1
	Orta	36	58.1
	Düşük	3	4.8

Çalışma Durumu	Çalışmıyor	50	80.6
	Çalışıyor	12	19.4
Gebelik Sayısı	1. gebelik	23	37.1
	2. gebelik	21	33.9
	3. gebelik	13	21.0
	4 ve üzeri	5	8.0
Doğum Şekli	Sezaryen	44	71.0
	Vajinal	18	29.0
Doğumda Komplikasyon	Yok	56	90.3
	Var	6	9.7
Bebek Cinsiyeti	Erkek	33	53.2
	Kız	29	46.8
Eşin Eğitim Düzeyi	İlkokul	8	12.9
	Lise	42	67.7
	Üniversite	12	19.4
Eşin Çalışma Durumu	Çalışıyor	55	88.7
	Çalışmıyor	7	11.3
Aile Desteği	Var	46	74.2
	Yok	16	25.8
Eşle İlişki Düzeyi	Çok iyi	32	51.6
	İyi	22	35.5
	Orta	6	9.7
	Kötü	2	3.2
Kronik Hastalık	Yok	44	71.0
	Var	18	29.0
Gebelikte Sağlık Sorunu	Yok	46	74.2
	Var	16	25.8
Psikiyatrik Hastalık Öyküsü	Yok	53	85.5
	Var	9	14.5
Sigara Kullanımı	Hayır	47	75.8
	Evet	15	24.2
Alkol Kullanımı	Hayır	61	98.4
	Evet	1	1.6

3.2. Yüz Yüze ve Telepsikiyatri Tarama Sonuçlarının Karşılaştırılması

Çalışmanın temel amacı doğrultusunda, 2024 (yüz yüze/poliklinik) ve 2025 (telepsikiyatri) dönemlerine ait tarama ve depresyon saptanma oranları karşılaştırılmıştır (Tablo 2).

2024 döneminde (Ocak-Mart) gerçekleşen toplam 181 doğumdan sadece 17 anneye (%9.4) poliklinik şartlarında yüz yüze EPDS uygulanabilmektedir. Bu grupta taranan annelerin 4'ünde (%23.5) depresyon riski ($EPDS \geq 13$) saptanmış, ancak bu annelerin hiçbirisi (%0) psikiyatrik tedaviye başvurmamıştır.

Buna karşın, 2025 döneminde (Ocak-Mart) gerçekleşen 128 doğumdan, doğum sonrası serviste iletişim bilgileri alınan 62 anneye (%48.4) telepsikiyatri yoluyla ulaşılmıştır. Bu grupta 12 annede (%19.4) depresyon riski saptanmış ve riskli grubun tamamı (%100) araştırmacılar tarafından organize edilerek psikiyatrik takibe alınmıştır.

İstatistiki analizler sonucunda, telepsikiyatri yönteminin tarama oranını yüz yüze yönetime göre anlamlı düzeyde artırdığı bulunmuştur (%9.4'e karşı %48.4; $\chi^2 = 58.03$, $p < 0.001$). Taranan gruplar içindeki depresyon saptanma oranları karşılaştırıldığında ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (%23.5'e karşı %19.4; $p = 0.969$).

Tablo 2. 2024 ve 2025 Yıllarının Doğum, Taramaya Katılım ve Depresyon Oranlarının Karşılaştırılması

Değişken	2024	2025	p değeri
Toplam doğum sayısı	181	128	—
Taramaya katılım oranı (%)	9.4	48.4	< 0.001
Depresyon oranı (%)	23.5	19.4	0.969

4. TARTIŞMA

PPD, anne ve bebek sağlığında yol açtığı kalıcı ve uzun süreli sonuçlar sebebiyle, dünya genelinde kritik bir halk sağlığı meselesi olarak güncelliğini korumaktadır. Wang ve arkadaşlarının (2021) 80 ülke ve 565 çalışmayı kapsayan meta-analizinde PPD'nin küresel prevalansı %17,2 olarak bildirilmiştir (Wang et al. , 2021). Türkiye'de yürütülen ve 52 çalışmanın dahil edildiği ulusal meta-analizde ise oran %23,8'e yükselmektedir (Keser Özcan et al., 2017). Çalışmamızda telepsikiyatri yöntemiyle değerlendirilen annelerde depresyon sıklığının %19,4 olarak saptanması hem küresel hem ulusal verilerle genel olarak uyumludur. Türkiye ortalamasından daha düşük bir oran bulunması, telepsikiyatrinin yalnızca ağır vakaları değil, topluluğu temsil eden daha geniş bir popülasyonu kapsayabilen bir tarama modeli olduğuna işaret etmektedir.

Örneklemimizin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde, depresyon riskini artırdığı bilinen faktörlerin önemli ölçüde bir arada bulunduğu görülmektedir. Katılımcıların %71'i lise ve altı eğitim düzeyine sahiptir; ekonomik durum çoğunlukla orta ve düşük düzeyde olup maddi açıdan zorluk yaşayan bir grup olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi düşük bireylerde sağlık okuryazarlığının azalması ve yardım arama davranışının gecikmesi literatürde sıkça vurgulanan risk etmenleridir (Cooke et al., 2025; Waqas et al., 2023). Benzer şekilde ekonomik güçlüklerin ebeveynlik stresini artırarak depresyona yatkınlığı yükselttiği bilinmektedir (Dadi et al., 2020). Ayrıca örneklemin yaklaşık üçte birinde (%29) kronik hastalık bulunması, fiziksel yükün psikolojik dayanıklılığı azalttığını gösteren çalışmalarla uyumludur (Brown et al., 2018).

PPD'nin yaygınlığına karşın tanı ve tedavi oranlarının düşük olmasında en kritik engeller damgalanma korkusu, toplumsal baskılar ve sağlık hizmetine erişim güçlükleridir. Annelik döneminin doğal olarak “mutlu” geçmesi gerektiğine dair toplumsal beklenti, depresyon yaşayan kadınlarda suçluluk

duygusunu derinleştirerek yardım arama davranışını azaltmaktadır (Bodnar-Deren et al., 2017). Ayrıca ulaşım sorunları, ekonomik güçlükler ve çocuk bakımı gibi yapısal engeller özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetine erişimi zorlaştırmaktadır (Smith et al., 2019). Bu nedenlerle yüz yüze poliklinik görüşmeleri, yeni annelerin ihtiyaç duydukları psikolojik desteğe ulaşmalarında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Buna karşın telepsikiyatri modeli, bireylerin kendi ev ortamında gizlilik ve konfor içinde değerlendirilmesini sağlayarak hem damgalanmayı azaltmakta hem de erişilebilirliği artırmaktadır.

Çalışmamızın en dikkat çekici bulgularından biri, telepsikiyatri protokolüne geçişle birlikte tarama oranlarında gözlenen belirgin artıştır. Yüz yüze yöntemde yalnızca %9,4 olan tarama oranı, telepsikiyatri ile %48,4'e yükselmiştir. Bu bulgu, Arias ve arkadaşlarının (2022) postpartum dönemde teletıp uygulamalarının tarama oranlarını %65'ten %86'ya çıkardığını gösteren çalışmasıyla paralellik göstermektedir (Arias et al., 2022). Langan ve Goodbred (2016), gelişmekte olan ülkelerde PPD'nin çoğunlukla tanı alamadığını vurgulamış; telepsikiyatri uygulamalarının tarama kapsamını genişleterek gizli kalmış vakaların açığa çıkmasına katkı sağladığını belirtmiştir (Langan & Goodbred, 2016). Bizim çalışmamızda da telepsikiyatrinin sunduğu erişilebilirlik, depresyon riskinin popülasyon içinde daha doğru ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

Telepsikiyatri yalnızca tarama oranlarını artırmakla kalmamış, aynı zamanda riskli annelerin tedaviye yönlendirilmesini de belirgin şekilde iyileştirmiştir. Yüz yüze görüşme döneminde depresyon riski saptanan hiçbir anne herhangi bir psikiyatrik takibe başvurmamışken, telepsikiyatri grubunda riskli olarak değerlendirilen annelerin tamamı psikiyatrik izleme alınmıştır. Bu bulgu, dijital sağlık müdahalelerinin hasta katılımını ve tedaviye uyumu artırdığını gösteren meta-analizlerle uyumludur (Ashford et al., 2016; Hanach et al., 2021). O'Mahen ve arkadaşları, teknoloji destekli bakım modellerinin özellikle yeni annelerde tedaviye başlama oranlarını anlamlı derecede artırdığını bildirmiştir (O'Mahen et al., 2014). Ek olarak tele-sağlık uygulamalarının annelik öz-yeterlilik düzeyini olumlu yönde etkileyerek ebeveynlik becerilerini güçlendirdiği gösterilmiştir (Zhang et al., 2023; Zhao et al., 2021).

Çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Retrospektif karşılaştırmalı tasarım, telepsikiyatri müdahalesinin uzun dönemli klinik iyileşme sonuçları (örneğin remisyon oranları) üzerinde nedensel çıkarımlar yapmayı kısıtlamaktadır. Ayrıca çalışmanın tek merkezde yürütülmesi, farklı sosyokültürel veya altyapısal özelliklere sahip bölgelere genellenebilirliği sınırlayabilir. Gelecek araştırmalarda telepsikiyatri ile tedaviye yönlendirilen annelerin uzun dönem iyilik hâli, tedavi uyumu ve maternal-bebek ilişkisindeki değişimlerin değerlendirilmesi önerilebilir.

Sonuç olarak, elde edilen bulgular telepsikiyatrinin postpartum depresyonun erken tanı ve tedavi süreçlerinde yüz yüze yöntemlere kıyasla daha etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşım sunduğunu göstermektedir. Van den Heuvel ve arkadaşlarının (2018) belirttiği gibi, e-Sağlık uygulamaları perinatal bakımın yeni nesil standardını oluşturma potansiyeline sahiptir (Van den Heuvel et al., 2018). Bu nedenle telepsikiyatrinin rutin sağlık hizmetlerine entegrasyonu, hem ülke çapında tarama oranlarının artırılmasına hem de riskli annelerin zamanında tedaviye yönlendirilmesine stratejik katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Arias, R. P., Richter, S. L., & Cheng, L. E. (2022). Evaluation of telemedicine for postpartum depression screening during the COVID-19 pandemic. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 51(4), 384–391. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2022.02.005>
- Ashford, M. T., Olander, E. K., & Ayers, S. (2016). Computer- or web-based interventions for perinatal mental health: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 197, 25–46. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.02.057>
- Bodnar-Deren, S., Benn, E. K. T., Balbierz, A., & Howell, E. A. (2017). Stigma and postpartum depression treatment acceptability among black and white women in the first six-months postpartum. *Maternal and Child Health Journal*, 21(7), 1457–1468. <https://doi.org/10.1007/s10995-017-2263-6>
- Brown, H. K., Qazilbash, A., Rahim, N., Dennis, C.-L., & Vigod, S. N. (2018). Chronic medical conditions and peripartum mental illness: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Epidemiology*, 187(9), 2060–2068. <https://doi.org/10.1093/aje/kwy105>
- Cooke, A., Nasiri, N., Jayakumar, S. A., & Rangrej, S. B. (2025). A systematic review of the effect of socioeconomic status on the prevalence of postpartum depression (PPD). *International Journal of Psychology*, 60(4), e70063.
- Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *The British Journal of Psychiatry*, 150(6), 782–786. <https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782>
- Dadi, A. F., Akalu, T. Y., Baraki, A. G., & Wolde, H. F. (2020). Epidemiology of postnatal depression and its associated factors in Africa: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*, 15(4), e0231940. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231940>
- Eisner, E., Lewis, S., Stockton-Powdrell, C., Agass, R., Whelan, P., & Tower, C. (2022). Digital screening for postnatal depression: Mixed methods proof-of-concept study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 429. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04756-2>
- Engindeniz, A. N., Küey, L., & Kültür, S. (1996). Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Bahar Sempozyumları I. Kitabı*, 51-52.
- Goodman, J. H., Watson, G. R., & Stubbs, B. (2016). Anxiety disorders in postpartum women: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 203, 292–331. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.05.033>
- Hanach, N., Sanchez, A., & Ahmed, M. (2021). The effectiveness of telemedicine interventions for the treatment of postpartum depression: A systematic

- review and meta-analysis. *Telemedicine and e-Health*, 27(10), 1085–1097. <https://doi.org/10.1089/tmj.2020.0326>
- Keser Özcan, N., Boyacıoğlu, N. E., & Dinç, H. (2017). Postpartum depression prevalence and risk factors in Turkey: A systematic review and meta-analysis. *Archives of Psychiatric Nursing*, 31(5), 420–428. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2015.12.003>
- Langan, R. C., & Goodbred, A. J. (2016). Identification and management of peripartum depression. *American Family Physician*, 93(10), 852–858.
- O'Mahen, H. A., Richards, D. A., Woodford, J., Wilkinson, E., McGinley, J., Taylor, R. S., & Warren, F. C. (2014). Netmums: A phase II randomized controlled trial of a guided Internet behavioural activation treatment for postpartum depression. *Psychological Medicine*, 44(8), 1675–1689. <https://doi.org/10.1017/S0033291713002092>
- Smith, M. S., Lawrence, V., Sadler, E., & Easter, A. (2019). Barriers to accessing mental health services for women with perinatal mental illness: Systematic review and meta-synthesis of qualitative studies in the UK. *BMJ Open*, 9(1), e024803. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024803>
- van den Heuvel, J. F. M., Groenhouf, T. K., Veerbeek, J. H. W., van Solinge, W. W., Lely, A. T., Franx, A., & Bekker, M. N. (2018). eHealth as the next-generation perinatal care: An overview of the literature. *Journal of Medical Internet Research*, 20(6), e202. <https://doi.org/10.2196/jmir.9262>
- Wang, Z., Liu, J., Shuai, H., Cai, Z., Fu, X., Liu, Y., Li, Z., Zhang, Y., Geng, R., Chen, J., & Li, H. (2021). Mapping global prevalence of depression among postpartum women. *Translational Psychiatry*, 11(1), 543. <https://doi.org/10.1038/s41398-021-01663-6>
- Waqas, A., Nadeem, M., & Rahman, A. (2023). Exploring heterogeneity in perinatal depression: A comprehensive review. *BMC Psychiatry*, 23(1), 643. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05143-x>
- Zhang, Y., Zhu, J., Li, S., Huang, L., Fang, Q., & Zheng, X. (2023). The effectiveness of an internet-based support program on maternal self-efficacy, postpartum depression and social support for primiparous women during the COVID-19 pandemic: Randomized controlled trial. *Frontiers in Public Health*, 11, 1035872.
- Zhao, L., Chen, J., Lan, L., Deng, N., Liao, Y., Yue, L., Chen, I., Wen, S. W., & Xie, R. (2021). Effectiveness of telehealth interventions for women with postpartum depression: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 9(10), e32544. <https://doi.org/10.2196/32544>

BÖLÜM 5

Nefes Egzersizlerinin Bağımlılık Tedavisinde Nörolojik Fizyolojik ve Ruhsal Boyutları*

Penbe Nur Görgülü²

*¹ Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

² Ergoterapist, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın, Türkiye, ORCID: 0009-0006-0362-9818

1. GİRİŞ

Bağımlılık, ülke çapında özellikle genç nüfusu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olup; biyolojik, psikolojik ve davranışsal boyutlarıyla çok yönlü bir hastalık niteliği taşımaktadır. Bu nedenle klasik tedavi yöntemlerinin yanı sıra tamamlayıcı müdahalelere duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Literatür, farkındalık temelli müdahalelerin stresle başa çıkma, nüksü önleme ve beden farkındalığını artırmada etkili olduğunu göstermektedir (Bates vd., 2019; Zaccaro vd., 2018). Ancak bağımlılıkla mücadele yalnızca fizyolojik belirtilerin kontrol altına alınmasından ibaret değildir; ruhsal sağlığın yeniden onarılması da sürecin kritik bir parçasıdır. Bu onarım, duygu düzenleme kapasitesinin geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi gibi çok boyutlu parametreleri içermektedir. (Paulus vd., 2013)

2. YÖNTEM

Nefes egzersizleri, meditasyon temelli müdahaleler ve bağımlılık bağlamındaki klinik araştırmaları kapsayan güncel literatür incelenmiştir. Çalışmalarda kalp hızı değişkenliği (HRV), barorefleks duyarlılığı, kortizol düzeyleri, EEG ve fMRI ölçümleri kullanılmıştır (Streeter vd., 2010; Paulus vd., 2013; Ünlü vd., 2023).

3. BULGULAR VE YORUM

3.1 Fizyolojik Etkiler

3.1.1 Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler

Madde kullanımını bırakmak, bireyde yoğun bir stres süreci başlatır. Bu sürecin fizyolojik yansımaları arasında kalp hızında ve kan basıncında artış yer alır. Ancak nefes egzersizleri ve yoga gibi gevşeme tekniklerinin uygulanmasıyla, stres hormonları olan kortizol ve Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) düzeylerinde anlamlı azalma sağlanabildiği gösterilmiştir (Ünlü vd., 2023; Streeter vd., 2010). Bu doğrultuda, nefes egzersizleri kalp-damar sisteminin regülasyonuna katkı sunar.

Özellikle dakikada 6 nefes hızında (0,1 Hz) gerçekleştirilen rezonans frekanslı nefes alma, tipik nefes hızına göre (dakikada 12–20 nefes) daha yavaş ve düzenlidir. Bu ritmik solunum, sistolik kan basıncını düşürmekte ve vasküler tonusta iyileşmeler meydana getirmektedir. Ayrıca hızlandırılmış nefes alma uygulamaları, kaygı ve stres düzeylerinde kayda değer düşüşlere neden olur. Bates vd. (2019) yaptığı çalışmada, beş dakika süren rezonans solunum egzersizi sonrasında kalp atış hızı, vasküler tonus, barorefleks duyarlılığı ve sistolik arter basıncı gibi fizyolojik parametrelerde olumlu değişiklikler gözlemlenmiştir.

Buna ek olarak, rezonans tarzı nefes alma egzersizi yalnızca ventilatuvar aşırılığın önüne geçmekle kalmaz; aynı zamanda kalp atış hızı, kan basıncı ve

solunum kontrol devrelerinin senkronizasyonuna da katkı sağlar (Zaccaro vd., 2018).

3.1.2 Solunum hızı ve stres hormonu regülasyonu

Nefes egzersizlerinin etkisi yalnızca kardiyovasküler sistemle sınırlı değildir. Derin ve yavaş nefes alma çalışmaları, rahatlatıcı ve sakinleştirici etkiler yaratırken; hızlı ve tekrarlı nefesler, aksine bireyde uyarılmışlık ve anksiyete düzeyini etkiler. Bu nedenle, alınan nefesin ardından verilen nefesin yavaş ve düşük yoğunlukta olması, gevşeme yanıtını destekler. Uzun süredir meditasyon uygulamalarında benimsenen bu ritmik solunum düzeni, günümüzde psikoterapi ve stres yönetim programlarında da kullanılmaktadır (Gilbert, 2014).

Solunumun hem istemli hem de otonom sistemler tarafından kontrol edilmesi, sinir sistemine doğrudan etki edebilmesini mümkün kılar. Bu bağlamda “derin nefes al” önerisi, anksiyete ve akut stres gibi durumlarda rahatlatıcı etki oluşturabilir. Ancak bu sürecin etkili olabilmesi için nefes verme sürecinin de yavaş ve kontrollü olması önemlidir. Aksi takdirde, hızlı ve tekrarlı soluk verme hiperventilasyon riskini artırır. Bu durum, kanda aşırı karbondioksit kaybına ve dolayısıyla pH seviyesinin alkali yöne kaymasına neden olur. Bu fizyolojik değişiklikler sonucunda kalsiyum seviyesinin düşmesiyle birlikte sinir ve kas hücrelerinin uyarılabilirliği artar; baş dönmesi, kas krampları ve huzursuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir (Gilbert, 2014; Zaccaro vd., 2018).

Yavaş ve ritmik nefes egzersizleri ise vagus siniri aracılığıyla parasempatik sinir sistemini aktive eder. Bu etki, HPA (hipotalamus-hipofiz-adrenal) eksenini üzerinden kortizol salınımını düzenleyerek stres tepkisinin dengelenmesini sağlar. Meditasyonda geleneksel uygulamalar olan mantra ve pranayama gibi teknikler, solunumun nörofizyolojik etkilerine dayalıdır. Güncel çalışmalar, en az beş dakika süren bu uygulamaların stres hormonlarını anlamlı ölçüde azalttığını ve bireyin psikolojik dayanıklılığını artırdığını ortaya koymuştur (Fincham vd., 2023; Liang vd., 2023).

Özellikle dakikada altı nefes hızında yapılan yavaş solunum egzersizlerinin, oksijen saturasyonunu artırdığı, bilişsel performansı desteklediği, stres yönetimini kolaylaştırdığı ve ruhsal sağlığı desteklediği ifade edilmektedir. Bu yönüyle, nefes egzersizleri uygulanabilir, ölçeklenebilir ve bilimsel temellere dayanan etkili bir yaklaşımdır (Bentley vd., 2023).

4.1 Nörolojik Etkiler

4.1.1 EEG ve beyin dalgaları

Yavaş nefes almanın otonom ve merkezi sinir sistemini etkilediği yukarıda belirtilmiştir. Nefes teknikleri kalp hızında değişikliğe ve solunum sinüs aritmisi artmış parasempatik aktivasyonun bir yansımasıdır; bununla bağlantılı olarak otonom sinir sistemindeki bu değişim, merkezi sinir sistemi üzerinde de etki gösterir. EEG çalışmalarında, özellikle alfa güçte artış ve teta güçte azalma

bulgularını elde edilmiştir. Mevcut fMRI çalışmaları ise kortikal ve subkortikal alanların aktivasyonunda artışı göstermektedir (Zaccaro vd., 2018). Buna ek olarak, EEG ve NIRS (Yakın Kızılötesi Spektroskopi) kullanılan çalışmalarda da alfa aktivitesinin ve frontal oksijenasyonda artışın gözlemlendiği bildirilmiştir. Kalp hızındaki artışın, afferent vagus siniri ile prefrontal korteks arasındaki bağlantılar üzerinden beyin aktivitesini düzenlediği öne sürülmektedir (Yu vd., 2011). Solunum sistemi yalnızca periferik bir işlev değil, aynı zamanda nöronal aktivitenin doğrudan modülatörü olarak da rol oynayabilir. Nefes almanın etkisi yalnızca akciğerlerle sınırlı kalmaz; beyindeki hücreleri doğrudan etkileyebilir. Özellikle burundan alınan nefesin, koku alma yolları üzerinden beyin genelinde geniş bir alanı etkilediği ortaya konmuştur. Bu süreçte beyinde 40–100 Hz frekans aralığında gama dalgalarında artış gözlenmiştir (Zelano vd., 2016).

Hayvan modelleri üzerinden elde edilen veriler, solunumun otonom sinir sistemi yoluyla merkezi sinir sistemi ağları üzerinde düzenleyici bir etki oluşturabildiğini ortaya koymaktadır. Vagal aracılı bu düzenleyici mekanizmaların, kortikal ve subkortikal düzeydeki nöral ağlarda değişimlere yol açarak öğrenme ve bellekle ilişkili süreçlerle bağlantılı olabileceği ifade edilmektedir (Iseger vd., 2020).

Nefes egzersizlerinin nörobiyolojik etkisi özellikle bağımlılık davranışları çerçevesinde de araştırılmıştır. Örneğin, nikotin bağımlısı bireylerde sigarayla ilgili görsel uyaranlara maruziyet sonrası insula bölgesinde gelişmiş bir aktivite gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, esrar kullanan bireylerde insuladaki kan akışı ve fMRI sinyallerinde artış bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada ise amfetamin kullanan bireylerde karar alma süreçlerinde insula aktivitesindeki düşüşün, nüksetme riskiyle ilişkili olduğu saptanmıştır.

Bu bulgular doğrultusunda, nefese odaklanan farkındalık temelli uygulamaların stres seviyelerini düşürdüğü ve dikkat süresini artırdığı gözlemlenmiştir. Anatomik olarak bakıldığında, özellikle insula, anterior singulat korteks (ACC) ve prefrontal kortekste meydana gelen yapısal değişimlerin, nefes odaklı dikkat çalışmalarıyla (örneğin meditasyon) ilişkili olduğu yönünde güçlü kanıtlar edilmiştir. Deneyimli meditasyon yapan bireylerde, ön insulada gri madde yoğunluğunun arttığı; bunun ağrıyı daha iyi işleme, engelleyici kontrolün gelişimi ve interoseptif dikkatin artışı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, arka insula ve dorsomedial prefrontal korteks arasında değişen fonksiyonel bağlantıların da bu süreçle koopere olduğu ileri sürülmektedir.

Tüm bu etkiler bir arada değerlendirildiğinde, farkındalık temelli yaklaşımların nüksetme riskini azaltabileceğine dair bulgular elde edilmiştir. Alkol ve madde kullanan bireylerde yardımcı tedavi olarak uygulanan bu yöntemlerin, madde kullanım oranlarını düşürdüğü ve istem düzeyinde azalma sağladığı gösterilmiştir (Paulus vd., 2013).

Benzer şekilde, beş dakikalık ritmik nefes egzersiziyle uygulanan rezonans solunumunun da beyin kapasitesine olan etkisi araştırılmıştır. Katılımcılar rezonans nefes çalışmasına katılırken, kontrol grubuna daha basit solunum yöntemleri uygulanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası yapılan fMRI ölçümlerine göre, rezonans nefes uygulayan grubun medial prefrontal korteks, singulat ve precuneus bölgelerinde aktivite artışı tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise bu tür değişimlere rastlanmamıştır. Bu sonuçlar, rezonans solunumunun zihinsel kontrol kapasitesini güçlendirebileceğini göstermektedir (Bates vd., 2019).

4.1.2 Beyin plastisitesi

Nöroplastisite çerçevesinde, alkol bağımlısı bireylerin uzun süreli alkol yoksunluğu sonrasında nöronal rejenerasyon olduğu gösterilmiştir. Bu bulgu, kronik alkol kullanımına bağlı olarak gelişen frontal lob hasarının geri döndürülebilir olabileceğini ve alkol bırakımı sonrasında bilişsel performansta iyileşme sağlanabileceğini desteklemektedir (Schneider vd., 1993).

Önceki çalışmalar, insula korteksinde meydana gelen yapısal ve işlevsel değişimlerin ağrı işleme ve amigdala aracılığıyla duygusal entegrasyon süreçlerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Özellikle anterior insulada gözlenen gri madde yoğunluğundaki artışın, interoseptif farkındalığın güçlenmesiyle ilişkili olduğu bildirilmektedir. Buna ek olarak, posterior insula ile dorsomedial prefrontal korteks arasındaki fonksiyonel bağlantılarda saptanan değişimlerin, duygusal ve bilişsel düzenleme süreçlerine katkı sağladığı belirtilmektedir. Bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, nefes farkındalığına dayalı uygulamaların insula merkezli sinir ağları ile diğer kortikal bölgeler arasındaki bağlantı bütünlüğünü artırarak beyin ağlarının daha etkin bir şekilde düzenlenmesine katkıda bulunabileceği göstermektedir (Paulus vd., 2013). Meditasyon ise zihinsel ve duygusal süreçlerin nörodavranışsal enerjiyle uyumlu hale getirilmesini sağlayan bir araç olarak öne çıkar. Açık izleme ve odaklanmış dikkat olmak üzere iki temel yaklaşımı içeren meditasyon uygulamaları, zaman ve hafıza algısından bağımsız bir varoluş deneyimi oluşturur. Nörogörüntüleme bulguları, meditasyonun varsayılan mod ağı (Default Mode Network - DMN) üzerinde hem yapısal hem de işlevsel değişimlere yol açtığını göstermektedir. DMN; prefrontal, parietal ve temporal korteksler ile ön singulat korteks, amigdala ve hipokampus gibi bölgeleri içerir. Meditasyon, bu ağın dikkat ve öz farkındalıkla ilişkili merkezlerle olan bağlantılarını güçlendirmekte, aynı zamanda somatosensöriyel işlemeyi artırarak limbik sistemin duygusal tepkilerini azaltmıştır. Bu sonuçlar, meditasyonun hem zihinsel işlevlerde hem de duygu düzenlemede bütünsel ve olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir (Khanna ve Greeson, 2013).

4.1.3 Nörotransmitter aktiviteleri

Nefes egzersizleriyle birlikte yürütülen yoga müdahaleleri, ruh hali ve kaygı düzeyleri üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Bu bağlamda yürütülen bir çalışmada, yoga uygulamaları ile metabolik yürüyüş egzersizi karşılaştırılmış ve yoga yapan bireylerde ruh hali ile kaygı düzeyinde daha belirgin iyileşmeler tespit edilmiştir. Bu bulgular, talamik GABA düzeyindeki artış ile ilişkilendirilmiştir. Akut süreçte talamik GABA dağılımında ortaya çıkan değişikliklerin, duygudurumun daha dengeli hale gelmesiyle eş zamanlı olarak kaygı düzeylerinde azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Streeter vd., 2010).

Bu etkiler, beynin nörokimyasal düzenlenmesiyle yakından ilişkilidir. Dopaminin, beynin ödül devrelerinde merkezi bir işlev üstlendiği ve bağımlılık yapıcı maddelerin pekiştirici etkilerinde temel rol oynadığı bilinmektedir. Kronik madde kullanımının, dopamin D2 reseptörlerinin aşağı düzenlenmesiyle ödül işleme süreçlerinde bozulmaya yol açtığı bildirilmektedir. Yoga uygulamalarına odaklanan nörogörüntüleme çalışmalarında ise ödül, motivasyon ve öz-düzenleme ile ilişkili beyin bölgelerinde yapısal değişiklikler saptanmıştır. Düzenli yoga pratiği yapan bireylerde superior frontal girus, orbitofrontal korteks ve precuneus bölgelerinde gri madde hacminde artış gözlemlendiği rapor edilmiştir. Bu bulgular, yoga temelli uygulamaların madde kullanım bozukluklarında etkilenen ödül ilişkili nöral devrelerin yeniden düzenlenmesine katkı sağlayabileceğini göstermektedir (Singh, 2024).

Nefes egzersizlerinin nörofizyolojik etkileri ise daha doğrudan bir mekanizma ile açıklanabilir. Nefes alma süreci, kortikal ve beyin sapı merkezleri tarafından hem istemli (motor ve somatosensoryel korteks) hem de istemsiz (dorsal ve ventral solunum grupları) yollarla düzenlenir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, solunum ritminin beynin uyarılma düzeylerini doğrudan etkilediğini ortaya koymuştur. Yavaş ve kontrollü nefes alma, merkezi sinir sisteminin uyarılmasını azaltarak sakinlik ve rahatlama hissini artırırken; hızlı ve yüzeysel nefes alma, kaygı ve stres düzeylerinde artışa neden olmaktadır (Fincham vd., 2023).

Bu sinirsel süreçlerin dengesini bozabilecek en önemli faktörlerden biri ise bağımlılık yapan maddelerdir. Kokain, metamfetamin gibi maddeler, hızla kana karışarak sinir yolları aracılığıyla beynin doğal ödül sistemine etki eder ve nörokimyasal dengede sapmalara neden olur. Bu durum, sempatik sinir sisteminin hiperaktivitesi ile birleşerek dopamin seviyelerinde ani ve yoğun bir artışa ve bunun sonucunda ‘savaş ya da kaç’ yanıtının tetiklenmesine yol açar. Süreç, stres ve kaygının yönetimini güçleştirir. Bununla birlikte, solunuma dayalı öz-düzenleme uygulamalarının fizyolojik stres yanıtlarını azaltarak otonom dengeyi destekleyebildiği ve bireyin stres altında bozulan nörofizyolojik dengenin yeniden sağlanmasına katkı sunabileceği gösterilmiştir (Ma vd., 2017).

5.1 Klinik uygulamalar ve rehabilitasyonda kullanımı

Bu fizyolojik ve nörolojik etkiler, klinik uygulamalar açısından da belirgin bir önem taşımaktadır. Stresin birey üzerindeki yansımaları; kas gerginliğinde artış, kalp hızının yükselmesi, gastrointestinal problemler ve olumsuz duyulanım değişiklikleri ile kendini göstermektedir. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerde ise stres, olumsuz duyulanım ve yoksunlukla ilişkili rahatsızlıklarla birlikte ortaya çıkarak nüksetme riskini artıran temel etkenlerden biri haline gelmektedir. Bu nedenle stres düzenlemesini hedefleyen klinik yaklaşımların, bağımlılık tedavisinde merkezi bir rol üstlendiği görülmektedir (Khanna ve Greeson, 2013).

Bu bağlamda, egzersiz uygulamalarının madde bağımlılığı tedavisinde hem fizyolojik hem de psikolojik düzeyde etkili bir yöntem olarak değerlendirildiği görülmektedir. Düzenli fiziksel aktivitenin, bireylerde öz-yeterlilik algısını güçlendirdiği, sosyal etkileşimi artırdığı ve genel iyilik hâlini desteklediği bildirilmektedir. Nikotin, kokain, metamfetamin, opioidler ve alkol gibi farklı maddelere bağlı bağımlılıklarda egzersizin nörofizyolojik düzeyde olumlu etkiler sağladığı rapor edilmiştir. Egzersizin, bağımlılıkla ilişkili dopaminerjik sistemdeki dengesizlikleri düzenleyerek madde kullanımını azaltabileceği ve nüks riskini düşürebileceği ifade edilmektedir (Ünlü vd., 2023).

4.SONUÇLAR

Bu derleme kapsamında ele alınan bulgular, nefes egzersizlerinin bağımlılık tedavisinde tamamlayıcı bir müdahale olarak çok boyutlu yönünü ele almaktadır. Yavaş ve kontrollü solunum uygulamalarının otonom sinir sistemi dengesini destekleyerek stres yanıtını azalttığı, yoksunluk dönemine eşlik eden fizyolojik ve duygusal zorlanmaların yönetilmesine katkı sağladığı görülmektedir (Streeter vd., 2010; Ma vd., 2017). Ayrıca nefes farkındalığına dayalı yaklaşımların, dopamin ve GABA gibi nörokimyasal sistemler üzerinde düzenleyici etkiler oluşturarak bağımlılığın ödül ve kaygı eksenli nörobiyolojik mekanizmalarına doğrudan etki edebildiği anlaşılmaktadır (Khanna ve Greeson, 2013; Singh, 2024). Bu süreçte duygu düzenleme ve dürtü kontrolünün güçlenmesi, tetikleyici durumlarla başa çıkma kapasitesini artırmaktadır (Paulus vd., 2013; Zelano vd., 2016). Literatür, nefes egzersizlerinin farmakolojik ve psikoterapötik yaklaşımları destekleyen, güvenli, düşük maliyetli ve uygulanabilir bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye bağlamında sınırlı sayıda çalışma bulunmakla birlikte, mevcut bulgular bu müdahalelerin klinik rehabilitasyon süreçlerine entegre edilebileceğine işaret etmekte ve ilerleyen araştırmalar için önemli bir temel oluşturmaktadır (Bates vd., 2019; Zaccaro vd., 2018; Ünlü vd., 2023).

5.TARTIŞMA

Nefes egzersizlerinin bağımlılık tedavisindeki fizyolojik, nörolojik ve psikolojik etkileri üzerine yapılan çalışmalar, bu tekniklerin stres yanıtını hafifletmekten beyin ödül devrelerini modüle etmeye uzanan geniş bir etki yelpazesine sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle yavaş ve derin nefes alma pratiklerinin otonom sinir sistemi üzerinde parasempatik baskınlığı artırdığı, böylece stres fizyolojisini düzenlediği saptanmıştır (Ma vd., 2017; Fincham vd., 2023). Bu durum, nefes egzersizlerinin vücudun “savaş-kaç” tepkisini azaltarak gevşeme tepkisi oluşturduğunu göstermektedir (Ünlü vd., 2023; Singh, 2024). Bunun yanı sıra dakikada altı nefes solunum uygulamalarının barorefleks duyarlılığını ve vagal tonu güçlendirdiği, bunun da anksiyete ve fizyolojik uyarılma düzeylerini azalttığı bildirilmiştir (Bates vd., 2019). Bu çalışmalar, nefes tekniklerinin stres azaltıcı etkisinde tutarlıdır: Yavaş tempolu solunum, sempatik aktiviteyi düşürüp parasempatik sinyalleşmeyi artırarak hem bedende hem zihinde rahatlama sağlamaktadır (Zaccaro vd., 2018; Bentley vd., 2023).

Nefes egzersizlerinin duygu düzenleme ve anksiyete azaltımı üzerindeki etkileri de birçok araştırmada vurgulanmaktadır. Düzenli nefes çalışması, anksiyete ve depresif duygu durumlarının regülasyonunun yanında, aynı zamanda duygusal tepkilerin daha iyi kontrol edilebilmesini destekler (Khanna ve Greeson, 2013; Fincham vd., 2023). Fincham vd. (2023) meta-analizinde, farklı nefes egzersizi müdahaleleri sonucunda yetişkinlerde kaygının anlamlı derecede azaldığı gösterilmiştir. Benzer şekilde, sağlıklı bireylerle yapılan kontrollü çalışmalarda da yavaş ritimli nefesin öfke, gerginlik, kafa karışıklığı ve üzüntü gibi olumsuz duygu durumlarını azalttığı, buna karşın dinginlik ve olumlu benlik algısını pekiştirdiği bulunmuştur (Yu vd., 2011; Gilbert, 2014; Fincham vd., 2023). Bu psikolojik iyileşmeler, nefes tekniklerinin duygusal beyin yapıları üzerindeki doğrudan etkileriyle de ilişkilidir. Nitekim Zelano vd. (2016) çalışması, burundan alınan nefesin limbik sistemde (özellikle amigdala ve hipokampüste) elektriksel aktiviteyi senkronize ettiğini ortaya koymuştur. Düzenli nefes egzersizleri ile kazanılan farkındalık ve kontrol, bağımlı bireylerde sık görülen duygudurum dalgalanmalarını ve dürtüsel tepki verme eğilimlerini azaltabilir (Paulus vd., 2013; Khanna ve Greeson, 2013). İnteroseptif farkındalığı artıran meditasyon temelli nefes çalışmaları, insula ve prefrontal korteks etkileşimini düzenleyerek kişinin iç uyaranlarına karşı toleransını ve duygusal dayanıklılığını güçlendirmektedir (Paulus vd., 2013). Bu sayede stres ve kriz anlarında sakin kalabilme becerisi, bağımlılık döngüsünü kırmada kritik olan duygu düzenleme kapasitesini destekler (Paulus vd., 2013; Singh, 2024).

Nörolojik açıdan bakıldığında, nefes egzersizleri hem beyin aktivitesinde hem de nörotransmitter sistemlerde ölçülebilir değişimler yaratmaktadır. Elektroensefalografi (EEG) ve görüntüleme çalışmaları, yavaş nefes alma tekniklerinin serebral aktiviteyi daha sakin ve dengeli bir duruma geçirdiğini

göstermektedir. Örneğin, sağlıklı bireylerde 10 dakikalık yavaş solunum sonrasında EEG’de alfa dalgalarının belirgin şekilde arttığı, teta dalgalarının ise azaldığı rapor edilmiştir (Yu vd., 2011; Zaccaro vd., 2018). Alfa dalgasındaki artış, beynin uyanık ve rahat bir hâle geçtiğini, kişinin farkındalığının artabileceğini göstermektedir.

Nefes egzersizlerinin nörotransmitter sistemler üzerindeki etkileri, bağımlılık tedavisi bağlamında önemli rol oynamaktadır. Bağımlılık, beyindeki ödül ve haz devrelerinin bozulması ile ilişkilidir. Uzun süre madde kullanımı, dopamin reseptörlerinde azalmaya ve stres sisteminde aşırı duyarlılığa yol açarak kişinin doğal ödüllere tepkisini azaltır (Singh, 2024). Bu bağlamda yoga ve meditasyon gibi nefes odaklı pratiklerin dopamin sistemini yeniden dengelemede etkili olabileceği ileri sürülmektedir. Meditasyon sırasında striatum bölgesinde endojen dopamin salınımında anlamlı artış saptanmış; bu artışın bağımlılıkta görülen ödül yetmezliği sendromunu tersine çevirmeye katkı sağlayabileceği belirtilmiştir (Singh, 2024). Bu tür bulgular, düzenli nefes ve meditasyon pratiklerinin dopaminerjik sistemi normalize ederek madde isteğini ve nüksetme riskini azaltabileceğini göstermektedir (Paulus vd., 2013; Singh, 2024). Literatürdeki incelemeler, yoga ve nefes odaklı meditasyonların vagal siniri uyarak beynin GABA aktivitesini artırabileceğini ve bunun da madde yoksunluğuna eşlik eden gerginlik ve huzursuzluk gibi semptomları hafifletebileceğini öne sürmektedir (Khanna ve Greeson, 2013; Iseger vd., 2020). Sonuç olarak dopamin ve GABA sistemleri üzerindeki bu düzenleyici etkiler, nefes egzersizlerinin bağımlılığın hem ödül mekanizmalarına hem de stres ve anksiyete mekanizmalarına eşzamanlı etki edebildiğini göstermektedir (Streeter vd., 2010; Singh, 2024).

İlgili çalışmalar karşılaştırmalı olarak ele alındığında, metodolojik farklılıklara rağmen nefes egzersizlerinin bağımlılık tedavisinde tamamlayıcı bir müdahale olarak tutarlı biçimde olumlu etkiler sunduğu görülmektedir. Kısa süreli uygulamalara odaklanan araştırmalar, rezonans frekanslı nefes egzersizlerinin anksiyete düzeylerini düşürdüğünü ve maddeyle ilişkili uyarılara verilen nöral tepkileri azalttığını göstermiştir (Bates vd., 2019; Iseger vd., 2020). Uzun süreli müdahaleleri inceleyen çalışmalar, düzenli nefes ve farkındalık temelli uygulamaların beyin kimyasında, öznel iyilik hâlinde ve duygu düzenleme kapasitesinde iyileşmeler sağladığını bildirmektedir (Streeter vd., 2010; Khanna ve Greeson, 2013). Yavaş ve düzenli solunum protokollerinin (dakikada 4–6 nefes) daha öngörülebilir ve güvenli etkiler sunduğu; buna karşılık hızlı ya da kesintili solunum tekniklerinin yeterli yönlendirme olmaksızın uygulandığında geçici fizyolojik rahatsızlıklar ve artmış anksiyete ile ilişkili olabildiği belirtilmektedir (Fincham vd., 2023). Bu bulgular, nefes çalışmalarında bireyin uygulamaya uyum süreci ve profesyonel yönlendirmenin önemini vurgulamaktadır (Bentley vd., 2023). Literatür, düzenli ve rehber eşliğinde uygulanan nefes egzersizlerinin stres düzenleme, bilişsel kontrol ve ödül

sisteminin dengelenmesi üzerinde çok boyutlu kazanımlar sağladığını ortaya koymaktadır (Ünlü vd., 2023).

KAYNAKÇA

- Bates, M. E., Lesnewich, L. M., Uhouse, S. G., Gohel, S., & Buckman, J. F. (2019). Resonance-paced breathing alters neural response to visual cues: Proof-of-concept for a neuroscience-informed adjunct to addiction treatments. *Frontiers in Psychiatry*, 10, 624. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00624>
- Bentley, T. G. K., D'Andrea-Penna, G., Rakic, M., Arce, N., LaFaille, M., Berman, R., Cooley, K., & Sprimont, P. (2023). Breathing practices for stress and anxiety reduction: conceptual framework of implementation guidelines based on a systematic review of the published literature. *Brain Sciences*, 13(12), 1612. <https://doi.org/10.3390/brainsci13121612>
- Fincham, G. W., Strauss, C., Montero-Marin, J., & Cavanagh, K. (2023). Effect of breathwork on stress and mental health: A meta-analysis of randomised-controlled trials. *Scientific Reports*, 13(1), 432. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-27247-y>
- Gilbert, C. (2014). The clinical handbook of biofeedback: a step-by-step guide for training and practice with mindfulness. Z. Khazan, PhD, BCB (2013), Chichester, UK: John Wiley & Sons. Biofeedback içinde, 42(3), 130-132. <https://doi.org/10.5298/1081-5937-42.3.05>
- Iseger, T. A., Van Bueren, N. E. R., Kenemans, J. L., Gevirtz, R., & Arns, M. (2020). A frontal-vagal network theory for major depressive disorder: Implications for optimizing neuromodulation techniques. *Brain Stimulation*, 13(1), 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.brs.2019.10.006>
- Liang, W.-M., Xiao, J., Ren, F.-F., Chen, Z.-S., Li, C.-R., Bai, Z.-M., & Rukšenas, O. (2023). Acute effect of breathing exercises on muscle tension and executive function under psychological stress. *Frontiers in Psychology*, 14, 1155134. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1155134>
- Ma, X., Yue, Z.-Q., Gong, Z.-Q., Zhang, H., Duan, N.-Y., Shi, Y.-T., Wei, G.-X., & Li, Y.-F. (2017). The effect of diaphragmatic breathing on attention, negative affect and stress in healthy adults. *Frontiers in Psychology*, 8, 874. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00874>
- Paulus, M. P., Stewart, J. L., & Haase, L. (2013). Treatment approaches for interoceptive dysfunctions in drug addiction. *Frontiers in Psychiatry*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2013.00137>
- Schneider, F., Elbert, T., Heimann, H., Welker, A., Stetter, F., Mattes, R., Birbaumer, N., & Mann, K. (1993). Self-regulation of slow cortical potentials in psychiatric patients: alcohol dependency. *Biofeedback and self-regulation*, 18(1), 23-32.
- Singh, N. (2024). Neurobiological basis for the application of yoga in drug addiction. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1373866. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1373866>

- Streeter, C. C., Whitfield, T. H., Owen, L., Rein, T., Karri, S. K., Yakhkind, A., Perlmutter, R., Prescott, A., Renshaw, P. F., Ciraulo, D. A., & Jensen, J. E. (2010). Effects of yoga versus walking on mood, anxiety, and brain GABA levels: A Randomized controlled MRS study. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 16(11), 1145-1152. <https://doi.org/10.1089/acm.2010.0007>
- Surbhi Khanna, Jeffrey M. Greeson, A narrative review of yoga and mindfulness as complementary therapies for addiction. *Complementary Therapies in Medicine*, Volume 21, Issue 3, 2013, Pages 244-252,
- Ünlü, İ. E., Doğan, O., & Keser, İ. (2023). Egzersizin nikotin, kokain, metamfetamin, opioidler ve alkol gibi madde bağımlılıklarındaki yeri. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 8(1), 70-78. <https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1190904>
- Yu, X., Fumoto, M., Nakatani, Y., Sekiyama, T., Kikuchi, H., Seki, Y., et al. (2011). *Activation of the anterior prefrontal cortex and serotonergic system is associated with improvements in mood and EEG changes induced by Zen meditation practice in novices. International Journal of Psychophysiology*, 80(2), 103–111. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2011.02.004>
- Zaccaro, A., Piarulli, A., Laurino, M., Garbella, E., Menicucci, D., Neri, B., & Gemignani, A. (2018). How breath-control can change your life: a systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, 353. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00353>
- Zelano, C., Jiang, H., Zhou, G., Arora, N., Schuele, S., Rosenow, J., & Gottfried, J. A. (2016). *Nasal respiration entrains human limbic oscillations and modulates cognitive function. Journal of Neuroscience*, 36(49), 12448–12467. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2586-16.2016>

BÖLÜM 6

21. Yüzyılın Sessiz Krizi: Sigara Bağımlılığına Grup Terapisiyle Müdahale Deneyimi*

**İsmail Emre Ak² & Narmin İsayeva³ &
Bahadır Geniş⁴**

*¹ Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

² Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye,
Orcid:0009-0003-4510-0013

³ Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye,
Orcid:0009-0001-8119-5975

⁴ Doçent Doktor, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye,
Orcid:0000-0001-8541-7670

1. GİRİŞ

Tütün kullanım bozukluğu, dünya genelinde yaklaşık olarak 1,3 milyar kişiyi etkileyen ve önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sigara bağımlılığını düzenli olarak günde en az bir adet sigara içme şeklinde tanımlamakta ve sigara kullanımını tüm dünyada en hızlı yayılan ve en uzun süre devam eden bir salgın olarak göstermektedir (Güven, 2019). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı 5. baskısında (DSM-5) sigara bağımlılığı “Tütünle İlişkili Bozukluklar” olarak ayrı bir başlık olarak sınıflandırılmıştır (APA, 2013). Bu bağlamda tütün kullanım bozukluğu tanısı, DSM-5’e göre son 12 ay içinde aşağıdaki belirtilerden en az ikisinin gözlenmesi ile konulmaktadır: beklenenden fazla miktarda kullanım, bırakma girişimlerinin başarısız olması, tütün elde etmek veya kullanmak için aşırı zaman harcama, güçlü kullanım isteği (craving), sosyal ve mesleki işlevselliğin bozulması, fiziksel tehlikeye rağmen kullanımın sürdürülmesi, fiziksel veya psikolojik sorunlara rağmen kullanım, tolerans gelişimi ve yoksunluk belirtilerinin varlığı. Bu kriterlerin şiddetine göre bozukluk hafif (2–3 kriter), orta (4–5 kriter) veya ağır (6 ve üzeri kriter) düzeyde sınıflandırılmaktadır. Söz konusu kriterler, tütün kullanımının yalnızca bir alışkanlık değil, süreklilik arz eden bir psikiyatrik bozukluk olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %28,3’tür (TÜİK, 2022). Tütün kullanımının kalp rahatsızlıklarının görülme sıklığını arttığı kansere ve felce yol açtığı bilinmekte ve birçok çalışmada vurgulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılı Avrupa Tütün Kullanım Trendleri Raporu, sigara içmenin erken ölüm riskini artırdığını vurgulamakta ve tüm ölümlerin yaklaşık %18’ini etkilediğine dikkat çekmektedir (WHO, 2019). Günlük 6–8 adet sigara tüketen bireylerin yaklaşık %83’ü, tüketim miktarlarını azaltmakta başarısız olduklarını belirtmektedir. Buna ek olarak, sigarayı bırakmayı düşünen bireylerin sadece %2,5’i herhangi bir yardım almadan sigarayı başarılı bir şekilde bırakabilmektedir (Gençöz F ve ark. 2003). Bu oranlar, sigarayı bırakma sürecinde profesyonel müdahalelerin ne denli hayati olduğunu ortaya koymaktadır.

Sigara bağımlılığının tedavisinde farmakolojik ve farmakolojik olmayan müdahaleler bir arada uygulanmaktadır. Nikotin replasman tedavileri (nikotin sakızı, bant vb.) ve bupropion gibi ilaçlar sıklıkla kullanılan farmakolojik ajanlardır. Ayrıca bireysel psikoeğitim, çevrimiçi uygulamalar, telefon destek hatları gibi yöntemler de yardım edici olmaktadır. Çeşitli araştırmalar farklı sonuçlar vermekle beraber sigara bağımlılığının tedavisinde 1 yıllık remisyon oranlarının oldukça düşük olduğu bilinmektedir (Fiore MC. ve ark., 2008).

Sigarayı bırakma konusunda bilişsel davranışçı terapi (BDT), bilimsel kanıtlara dayalı olarak yapılandırılmış etkili bir müdahaledir (Hollon SD. ve Beck

AT., 2004). BDT, bireyin düşünce kalıplarını ve davranış biçimlerini yapılandırmayı hedefleyerek davranışsal değişim sağlamayı amaçlar. Son yıllarda grup temelli yaklaşımların sigara bağımlılığı üzerindeki etkileri de araştırılmakta; grup psikoterapisinin sosyal destek sağlayıcı etkisi ve paylaşım ortamı sunması, motivasyonu ve kalıcılığı artırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Çelik ve Mortan Sevi, 2020). Ülkemizde grup psikoterapilerinin sigara bağımlılığı etkinliği üzerine yapılan araştırmaları sınırlıdır ve grup psikoterapilerinin kalıcı bırakma üzerine etkinliğini araştıran çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sigara bağımlılığı tedavisinde grup terapilerinin hem bireysel bırakma başarısına katkısı hem de uzun vadeli kalıcılığı destekleyici etkileri yeterince değerlendirilmemiştir. Ayrıca mevcut müdahalelerde sürdürülebilir katılımın sağlanması ve yüksek “drop-out” oranlarının azaltılması da önemli bir araştırma alanıdır.

Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Bağımlılık Polikliniğine başvuran ve tütün kullanım bozukluğu olan hastalarla ile gerçekleştirilen grup psikoterapisinin sigara bırakma ve çalışma boyunca hastalara uygulanacak olan psikometrik testler üzerine etkinliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal dayanıklılık açısından da grup terapilerinin ruh sağlığına olan katkılarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Elde edilecek veriler hem sağlık politikaları açısından hem de klinik uygulamalarda grup temelli müdahalelerin geliştirilmesine katkı sunabilir.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, tütün kullanım bozukluğu olan bireylerde grup psikoterapisinin sigara bırakmaya etkisini değerlendirmeyi amaçlayan müdahale temelli bir süreçtir. Müdahale, 6 hafta süren yapılandırılmış grup psikoterapisi oturumlarını içermektedir. Araştırma için etik kurul onayı; T.C. Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır (Karar No: GOKAEK-2023/18.10, Proje No:2023/350).

Her oturum yaklaşık 60–90 dakika sürmüş ve haftada bir kez yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Müdahale, bilişsel davranışçı terapi (BDT) ilkelerine, motivasyon artırıcı görüşmelere ve grup etkileşimini temel alan psikoeğitimsel ve deneyimsel çalışmalara dayanmaktadır. Süreç aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

1. Hafta: Alışkanlıkların Gücü ve Bireysel Farkındalık

Grup psikoterapisi sürecinin ilk oturumunda katılımcılarla alışkanlık kavramı, sigara içme davranışının nasıl bir rutin haline geldiği ve bu davranışın yaşamlarındaki işlevi ele alınmıştır. Oturumda, alışkanlık döngüsü (tetikleyici – davranış – ödül) üzerine yapılandırılmış psiko-eğitim verilmiş; bireylerin sigarayı ne zaman, nerede ve hangi duygularla içtikleri üzerinde durulmuştur. “Sigara Tüketim İzlem Formu” kullanılarak bireylerin haftalık sigara içme sıklıkları,

tetikleyici durumları ve davranışsal örüntüleri değerlendirilmiştir. Katılımcılar bu formu ev ödevi olarak da kullanarak, davranış farkındalıklarını artırmaya teşvik edilmiştir. “Sigara Bırakmak İçin Önemli Nedenlerim” başlıklı bireysel çalışma formu ile katılımcılar kendi bırakma motivasyonlarını yazılı olarak keşfetmiş; sağlık, ekonomik, sosyal ve duygusal nedenler üzerine düşünceleri sağlanmıştır. Grup içinde gönüllü paylaşımlar ile motivasyonel etkileşim desteklenmiştir. Bu oturum, sürece dair güven ilişkisi oluşturmak, motivasyon kaynaklarını keşfetmek ve davranışsal örüntüleri fark etmeye başlamak amacıyla yapılandırılmıştır.

2. Hafta: Sigara Bırakmanın Faydaları ve Motivasyonu Güçlendirme

Bu oturumun temel amacı, katılımcıların sigara bırakmanın kısa ve uzun vadeli faydalarını fark etmelerini sağlamak ve kendi bırakma nedenlerini netleştirerek motivasyonlarını derinleştirmektir. Bu hafta özellikle sigara içmenin sağlık üzerindeki etkileri ve bireysel bırakma nedenlerinin içselleştirilmesi üzerinde durulmuştur. Katılımcılar önceki hafta verdikleri ev ödevleri üzerinden sigara içme alışkanlıklarını ve tetikleyici durumları paylaşmışlardır. Grup ortamında, bu farkındalıkların neleri değiştirdiği ve hangi durumlarda sigara içme isteğinin arttığı tartışılmıştır. Katılımcılara, sigarayı bırakmanın kısa vadeli ve uzun vadeli etkilerini gösteren materyaller sunulmuştur. Katılımcılardan sigarayı bırakmak için en önemli nedenlerini belirlemeleri istenmiştir. Her birey, sigarayı bırakmaya yönelik kendi en güçlü motivasyon kaynaklarını belirleyip yazmıştır. İsteyen katılımcılar bu nedenlerini grup içinde paylaşmış, grup dinamiğiyle motivasyonları pekiştirilmiştir. Katılımcılardan, sigara bırakmanın faydalarına dair en çok etkilendikleri üç maddeyi bir deftere veya telefon notuna yazarak hafta boyunca her gün kendilerine hatırlatmaları istenmiştir.

3. Hafta: Değişime Hazırlık ve Davranışsal Planlama

Oturumun başlangıcında, katılımcılar, sigara bırakmanın faydaları üzerine önceki hafta hazırladıkları motivasyon kartlarını paylaştı. Bu sürecin kendilerinde nasıl bir farkındalık yarattığı ve hangi nedenlerin bırakma isteğini artırdığı üzerine kısa bir grup paylaşımı yapıldı. Bu oturumda temel hedef, bireylerin sigarasız bir yaşama geçiş için zihinsel ve davranışsal hazırlık yapmalarını sağlamak ve değişim sürecine yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerine destek olmaktır. Katılımcılar alışkanlık döngüsünü kırmak için değişim stratejileri üzerine düşünmüş ve kendi davranış planlarını oluşturmaya yönlendirilmiştir. Ayrıca, katılımcılara davranış değişikliğinin psikolojik dinamikleri aktarıldı. Bu bilgiler, katılımcılara sigarayı bırakmaya karar vermenin yalnızca bir istek değil, aşamalı bir hazırlık süreci olduğunu göstermeyi amaçladı. Sigarasız bir yaşama geçmeden önce yapmaları gereken düzenlemeleri belirlediler ve yaşamlarında karşılaşılabilecekleri zorlanmaları ve bu zorlanmalara karşı alabilecekleri önlemleri listelediler. Katılımcılara verilen tablo aracılığıyla, sigara içmeye yönelindikleri tetikleyici durumları ve bu durumlar karşısında

alternatif tepkileri yazmaları istendi. Bu tablo sayesinde bireyler hem riskli durumları tanımladılar hem de bu anlarda uygulayabilecekleri davranışları planladılar.

4. Hafta: Bırakma Günü Belirleme ve Yoksunlukla Baş Etme Stratejileri

Bu haftanın temel amacı, katılımcıların sigarayı bırakma konusunda somut bir adım atarak bırakma gününü belirlemelerini sağlamak ve bu geçiş sürecinde karşılaşabilecekleri yoksunluk belirtileriyle başa çıkabilmeleri için gerekli psikoeğitimi ve stratejileri sunmaktır. Bu hafta, önceki oturumlara kıyasla katılım sıklığında azalma gözlemlenmiştir. Katılımcıların bir kısmı sürece devam etmemiştir. Bu durum, grubun dinamliğini etkilemiş ve motivasyonel desteğin sürekliliği açısından sınırlılıklar yaratmıştır. Oturuma düzenli katılım sağlayan bireylerle çalışmalar yürütülmüştür. Sigarayı bıraktıktan sonra ortaya çıkabilecek yoksunluk belirtileri (sinirlilik, anksiyete, uyku bozuklukları, yoğun sigara isteği vb.) hakkında bilgi verildi. Bu belirtilerin normal ve geçici olduğu, sürece dair farkındalığın direnci artırabileceği vurgulandı. Katılımcılardan, kendi imzalarıyla sigara kullanmama taahhüdü verdikleri sembolik bir sözleşme hazırlamaları istendi. Bu belge, kişisel motivasyonu artırmak ve bırakma kararını güçlendirmek amacıyla kullanıldı. Katılımcılardan, bir sonraki hafta için kesin bir bırakma tarihi belirlemeleri istendi. Bu tarih, bireysel olarak seçildi ve “sıfırıncı gün” olarak tanımlandı. Katılımcıların bu geçişe psikolojik olarak hazırlanabilmeleri adına, bu karar grup ortamında açıkça ifade edildi ve grup desteğiyle pekiştirildi.

5. Hafta: İstek Yönetimi, Tetikleyicilerle Baş Etme ve Nüks (Relaps) Farkındalığı

Bu haftanın temel amacı, sigarayı bırakmış olan katılımcıların istek anlarıyla nasıl başa çıkacaklarını, tetikleyici durumları nasıl tanımlayacaklarını ve nüks (relaps) riskiyle nasıl başa çıkabileceklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca, sürecin olumlu taraflarını pekiştirmek amacıyla kişisel ödül sistemleri konuşulmuş ve motivasyonel destek artırılmıştır. Katılımcılar bir önceki hafta belirledikleri bırakma gününden sonraki deneyimlerini grup içinde paylaştılar. Zorluklar, başarılar ve destek mekanizmaları ele alındı. Sigara içme isteğinin (craving) biyolojik ve psikolojik temelleri açıklandı. Katılımcılar, sigarasız geçen her gün veya hafta için kendilerine küçük ödüller belirlemeleri konusunda teşvik edildi. Bu davranışın, dopamin sistemini destekleyerek sürece olan bağlılığı artıracakı vurgulandı. Katılımcılar somut hedef-ödül eşleştirmeleri yaptı.

6. Hafta: Sürdürme, Tetikleyicilerle Baş Etme ve Başarıyı Pekiştirme

Bu son oturumun temel hedefi, sigarayı bırakmış olan katılımcıların değişimlerini pekiştirmek, tetikleyici durumlarla nasıl başa çıktıklarını değerlendirmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemektir. Aynı zamanda katılımcıların kendilerini ödüllendirmeleri teşvik edilerek motivasyonun korunması amaçlanmıştır. Bu haftaya yalnızca 4 katılımcı düzenli katılım

sağlayarak ulaşabildi. Grup azalmış olmasına rağmen, kalan bireylerin motivasyonu yüksek ve bırakma süreçlerine bağlılıkları dikkat çekiciydi. Katılımcılar, sigarayı bırakmalarının ardından karşılaştıkları riskli ve tetikleyici durumları paylaştılar. Bu durumlar arasında sosyal çevre baskısı, stresli olaylar ve alışkanlıkla bağlantılı rutinler (örneğin sabah kahvesiyle sigara içme arzusu) öne çıktı. Grup içinde bu tetikleyici anlara karşı geliştirilen bireysel baş etme stratejileri tartışıldı. 6 haftalık terapi süreci özetlendi. Katılımcılar, ilk oturumdan bugüne değişen düşünce, davranış ve duygu örüntülerini değerlendirdiler. Grup sürecinde nelerden fayda gördükleri, neleri zorlayıcı buldukları üzerine yansıtma yapmaları teşvik edildi.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmamızda grup terapisini başlatan dokuz katılımcıdan yalnızca dört kişi altıncı haftaya kadar süreci tamamlayabilmiştir. Bu bulgu, tütün bağımlılığı tedavisinde sürdürülebilir katılım sağlamanın güçlüğüne göstermektedir. Literatürde de sigara bırakma programlarına düzenli devam oranlarının genellikle %47–70 aralığında kaldığı, başka bir ifadeyle katılımcıların yaklaşık %30–53’ünün programı terk ettiği bildirilmektedir (Koçak & Aktürk, 2019). Türkiye’de yapılan bir çalışmada da sigara bırakma polikliniğine başvuran 1324 kişinin %40,8’inin ilk görüşmeden sonra programa devam etmediği rapor edilmiştir (Bahadır A. ve ark., 2016). Bizim grubumuzda da özellikle dördüncü haftadan sonra, çeşitli nedenlerle oturumlara düzenli katılımın azaldığı görülmüştür. Bu noktada motivasyon eksikliği ve bireysel/pratik engellerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Nitel bir çalışmada katılımcıların terapi merkezine uzaklık, zaman yönetimi sorunları ve “psikoterapinin bana yeterince yardımcı olmayacağı” düşüncesi gibi nedenlerle programı bıraktıkları belirtilmiştir (Özaydın Ö. ve ark., 2024). Bu bulgular, grup terapilerinde sürdürülebilir katılımı artırmak için motivasyonu güçlendirecek ve pratik engelleri azaltacak stratejilerin önemini ortaya koymaktadır. Nitekim tedaviye düzenli devam edemeyen kişilerde başarının düştüğü ve programı düşük düzeyde takip edenlerde ilerleyen aylarda sigara kullanımının sürme olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Koçak & Aktürk, 2019).

Bununla birlikte, grup terapisini tamamlayan dört katılımcının tamamının belirledikleri bırakma gününde sigarayı bırakmış olması, düzenli katılım sağlayan bireylerde grup terapisinin etkili olabileceğine işaret etmektedir. Literatürde grup temelli sigara bırakma programlarının etkinliğine ilişkin güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin, bir Cochrane derlemesinde grup destekli davranışsal terapi alan bireylerde en az altı ay süreyle sigarayı bırakma olasılığının, yalnızca yazılı materyallerle desteklenen kendi kendine yardım programlarına kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır (Stead ve ark., 2017). Aynı derlemede, benzer yoğunlukta bireysel danışmanlık ile grup terapisini karşılaştırıldığında ise iki yaklaşımın başarı açısından benzer olduğu ve belirgin

bir üstünlük göstermediği bildirilmiştir; bu bulgu grup formatının bireysel danışmanlık kadar etkili bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir (Stead ve ark., 2017).

Çalışmamızdaki kısa dönem sonuçlar nicel ölçümlerle doğrulanmamış olsa da önceki araştırmalarla genel hatlarıyla uyumludur. Örneğin Yeşildal ve arkadaşlarının (2014) 130 kişi ile yürüttükleri bir grup terapisi çalışmasında (Allen Carr yöntemi) bir yıllık takip sonunda sigarayı bırakma başarısının gruplara göre %28 ile %62 arasında değiştiği bildirilmiştir. Bizim müdahalemizde katılımcılar farmakolojik destek almaksızın psikoeğitim ve grup terapisiyle desteklenmiş, erken dönemde klinik olarak anlamlı bir bırakma davranışı gözlenmiştir. Bir sistematik derlemede BDT temelli müdahalelerin sigara bırakmada tek başına anlamlı fayda sağlayabildiği ve farmakoterapi veya nikotin replasman tedavisiyle birleştirildiğinde başarının daha belirgin biçimde arttığı belirtilmiştir (Çelik ve Mortan Sevi, 2020). Bu nedenle bulgularımız, grup terapisinin doğru yapılandırıldığında farmakolojik desteğe tamamlayıcı bir katkı sunabileceğini düşündürmektedir.

Katılımcıların öznel geri bildirimleri, grup terapisinin sağladığı “yalnız olmadığını hissetme” deneyiminin ve benzer sorunlarla mücadele eden kişilerle bir arada olmanın güçlendirici etkisini vurgulamıştır. Grup içindeki dayanışma, bağımlılıkla mücadelede önemli bir sosyal destek mekanizması sağlamıştır. Nitel çalışmalarda da grup halinde çalışmanın katılımcıları daha fazla motive ettiği ve birbirine destek olma imkânı verdiği bildirilmiştir (Özaydın Ö. ve ark., 2024). Sosyal desteğin öz-yeterlik duygusunu güçlendirerek bırakma kararlılığını pekiştirebildiği bilinmektedir. Grup eğitimi sonrasında bireylerin sigara konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttığı ve bağımlılıkla baş etme becerilerinin geliştiğini bildiren çalışmalar da mevcuttur (Ateş, 2013). Çalışmamızda oturumlarda kullanılan psiko-eğitim materyalleri, davranışsal izleme tabloları ve motivasyon kartlarının katılımcıların öz farkındalık geliştirmelerine ve hedeflerine bağlanmalarına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle tetikleyici durumları tanıma, yoksunluk belirtileriyle başa çıkma ve küçük ödüller planlama gibi bilişsel-davranışçı tekniklerin motivasyonu artırdığı görülmüştür.

BDT, işlevsel olmayan düşünce ve davranışların belirlenmesi ve değiştirilmesine odaklanan yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Beck’in bilişsel modeline göre bağımlılık, öğrenilmiş bir davranış örüntüsüdür ve bireyin kendisi ile çevresine ilişkin geliştirdiği işlevsel olmayan temel inançlar tarafından sürdürülebilir (Beck, 1993). Beck (1993), bağımlılığın devamlılığını sağlayan ve bırakmayı zorlaştıran temel etkenlerden birinin, maddenin “rahatlatıcı/koruyucu/telafi edici” bir işlev gördüğüne dair bilişsel çarpıtmalar olduğunu vurgulamıştır. BDT yaklaşımında bireyin bağımlılık davranışını tetikleyen uyarıları fark etmesi ve bu uyarılara uygun tepkiler geliştirmesi

temel hedeflerdendir (Marlatt ve Donovan, 2005). Biz de grup sürecinde her katılımcının hangi durum ve duyguların kendisinde sigara içme isteğini tetiklediğini keşfetmesini destekledik. Katılımcılar kahve içmek, stresli olmak, sosyal ortam baskısı gibi tetikleyicilerini grup içinde dile getirerek bunlara karşı alternatif davranışlar planlamışlardır (örn. nefes egzersizi, dikkat dağıtma, destek arama). İlk haftalardan itibaren sigarayı bırakma nedenlerini yazılı hâle getirmek ve bırakmanın kısa/uzun vadeli avantajlarını tartışmak da motivasyonu yüksek tutmaya yönelik adımlar olmuştur. Literatürde tetikleyicileri yönetebilmek, alternatif ödülleri koymak ve davranışsal farkındalık kazanmanın nüks riskini azaltan temel unsurlar olduğu vurgulanmaktadır (Marlatt ve Donovan, 2005). Başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi ve nüks önleme stratejileri aracılığıyla; bireyin sigaraya atfettiği işlevi sorgulamasını ve daha uyumlu baş etme yolları geliştirmesi amaçlanır (McHugh ve ark., 2010; Connors ve ark., 2013; Güven, 2019).

Grup terapisinin bir diğer boyutu ise paylaşım ve “hesap verebilirlik” duygusudur. Dördüncü haftada katılımcıların bırakma tarihlerini grup önünde ilan etmeleri, karşılıklı taahhüt ve sorumluluk hissini artırmış olabilir. Süreçte kalan dört katılımcının da belirledikleri tarihte sigarayı bırakıp sonraki oturlara dumanlı katılması, bu yaklaşımın potansiyel değerini düşündürmektedir. Katılımcıların sigarasız geçen günlerde yaşadıkları yoksunluk belirtilerini ve zorlanmaları grupta açıkça paylaşmaları, yalnızca terapistin yönlendirmesiyle değil, akran desteğiyle de öğrenmeyi mümkün kılmış; başa çıkma repertuarını genişletmiştir. Bu psikososyal destek, bireylerin yalnız olmadıklarını hissetmelerine, zorluklarla mücadelede dayanışma geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlamış; bırakma davranışının sürdürülmesine olumlu yansımıştır.

Bu çalışmanın belirgin bir kısıtlılığı, örneklem büyüklüğünün küçük olması ve nicel veri ile uzun vadeli sonuçların değerlendirilememiş olmasıdır. Altı haftalık kısa bir grup müdahalesi sonunda elde edilen bulgular, sigara bırakma sürecinin ancak başlangıç aşamasını yansıtmaktadır. Psikometrik testler, katılımcıların tedaviden ayrılması nedeniyle tamamlanmamış olduğundan, elde ettiğimiz sonuçlar nitel gözlemlere ve katılımcı beyanlarına dayanmaktadır. Literatürde de benzer müdahalelerin etkinliğini tam olarak ortaya koymak için daha uzun süreli takiplere ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır (Mohamed R., ve ark., 2021). Gelecek çalışmalarda daha geniş örneklemle, mümkünse kontrol gruplu ve randomize desenlerde, grup terapilerinin tek başına veya diğer tedavi bileşenleriyle (örneğin farmakoterapi) kombinasyonunun etkinliği araştırılmalıdır. Bizim çalışmamızda tedavi süresince gözlenen, yüksek bırakma oranı, grup terapisinin potansiyel faydasını gösterse de bunun ne derece sürdürülebilir olduğu ve genel popülasyona ne ölçüde genellenebileceği ileri araştırmalarla desteklenmelidir. Ayrıca, devamlılık sorununun azaltılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımlar da gelecekte ele alınmalıdır. Örneğin, telefon

uygulamaları veya çevrimiçi destek grupları aracılığıyla oturumlar arasındaki iletişimin sürdürülmesi, hatırlatıcı mesajlar ve destekleyici geribildirimler ile motivasyonun taze tutulması gibi yöntemler, katılımı artırmada faydalı olabilir. Dolayısıyla, grup terapilerine ek olarak bu tür destekleyici araçların kullanımı hem katılımı arttırmak hem de bırakma davranışını pekiştirmek için gelecek çalışmalarda değerlendirilebilir.

4. SONUÇ

Sigara kullanım bozukluğu tanısı almış bireylerle yürütülen bu altı haftalık grup psikoterapisi çalışması, grup temelli müdahalelerin sürdürülebilir katılım sağlandığında sigara bırakma sürecinde klinik açıdan anlamlı ve olumlu değişiklikler yaratabildiğini göstermektedir. Grup ortamı, bireylerin yalnızca sigara içme davranışlarını değil, bu davranışla ilişkili otomatik düşüncelerini, duygusal tepkilerini ve baş etme biçimlerini birlikte ele almalarına olanak tanımaktadır. Bu yönüyle grup psikoterapileri, sigara bağımlılığının yalnızca fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal boyutlarını hedef alan bütüncül bir müdahale çerçevesi sunmaktadır. Bu bulgu, literatürdeki grup terapilerinin sigara bırakmadaki rolüne dair olumlu kanıtlarla uyumludur Hall ve ark., 1998; Hernandez-Lopez ve ark., 2009; Secades-Villa ve ark., 2014; López-Núñez ve ark., 2016b).

Çalışmada süreci tamamlayan katılımcıların tamamının sigarayı bırakmış olması, grup psikoterapilerinin davranış değişikliğini başlatma ve sürdürme açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu düşündürmektedir. Grup sürecinde paylaşılan deneyimler, karşılıklı destek ve model alma, bireylerin bırakma kararlarını pekiştirmekte ve yoksunluk döneminde yaşanan zorluklarla baş etme becerilerini güçlendirmektedir. Bu bulgular, grup temelli yaklaşımların motivasyon, öz-yeterlik ve sosyal destek gibi sigara bırakma sürecinin kritik belirleyicilerini eş zamanlı olarak ele alabildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, çalışmanın en önemli sınırlılığı katılımın sürdürülememesi olmuştur. Müdahale sürecinin ilerleyen haftalarında bazı katılımcıların gruptan ayrılması, grup psikoterapilerinin etkinliğinin büyük ölçüde devamlılığa bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, grup terapilerinin planlanması aşamasında yalnızca terapötik içeriğin değil, katılımı destekleyecek yapısal ve psikososyal unsurların da dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir. Oturum saatlerinin esnekliği, hatırlatıcı sistemler, kısa bireysel destek görüşmeleri, motivasyonel güçlendirme oturumları ve gerektiğinde farmakoterapi ile entegrasyon, grup sürecine devamı artırabilecek uygulamalar arasında değerlendirilebilir.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, grup psikoterapilerinin sigara bağımlılığı tedavisinde tek başına “herkes için uygun” bir yöntem olmaktan ziyade, doğru yapılandırıldığında ve uygun katılımcılarla yürütüldüğünde etkili olabilecek bir müdahale biçimi olduğunu düşündürmektedir. Özellikle sigarayı bırakmaya

yönelik motivasyonu bulunan, sosyal etkileşimden yarar sağlayabilen ve düzenli katılım gösterebilecek bireyler için grup terapileri önemli bir seçenek sunmaktadır.

Sonuç olarak, grup psikoterapileri sigara bağımlılığı ile mücadelede umut vadeden bir müdahale yaklaşımıdır; ancak uygulamada dikkatli planlama, katılımı destekleyici düzenlemeler ve bireysel ihtiyaçlara duyarlı bir yapı gerektirmektedir. Gelecek çalışmaların, grup terapilerinin uzun dönemli etkilerini, farklı yoğunluk ve içeriklerdeki uygulamalarını ve farmakoterapi ile bütünleşik modellerini değerlendirmesi, bu yaklaşımın klinik pratikte daha etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Ateş, Z. B. (2013). Sigarayı bırakma tedavisinde sosyal grup çalışması. *Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi*, (2), 23–26.
- Bahadır, A., Iliaz, S., Yurt, S., et al. (2016). Factors affecting dropout in the smoking cessation outpatient clinic. *Chronic Respiratory Disease*, 13(2), 155–161.
- Beck, A. T., Wright, F. D., Newman, C. F., & Liese, B. S. (1993). Cognitive therapy of substance abuse. Guilford Press.
- Carroll, K. M. (1996). Relapse prevention as a psychosocial treatment: A review of controlled clinical trials. *Experimental and Clinical Psychopharmacology*, 4(1), 46–54. <https://doi.org/10.1037/1064-1297.4.1.46>
- Cavallo, D. A., Cooney, J. L., Duhig, A., Smith, A. E., Liss, T. B., McFedridge, A. K., et al. (2007). Combining cognitive behavioral therapy with contingency management for smoking cessation in adolescent smokers: A preliminary comparison of two different CBT formats. *The American Journal on Addictions*, 16(6), 469–474.
- Çelik, Z. H., & Mortan Sevi, O. (2020). Sigarayı bırakma tedavisinde bilişsel davranışçı terapisinin etkililiği: Sistematik bir gözden geçirme. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 12(1), 54–71. <https://doi.org/10.18863/pgy.534638>
- Connors, G., DiClemente, C., & Velasquez, M. (2013). Substance abuse treatment and the stages of change: Selecting and planning interventions. Guilford Press.
- Fiore, M. C., Jaén, C. R., Baker, T. B., Bailey, W. C., Benowitz, N. L., Curry, S. J., et al. (2008). Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Clinical practice guideline. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service.
- Gençöz, F., Soykan, Ç., Soykan, A., ve ark. (2003). Sigara bağımlılığı ve tedavisi. Art Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
- Güven, M. (2019). Alkol ve madde kullanım bozukluğunda bilişsel davranışçı terapiler. In C. Evren (Ed.), *Alkol ve madde kullanım bozuklukları temel başvuru kitabı* (Cilt 1, ss. 87–104). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.
- Hall, S. M., Reus, V. I., Munoz, R. F., Sees, K. L., Humfleet, G. L., Hartz, D. T., et al. (1998). Nortriptyline and cognitive-behavioral therapy in the treatment of cigarette smoking. *Archives of General Psychiatry*, 55(8), 683–690.
- Hernandez-Lopez, M., Luciano, M. C., Bricker, J. B., Roales-Nieto, J. G., & Montesinos, F. (2009). Acceptance and commitment therapy for smoking cessation: A preliminary study of its effectiveness in comparison with

- cognitive behavioral therapy. *Psychology of Addictive Behaviors*, 23(4), 723–730.
- Hollon, S. D., & Beck, A. T. (2004). Cognitive and cognitive-behavioral therapies. In M. J. Lambert (Ed.), *Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change* (5th ed., pp. 447–492). Wiley.
- Koçak, N. D., & Aktürk, Ü. A. (2019). What factors influence non-adherence to the smoking cessation program? *Turkish Thoracic Journal*, 20(3), 168–174. <https://doi.org/10.5152/TurkThoracJ.2018.18040>
- López-Núñez, C., Martínez-Loredo, V., Weidberg, S., Pericot-Valverde, I., & Secades-Villa, R. (2016b). Voucher-based contingency management and in-treatment behaviors in smoking cessation treatment. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 16(1), 30–38.
- Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. (Eds.). (2005). *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors*. Guilford Press.
- McHugh, R. K., Hearon, B. A., & Otto, M. W. (2010). Cognitive-behavioral therapy for substance use disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 33(3), 511–525. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2010.04.012>
- Mohamed, R., Bullen, C., Hairi, F. M., & Nordin, A. S. A. (2021). A systematic review of group therapy programs for smoking cessation in Asian countries. *Tobacco Induced Diseases*, 19, 63. <https://doi.org/10.18332/tid/140089>
- Özaydın, Ö., Uçar, M. T., Kalmuk, G., Kaplan, D., et al. (2024). Sigarayı bırakma tedavi ve grup müdahalesine katılımı etkileyen faktörler: Nitel bir araştırma [Özet bildirisi]. 8th International 26th National Public Health Congress, Ankara, Türkiye, 5–7 Aralık 2024, 758–759.
- Potts, D. A., & Daniels, J. S. (2014). Where there's smoke there must be ire! Nicotine addiction treatment: A review. *Missouri Medicine*, 111(1), 80–84.
- Rüther, T., Kiss, A., Eberhardt, K., Linhardt, A., Kröger, C., & Pogarell, O. (2018). Evaluation of the cognitive behavioral smoking reduction program “Smokeless”: A randomized controlled trial. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 268(3), 269–277.
- Secades-Villa, R., García-Rodríguez, O., López-Núñez, C., Alonso-Pérez, F., & Fernández-Hermida, J. R. (2014). Contingency management for smoking cessation among treatment-seeking patients in a community setting. *Drug and Alcohol Dependence*, 140, 63–68.
- Stead, L. F., Carroll, A. J., & Lancaster, T. (2017). Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3(3), CD001007. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001007.pub3>
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Küresel yetişkin tütün araştırması. TÜİK.

- Vinci, C. (2020). Cognitive behavioral and mindfulness-based interventions for smoking cessation: A review of the recent literature. *Current Oncology Reports*, 22(6), 58. <https://doi.org/10.1007/s11912-020-00915-w>
- World Health Organization. (2019). European tobacco use trends report. <https://www.who.int/publications/i/item/who-global-report-on-trends-in-prevalence-of-tobacco-use-2000-2025-third-edition>
- Yeşildal, A., Oğuz, G., Güven, M., Sungur, M. Z., & Üstünuçar, I. (2014). Sigara bağımlılığı tedavisinde bilişsel davranışçı grup tedavisi. *Bağımlılık Dergisi*, 15(2), 76–84.

BÖLÜM 7

Trans Bireylerde Cinsiyet Uyumlandırma Sürecinde Telepsikiyatri: Klinik Deneyim ve Avantajlar*

**İlay Dalkıran² & Nezihe Gül³ &
Fatma Seher Kocaayan⁴ & Aslıhan Polat⁵**

¹*Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi’nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

² Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye, Orcid No:0009-0009-6433-2681

³ Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye, Orcid No:0009-0008-6554-7054

⁴ Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye, Orcid No:0009-0001-7183-2002

⁵ Profesör Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye, Orcid No:0000-0001-9649-8701

1. GİRİŞ

Cinsiyet hoşnutsuzluğu (gender dysphoria), bireyin doğumda belirlenen cinsiyeti ile içsel olarak deneyimlediği cinsiyet kimliği arasındaki uyumsuzluk sonucunda ortaya çıkmasıdır. Kinik olarak anlamlı bir soruna yol açabilen, biyopsikososyal temelleri olan bir süreçtir. Güncel yaklaşımlar, cinsiyet hoşnutsuzluğunu yalnızca bireysel bir durum olarak değil; toplumsal normlar, ayrımcılık, sağlık hizmetlerine erişim ve hukuki düzenlemelerle etkileşim içinde şekillenen çok katmanlı bir süreç olarak ele almaktadır. Bu bağlamda, trans bireylerin ruhsal iyilik hali yalnızca bireysel psikopatoloji ile değil, aynı zamanda yapısal ve çevresel faktörlerle de yakından ilişkilidir (Van der Miesen et al., 2020).

Cinsiyet uyumlandırma süreci; psikiyatrik değerlendirme ve izlem, endokrinolojik tedaviler, cerrahi girişimler, sosyal uyum ve hukuki düzenlemeleri içeren, uzun soluklu ve dinamik bir süreçtir. Bu sürecin başarısı, yalnızca tıbbi müdahalelerin uygulanmasına değil; bireyin ruhsal olarak desteklenmesine, kimlik gelişiminin güvenli bir çerçevede ele alınmasına ve süreklilik gösteren psikososyal izlemin sağlanmasına bağlıdır. Literatürde, düzenli ruhsal destek alan trans bireylerin yaşam kalitesinin, ruhsal dayanıklılığının ve tedaviye uyumunun daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Van de Grift et al., 2024).

Bununla birlikte, trans bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine erişimi birçok ülkede yapısal engellerle sınırlıdır. Uzmanlaşmış merkezlerin azlığı, uzun bekleme süreleri, coğrafi uzaklık, ekonomik güçlükler ve sağlık sistemleri içerisinde deneyimlenen damgalayıcı tutumlar, bu sürecin sürekliliğini tehdit eden başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle bekleme sürelerinin uzaması, cinsiyet hoşnutsuzluğu ile ilişkili sıkıntının artmasına, depresyon ve anksiyete belirtilerinin şiddetlenmesine ve bazı bireylerde umutsuzluk ile intihar düşüncelerinin yoğunlaşmasına yol açabilmektedir (Van der Miesen et al., 2020).

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde sağlık hizmetlerinin sunum biçimlerini köklü biçimde değiştirmiş; yüz yüze hizmetlerin kısıtlanması, birçok alanda olduğu gibi ruh sağlığı hizmetlerinde de ciddi aksamalara neden olmuştur. Pandemi sürecinde “acil olmayan” sağlık hizmetlerinin ertelenmesi, trans bireylerin cinsiyet uyumlandırma süreçlerinde belirgin kesintilere yol açmış; hormon tedavilerinin gecikmesi, cerrahi girişimlerin ertelenmesi ve psikiyatrik izlem süreçlerinin askıya alınması yaygın olarak bildirilmiştir (Van der Miesen et al., 2020; The Lancet, 2020). Bu kesintilerin, trans bireylerin ruhsal iyilik hali üzerinde olumsuz etkiler yarattığı; depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinde artışa neden olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (MacCarthy et al., 2020).

Pandemi koşullarında yüz yüze görüşmelerin sınırlanmasıyla birlikte, telepsikiyatri uygulamaları ruh sağlığı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak açısından önemli bir alternatif olarak ön plana çıkmıştır. Telepsikiyatri,

psikiyatrik deęerlendirme, izlem ve psikoterapötik müdahalelerin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla uzaktan sunulmasını mümkün kılmakta; özellikle fiziksel erişimin kısıtlı olduęu dönemlerde tedavi süreklilięinin korunmasına katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, telepsikiyatri uygulamaları, azınlık grupların saęlık kurumlarına başvururken karşılaşılabilecekleri damgalanma ve ayrımcılık risklerini azaltarak daha güvenli bir destek alanı sunabilmektedir (Gava et al., 2021; Renner et al., 2022).

Uluslararası literatürde, telepsikiyatri ve e-saęlık uygulamalarının pandemi sürecinde trans bireyler için erişilebilirlik, süreklilik ve psikosozal destek açısından önemli avantajlar sunduęu bildirilmiştir. Özellikle hormon tedavilerinin uzaktan izlenebilmesi, psikiyatrik destek görüşmelerinin çevrim içi ortamda sürdürülebilmesi ve multidisipliner ekipler arasında iletişimin devam ettirilmesi, ruhsal yükün hafifletilmesinde koruyucu bir rol üstlenmiştir (Gava et al., 2021; The Lancet, 2020). Bu bulgular, telepsikiyatrinin yalnızca geçici bir kriz çözümü deęil, uzun vadede ruh saęlığı hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olarak deęerlendirilmesi gerektięine işaret etmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2004 yılından bu yana cinsiyet hoşnutsuzluęu tanısı almış bireyleri multidisipliner bir yaklaşımla izlemekte; düzenli psikiyatrik deęerlendirmeler, aylık grup psikoterapileri ve hormon ile cerrahi konseyleri aracılığıyla kapsamlı bir bakım sunmaktadır. Pandemi sürecinde yüz yüze görüşmelerin durmasıyla birlikte, birim bünyesinde kısa sürede bir telepsikiyatri poliklinięi kurulmuş ve başlangıçta acil ruhsal yakınmaları olan hastalara hizmet vermeye başlamıştır. Zaman içerisinde, trans bireylerin pandemi koşullarına baęlı artan depresyon ve anksiyete belirtileri nedeniyle bu poliklinięe yoğun başvurular gerçekleştirdięi gözlemlenmiştir.

Pandemi döneminde edinilen bu klinik deneyimlerin ardından, telepsikiyatri poliklinięi birim bünyesinde kalıcı hale getirilmiş ve pandemi sonrasında da aktif olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Özellikle 2022 yılından itibaren pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte, cinsiyet uyumlandırma sürecindeki tıbbi takipler yeniden başlatılmış; buna karşın telepsikiyatri uygulamaları, duyulan gereksinimler doęrultusunda daha yaygın ve bütünleyici bir biçimde kullanılmaya devam etmiştir.

Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda pandemi döneminde başlatılan ve sonrasında kalıcı hale gelen telepsikiyatri uygulamalarının, cinsiyet uyumlandırma sürecindeki trans bireyler açısından klinik katkılarının, avantajlarının ve ruhsal destek süreçlerine saęladığı olanakların deęerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Tasarımı

Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırma, COVID-19 pandemisi sürecinde ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda yaşanan dönüşüm bağlamında, telepsikiyatri uygulamalarının cinsiyet uyumlandırma sürecindeki trans bireyler açısından klinik katkılarını betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışma, herhangi bir müdahale içermeyen, mevcut klinik uygulamalara dayalı gözlemsel bir tasarıma sahiptir.

2.2. Araştırma Evreni ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Cinsiyet Kimliği Polikliniği'nde Nisan 2020 ile Eylül 2025 tarihleri arasında izlenen bireyler oluşturmaktadır. Belirlenen bu zaman aralığı, COVID-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte yüz yüze psikiyatrik hizmetlerin önemli ölçüde kısıtlandığı ve telepsikiyatri uygulamalarının klinik pratiğe entegre edildiği dönemi kapsamaktadır.

Çalışma kapsamına, cinsiyet hoşnutsuzluğu tanısı ile izlenen ve en az bir kez telepsikiyatri görüşmesi yapılan bireyler dahil edilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili tarihler arasında izlenen toplam 120 bireyin hasta dosyası geriye dönük olarak incelenmiştir. Dosya incelemesi sonucunda, 47 bireyin telepsikiyatri hizmetinden yararlandığı belirlenmiştir. Bu bireylerin 28'i trans erkek, 19'u trans kadındır.

Çalışmaya dahil edilen 47 birey ile toplam 117 telepsikiyatri görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Birey başına düşen görüşme sayısı 1 ile 11 arasında değişmekte olup, görüşme sıklığı bireylerin klinik gereksinimleri, ruhsal belirtilerinin şiddeti ve izlem ihtiyacına göre belirlenmiştir.

2.3. Telepsikiyatri Uygulamasının Özellikleri

Telepsikiyatri görüşmeleri, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nin veri güvenliği ve gizlilik ilkelerine uygun, güvenli çevrim içi görüşme platformu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, psikiyatri uzmanı veya psikiyatri alanında görev yapan araştırma görevlileri tarafından yürütülmüştür.

Görüşmeler yapılandırılmamış klinik değerlendirme formatında gerçekleştirilmiş olup, her görüşmede bireyin öznel anlatımı ve klinik gözlem ön planda tutulmuştur. Görüşmeler sırasında aşağıdaki alanlar bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır:

- Cinsiyet uyumlandırma süreci ile ilişkili ruhsal durum,
- Depresyon ve anksiyete belirtilerinin varlığı ve şiddeti,
- Sosyal ilişkiler ve sosyal destek kaynakları,
- Aile içi ilişkiler ve aile tutumları,

- Eğitim ve iş yaşamındaki işlevsellik,
- Hormon tedavisinin ruhsal etkileri,
- Cerrahi süreçlere yönelik beklenti, kaygı ve belirsizlikler,
- Pandemi koşullarının bireyin ruhsal iyilik hali üzerindeki etkileri.

Her görüşmenin ardından klinik notlar hasta dosyalarına kaydedilmiş ve bu notlar araştırma kapsamında nitel veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

2.4. Veri Toplama ve Veri Analizi

Araştırmada elde edilen veriler, telepsikiyatri görüşmelerine ait klinik notların geriye dönük olarak incelenmesi yoluyla toplanmıştır. Klinik notlar, nitel veri analizi yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu amaçla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

İçerik analizi sürecinde, görüşme notları tekrar tekrar okunmuş, anlamlı ifade birimleri belirlenmiş ve benzer içerikler tematik olarak gruplanmıştır. Bu analiz sonucunda görüşmelerde öne çıkan temalar beş ana başlık altında sınıflandırılmıştır:

1. Hormon ve cerrahi tedaviler,
2. Açılma süreci,
3. Aile ve arkadaş ilişkileri,
4. İş ve eğitim hayatı,
5. Yasal süreçler ve haklar.

Belirlenen bu temalar, trans bireylerin cinsiyet uyumlandırma sürecinde yaşadıkları psikososyal güçlükleri ve telepsikiyatri uygulamalarının bu güçlüklerle baş etmedeki rolünü betimlemek amacıyla kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

3.1. Hormon ve Cerrahi Tedaviler

Hormon tedavisine ilişkin görüşmelerde; trans bireylerin bir kısmı hormon tedavisine bağlı duygudurum değişimleri, anksiyete artışı ve bedensel farklılaşmaya yönelik karışık duygular bildirmiştir. Ameliyat öncesi süreçte kaygı, belirsizlik ve beklentiler öne çıkarken; ameliyat sonrası dönemde komplikasyonlarla baş etme ve bedensel bütünlüğe uyum temaları dikkat çekmiştir.

Literatürde de benzer şekilde, pandeminin cinsiyet uyumlandırma süreçlerini aksattığı, hormon tedavilerinde kesinti yaşayan bireylerin ruhsal iyilik halinin bozulduğu belirtilmektedir (Van der Miesen et al., 2020; Gava et al., 2021).

3.2. Açılma Süreci

Katılımcıların büyük bir kısmı aile bireylerine veya arkadaş çevresine cinsiyet kimliğini açıklama sürecinde yoğun kaygı yaşadığını, bazı durumlarda reddedilme veya dışlanma ile karşılaştığını belirtmiştir. Telepsikiyatri görüşmeleri, bu süreçte duygusal destek sağlama, kabul edilmeme durumlarında baş etme stratejileri geliştirme ve aileyle iletişimi güçlendirme açısından önemli bir araç olmuştur.

Benzer biçimde, Renner ve ark. (2022) e-sağlık uygulamalarının trans bireylerde izolasyonu azaltarak sosyal destek algısını güçlendirdiğini vurgulamıştır.

3.3. Aile ve Arkadaş İlişkileri

Aile üyeleriyle yaşanan çatışmalar, romantik ilişkilerde açıklık ve güven sorunları ile arkadaş çevresinden destek arayışı görüşmelerde sık dile getirilmiştir. Pandemi döneminde sosyal kısıtlamalar nedeniyle, bireylerin kendi topluluklarıyla yüz yüze bir araya gelme imkânlarının azalması, trans bireylerde izolasyon duygusunu belirgin biçimde artırmıştır (Van der Miesen et al., 2020; MacCarthy et al., 2020). Trans topluluğundan uzak kalmak, kimliğin onaylanması ve aidiyet duygusunun zayıflamasına yol açmış, bu durum bazı bireylerde yalnızlık, düşük benlik saygısı ve umutsuzluk belirtilerini güçlendirmiştir (Renner et al., 2021).

Telepsikiyatri, bu izolasyon koşullarında psikososyal destek sunarak bireylerin duygusal paylaşımını kolaylaştırmış ve yalnızlık hissini azaltmada önemli bir işlev üstlenmiştir. Görüşmeler sırasında katılımcıların duygularını ifade etme, sosyal ilişkilerinde sınır koyma, çatışmaları yönetme ve baş etme becerilerini geliştirme konularında ilerleme kaydedildiği gözlenmiştir. Benzer biçimde, Eyssel ve ark. (2017), trans bireylerin sağlık hizmetlerinde yalnızca klinik destek değil, aynı zamanda sosyal onay ve güven ilişkisi aradıklarını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, telepsikiyatri görüşmeleri hem bireysel dayanıklılığı güçlendiren hem de topluluk desteğinden yoksun kalınan dönemlerde köprü işlevi gören bir araç haline gelmiştir.

3.4. İş ve Eğitim Hayatı

Telepsikiyatri görüşmelerinde, katılımcıların önemli bir kısmı işyerinde veya eğitim kurumlarında isim değişikliği, kimlik kullanımı, tuvalet veya giyinme alanlarına erişim gibi yapısal engeller yaşadıklarını bildirmiştir. İşe veya eğitime devam ederken gizlilik nedeniyle randevulara katılamama sorunu yaşayan bireyler için telepsikiyatri önemli bir kolaylık sağlamıştır. Uzak bölgelerde yaşayan veya şehir değiştiren katılımcıların tedavi sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi, uygulamanın en belirgin avantajları arasında yer almıştır. Özellikle Kocaeli Üniversitesi psikiyatri bölümünde cinsiyet hoşnutsuzluğu sürecine başlayıp üniversite kazanması nedeniyle şehir değiştirmek zorunda

kalan genç trans bireylerin hem eğitim sürecini teşvik etmek hem de sürecine devam edebilmesine konusunda belirgin destek sağladığı görülmüştür. Cinsiyet disforisi gibi özellikli yaklaşım gerektiren süreçler her klinikte izlenmediği için bu süreçte telepsikiyatrinin avantajı fark edilmiştir. Bu bulgu, telepsikiyatri uygulamalarının azınlık gruplarının sağlık hizmetine erişiminde eşitsizlikleri azalttığını gösteren uluslararası verilerle örtüşmektedir (MacCarthy et al., 2020; Van de Grift et al., 2024).

3.5. Yasal Süreçler ve Haklar

Görüşmelerin bir kısmında, katılımcıların multidisipliner kurul onayından sonra mahkeme süreçleri hakkında bilgi ve rehberlik desteği talep ettikleri görülmüştür. Aynı zamanda yakın zamanda değişen yönetmelik nedeniyle yasal süreçler konusunda belirsizlik yaşayan kişilere değişiklikler hakkında bilgilendirme ve kaygıyla baş etmede yardımcı olduğu görülmüştür. Bu süreçte Telepsikiyatri görüşmeleri bu bilgi aktarımını kolaylaştırmış, özellikle şehir dışında yaşayan bireylerin hukuki süreçlerdeki kaygılarını azaltmıştır.

3.6. Genel Değerlendirme

Elde edilen bulgular, telepsikiyatri uygulamalarının trans bireylerin cinsiyet uyumlandırma sürecinde erişilebilirlik, süreklilik, damgalanma riskinin azalması ve psikososyal destek sağlama açısından önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir. Katılımcılar, çevrim içi görüşmelerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine olanak tanıdığını belirtmiştir. Bununla birlikte, uygun görüşme ortamı sağlayamama ve teknik altyapı sorunları uygulamanın sınırlılıkları arasında yer almıştır.

Bu sonuçlar, The Lancet'in (2020) telemedicine değerlendirmesiyle uyumlu olarak, çevrim içi hizmetlerin gelecekte klasik psikiyatrik bakımın tamamlayıcısı değil, ayrılmaz bir parçası olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, Van de Grift ve ark. (2024)'ün çalışmasında bildirilen uzun bekleme sürelerinin trans bireylerde depresyon ve izolasyonu artırdığı göz önüne alındığında, telepsikiyatri bu sürecin neden olduğu psikososyal yükü azaltan sürdürülebilir bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

4. SONUÇLAR

Bu çalışma, trans bireylerin cinsiyet uyumlandırma sürecinde telepsikiyatri uygulamalarının klinik katkılarını ve sağladığı avantajları değerlendirmiştir. Elde edilen bulgular, telepsikiyatrinin özellikle erişilebilirlik, tedavi sürekliliği, psikososyal destek sağlama ve damgalanma riskini azaltma açısından önemli bir işlev üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle telepsikiyatri, pandemi koşullarında ortaya çıkan geçici bir çözümün ötesinde, trans bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine erişiminde kalıcı ve bütünüleyici bir model olarak değerlendirilmektedir.

Çalışmamızda, özellikle şehir dışında yaşayan, iş veya eğitim yaşamı nedeniyle yüz yüze görüşmelere düzenli olarak katılamayan bireyler için telepsikiyatri uygulamalarının tedavi sürecinin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesine olanak tanıdığı gözlenmiştir. Uzmanlaşmış merkezlere fiziksel erişimin sınırlı olduğu durumlarda, çevrim içi görüşmelerin süreklilik sağlaması, cinsiyet uyumlandırma sürecinin ruhsal boyutunda koruyucu bir rol üstlenmiştir. Bu bulgu, pandemi öncesinde de var olan erişim eşitsizliklerinin telepsikiyatri aracılığıyla kısmen azaltılabileceğine işaret etmektedir ve uluslararası literatürle uyumludur (van der Miesen et al., 2020; Renner et al., 2022).

Pandemi sonrası dönemde de telepsikiyatri hizmetlerinin aktif biçimde sürdürülmesi, bu uygulamanın klinik pratikte sürdürülebilir bir model haline geldiğini göstermektedir. Çalışmamızda, telepsikiyatri görüşmelerinin bireylerin ruhsal iyi oluşunu desteklediği; depresyon ve anksiyete belirtilerinde azalma sağladığı; stresle baş etme becerilerini ve sosyal işlevselliği güçlendirdiği gözlemlenmiştir. Görüşmeler sırasında bireylerin, cinsiyet uyumlandırma sürecine ilişkin belirsizlikleri ve kaygılarını güvenli bir ortamda paylaşabildikleri; özellikle hormon tedavileri ve cerrahi süreçlerle ilişkili endişelerin ele alınabildiği dikkati çekmiştir.

Bu bulgular, telepsikiyatri uygulamalarının trans bireylerde yalnızca ruhsal semptomların yönetimine değil, aynı zamanda izolasyonun azaltılmasına ve öznel yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunduğunu gösteren uluslararası çalışmalarla örtüşmektedir. Pandemi sürecinde yapılan araştırmalar, telepsikiyatri ve e-sağlık uygulamalarının trans bireylerin sağlık sistemleriyle bağını sürdürmesine yardımcı olduğunu; ruhsal destek sürekliliğini sağlayarak psikolojik yükü hafıflettiğini bildirmektedir (MacCarthy et al., 2020; van der Miesen et al., 2020). Ayrıca, telepsikiyatrinin, damgalayıcı deneyimlere maruz kalma riskini azaltarak bireylerin yardım arama davranışlarını desteklediği vurgulanmaktadır (Renner et al., 2022).

Çalışmamızda öne çıkan önemli bir diğer bulgu, telepsikiyatri uygulamalarının damgalanma ve yanlış cinsiyetlendirilme kaygılarını azaltıcı bir işlev görmesidir. Fiziksel mekâna gitme zorunluluğunun ortadan kalkması, bazı bireyler için sağlık kurumlarında yaşanabilecek olumsuz deneyimlere karşı koruyucu bir etki yaratmıştır. Bu durum, özellikle daha önce sağlık hizmetlerinde ayrımcı tutumlarla karşılaşmış bireylerde, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırıcı bir faktör olarak değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, telepsikiyatri uygulamalarının bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Uygun görüşme ortamının sağlanamaması, ev içi mahremiyet sorunları, teknik altyapı yetersizlikleri ve bağlantı problemleri, görüşmelerin etkinliğini olumsuz etkileyebilen faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca, çevrim içi görüşmelerde gizlilik ve veri güvenliği konusundaki kaygılar, hem

klinisyenler hem de danışanlar açısından dikkatle ele alınması gereken etik sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, telepsikiyatri hizmetlerinin yaygınlaştırılması sürecinde güvenli dijital altyapıların oluşturulması, etik standartların netleştirilmesi ve kapsayıcı sağlık politikalarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır (Renner et al., 2022).

Sonuç olarak, telepsikiyatri uygulamaları cinsiyet uyumlandırma sürecinde olan trans bireyler için bütüncül, erişilebilir ve esnek bir ruh sağlığı hizmet modeli sunmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı deneyimi, bu modelin Türkiye bağlamında uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğunu göstermekte; telepsikiyatrinin multidisipliner cinsiyet uyumlandırma süreçlerine etkili biçimde entegre edilebileceğine işaret etmektedir. Bu deneyim, gelecekte yürütülecek çalışmalar için klinik, etik ve toplumsal düzeyde önemli bir referans noktası oluşturmakta; telepsikiyatrinin trans ruh sağlığı alanındaki potansiyelini ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Dorsey, E. R., & Topol, E. J. (2020). Telemedicine 2020 and the next decade. *The Lancet*, 395(10227), 859.
- Ekeland, A. G., Bowes, A., & Flottorp, S. (2010). Effectiveness of telemedicine: a systematic review of reviews. *International Journal of Medical Informatics*, 79(11), 736–771.
- Eyssel, J., Koehler, A., Dekker, A., Sehner, S., & Nieder, T. O. (2017). Needs and concerns of transgender individuals regarding interdisciplinary transgender healthcare: A non-clinical online survey. *PLoS One*, 12(8), e0183014.
- Gareayaghi, A., Tatlıdil, E., Şişman, E., & Polat, A. (2025). Post-Earthquake PTSD and the Role of Telepsychiatry: A Six-Month Follow-Up Study After the 2023 Kahramanmaraş Earthquakes. *Medicina*, 61(6), 1097.
- Gava, G., Fisher, A. D., Alvisi, S., Mancini, I., Franceschelli, A., Seracchioli, R., & Meriggola, M. C. (2021). Mental health and endocrine telemedicine consultations in transgender subjects during the COVID-19 outbreak in Italy: A cross-sectional web-based survey. *The Journal of Sexual Medicine*, 18(5), 900–907.
- Hertling, S., Hertling, D., Martin, D., & Graul, I. (2021). Acceptance, use, and barriers of telemedicine in transgender health care in times of SARS-CoV-2: Nationwide cross-sectional survey. *JMIR Public Health and Surveillance*, 7(12), e30278.
- Koehler, A., Motmans, J., Mulió Alvarez, L., Azul, D., Badalyan, K., Basar, K., ... & Nieder, T. O. (2023). How the COVID-19 pandemic affects transgender health care—A cross-sectional online survey in 63 upper-middle-income and high-income countries. *International Journal of Transgender Health*, 24(3), 346–359.
- MacCarthy, S., Izenberg, M., Barreras, J. L., Brooks, R. A., Gonzalez, A., & Linnemayr, S. (2020). Rapid mixed-methods assessment of COVID-19 impact on Latinx sexual minority men and Latinx transgender women. *PLoS One*, 15(12), e0244421.
- Magnus, M., Edwards, E., Dright, A., Gilliam, L., Brown, A., Levy, M., ... & Kuo, I. (2018). A feasibility study of a telehealth intervention on health care service utilization among transgender women of color in Washington, DC. *ACI Open*, 2(01), e1–e9.
- Nieder, T. O., Renner, J., Sehner, S., Pepić, A., Zapf, A., Lambert, M., ... & Dekker, A. (2024). Effect of the i2TransHealth e-health intervention on psychological distress among transgender and gender diverse adults from remote areas in Germany: a randomised controlled trial. *The Lancet Digital Health*, 6(12), e883–e893.

- Nieder, T. O., Renner, J., Zapf, A., Sehner, S., Hot, A., König, H. H., ... & Dekker, A. (2022). Interdisciplinary, internet-based trans health care (i²TransHealth): study protocol for a randomised controlled trial. *BMJ Open*, 12(2), e045980.
- Polat, A., & Alioğlu, F. (2019). Cinsiyet disforisi: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi deneyimi. *Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 20(1).
- Renner, J., Blaszyk, W., Täuber, L., Dekker, A., Briken, P., & Nieder, T. O. (2021). Barriers to accessing health care in rural regions by transgender, non-binary, and gender diverse people: a case-based scoping review. *Frontiers in Endocrinology*, 12, 717821.
- Renner, J., Taeuber, L., & Nieder, T. O. (2022). Need for inclusive consideration of transgender and gender diverse people in E-Health services: a systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 11(4), 1090.
- Ross, M. B., van de Grift, T. C., Elaut, E., Nieder, T. O., Becker-Hebly, I., Heylens, G., & Kreukels, B. P. (2023). Experienced barriers of care within European treatment seeking transgender individuals: A multicenter ENIGI follow-up study. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 26–37.
- Scheim, A. I., Coleman, T., Lachowsky, N., & Bauer, G. R. (2021). Health care access among transgender and nonbinary people in Canada, 2019: a cross-sectional survey. *Canadian Medical Association Open Access Journal*, 9(4), E1213–E1222.
- Schröder, J., Jelinek, L., & Moritz, S. (2017). A randomized controlled trial of a transdiagnostic Internet intervention for individuals with panic and phobias—one size fits all. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 54, 17–24.
- Van de Grift, T. C., Martens, C., van Ginneken, L., & Mullender, M. G. (2024). Waiting for transgender care and its effects on health and equality: a mixed-methods population study in the Netherlands. *EClinicalMedicine*, 73.
- Van der Miesen, A. I., Raaijmakers, D., & van de Grift, T. C. (2020). “You have to wait a little longer”: Transgender (mental) health at risk as a consequence of deferring gender-affirming treatments during COVID-19. *Archives of Sexual Behavior*, 49(5), 1395–1399.
- Watkinson, R. E., Linfield, A., Tielemans, J., Francetic, I., & Munford, L. (2024). Gender-related self-reported mental health inequalities in primary care in England: a cross-sectional analysis using the GP Patient Survey. *The Lancet Public Health*, 9(2), e100–e108.

BÖLÜM 8

Metakognitif Grup Terapisinin Şizofreni ve Şizoaffektif Bozuklukta Duygu Düzenleme Üzerindeki Etkisi*

Narmin İsayeva² & İsmail Emre Ak³

^{1*} Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

² Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye, Orcid:0009-0001-8119-5975

³ Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye, Orcid:0009-0003-4510-0013

1.GİRİŞ

Şizofreni ve şizoaffektif bozukluk, Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasına (ICD-11) göre; düşünce, algı, duygulanım ve davranış alanlarında belirgin bozulmalarla seyreden psikotik bozukluklar arasında yer almaktadır (World Health Organization [WHO], 2019). Şizofreni; sanrılar ve varsanılar gibi psikotik belirtiler ile dezorganize düşünce ve davranışların yanı sıra duygulanımda küntleşme, motivasyon kaybı ve sosyal geri çekilme gibi negatif belirtilerle karakterizedir. Şizoaffektif bozuklukta ise bu psikotik belirtilere majör duygudurum dönemleri eşlik etmekte; ayrıca psikotik belirtiler, duygudurum belirtilerinden bağımsız olarak da görülebilmektedir. Her iki bozukluk da genellikle erken dönemde başlayan ve kronik seyir gösteren ruhsal hastalıklardır (WHO, 2019).

Çalışmamızda bu iki tanının birlikte ele alınmasının temel gerekçesi, şizofreni ve şizoaffektif bozukluğun ICD-11 sınıflandırmasında psikoz spektrumu içerisinde yer alması ve her iki bozuklukta da psikotik belirtilere eşlik eden bilişsel yanlılıklar, metakognitif güçlükler ve duygu düzenleme sorunlarının benzer süreçler üzerinden tanımlanmasıdır (WHO, 2019; Freeman ve Garety, 2004; Lysaker ve Dimaggio, 2014).

Şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanılı bireyler, hastalık süreci boyunca duygu düzenleme, sosyal işlevsellik, kişilerarası ilişkiler, çalışma yaşamına katılım ve bağımsız günlük yaşam becerileri gibi birçok alanda belirgin güçlükler yaşayabilmektedir. Bu alanlardaki zorlanmaların önemli bir bileşeni olan duygu düzenleme, bireyin duygusal tepkilerini fark etme, değerlendirme ve bu tepkilere verdiği bilişsel ve davranışsal yanıtları yönetme kapasitesini ifade etmektedir (Gross, 1998). Psikotik bozukluklarda duygu düzenleme güçlüklerinin, çoğu zaman duygunun yoğunluğundan ziyade bu duygulara eşlik eden düşüncelerin katılığı ve bilişsel esnekliğin azalmasıyla ilişkili olduğu bildirilmektedir (Freeman ve Garety, 2004; Lysaker ve Dimaggio, 2014).

Klinik uygulamada farmakoterapi, özellikle pozitif belirtilerin kontrolünde temel bir tedavi yaklaşımı olmakla birlikte; birçok hastada duygu düzenleme güçlükleri, sosyal geri çekilme, bilişsel katılık ve içgörü dalgalanmaları remisyon dönemlerinde de devam edebilmektedir. Bu durum, bireyin işlevselliğinin sürdürülebilirliğini zorlaştırmakta ve iyilik halinin yalnızca semptom düzeyinde kalmasına neden olabilmektedir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü ve iyileşme odaklı ruh sağlığı yaklaşımları, psikotik bozukluklarda iyileşmenin yalnızca semptomların azalmasıyla sınırlı olmadığını; sosyal işlevsellik, öznel iyilik hali ve toplumsal katılımın da tedavinin temel hedefleri arasında yer alması gerektiğini vurgulamaktadır (Davidson ve ark., 2005; WHO, 2013).

Bu nedenle, duygu düzenleme süreçlerini ve bilişsel yanlılıkları hedef alan psikososyal terapiler, farmakoterapinin tamamlayıcısı olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Psikotik bozukluklarda düşünce içeriğiyle doğrudan

çalışmak zaman zaman direnç ve gerçeklik tartışmalarını artırabilmekteyken; metakognitif yaklaşımlar, düşünce içeriğine girmeden bireyin düşüncelerine yüklediği anlamı ve bu düşüncelere verdiği tepkileri hedeflemesi nedeniyle bu hasta grubu için daha güvenli ve tolere edilebilir bir müdahale sunmaktadır (Wells, 2009).

Metakognitif grup terapisi (MGT), Adrian Wells'in Self-Regulatory Executive Function (S-REF) modelinden köken alan ve bilişsel dikkat sendromunu (BDS) azaltmayı hedefleyen bir terapötik yaklaşımdır (Wells ve Matthews, 1994). MGT, bireylerin yalnızca “ne düşündükleriyle” değil, “düşünceleriyle nasıl ilişki kurduklarıyla” ilgilenir. Terapinin temel amacı, olumsuz düşünce ve duyguların varlığını ortadan kaldırmaktan ziyade, bireyin bu içsel deneyimlere verdiği tepkileri dönüştürmektir. Bu yönüyle MGT, duygu düzenleme güçlüklerinin ve bilişsel yanlılıkların merkezde olduğu psikotik bozukluklar için özgün ve mekanizma odaklı bir müdahale modeli sunmaktadır (Moritz ve Woodward, 2005).

Grup formatında yürütülen MGT uygulaması, yalnızca bilişsel düzeyde bir farkındalık sağlamaz; aynı zamanda sosyal öğrenme, model alma, akran geri bildirimi ve normalleştirme gibi grup terapisine özgü mekanizmalar yoluyla çok katmanlı bir iyileşme ortamı oluşturur. Türkiye’de toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri kapsamında yürütülen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) uygulamalarına ilişkin çalışmalar, yapılandırılmış grup temelli psikososyal müdahalelerin; hastaneye yatış sayıları, acil servis başvuruları ve zorunlu yatışlar gibi klinik göstergelerde anlamlı iyileşmelerle ilişkili olduğunu göstermektedir (Durmaz ve ark., 2019). Bu bulgular, grup temelli müdahalelerin yalnızca sosyal destek sağlamadığını; aynı zamanda klinik stabilite ve işlevsellik üzerinde koruyucu bir etki oluşturabileceğini düşündürmektedir.

Psikotik bozukluğu olan bireylerde, özellikle kişilerarası ilişkilerdeki geri çekilme ve güven sorunları nedeniyle bireysel terapilerin sürdürülebilirliği sınırlı olabilmektedir. Buna karşılık grup terapisi formatı, güvenli ve destekleyici bir sosyal bağlam sunarak metakognitif ve duygu düzenleme becerilerinin daha kalıcı biçimde pekişmesine olanak tanımaktadır. Günümüzde poliklinik temelli izlem ağırlıklı ruh sağlığı hizmetlerinde yapılandırılmış grup müdahalelerine erişimin sınırlı olması, bu tür terapilerin klinik etkilerinin araştırılmasını daha da önemli hale getirmektedir.

Bu çalışma, Türkiye’de poliklinik koşullarında izlenen şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanımlı hastalarda grup formatında uygulanan metakognitif terapinin yalnızca semptom kontrolünü değil; duygu düzenleme ve ilişkili bilişsel süreçlerde de iyileşme sağlayacağı ve kişilerarası işlevselliği güçlendirebileceği varsayımıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, metakognitif grup terapisinin psikotik bozukluklar üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, şizofreni ve şizoaffectif bozukluk tanıılı bireylerde metakognitif grup terapisinin (MGT) duygu düzenleme, bilişsel içgörü ve kişilerarası işlevsellik üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla planlanmış, eşleştirilmiş karşılaştırmalı ön test–son test tasarımına sahip bir araştırmadır. Terapötik etkiler nicel ölçüm araçlarıyla değerlendirilmiş; ayrıca terapi sürecine ilişkin nitel klinik gözlemlerden yararlanılmıştır.

Araştırmaya, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde izlenen ve DSM-5 ölçütlerine göre şizofreni (n = 14) veya şizoaffectif bozukluk (n = 10) tanısı almış toplam 24 hasta dâhil edilmiştir. Katılımcılar yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve hastalık süresi açısından eşleştirilerek iki gruba ayrılmış; 12 hasta metakognitif grup terapisi uygulanan müdahale grubunu, 12 hasta ise yalnızca rutin poliklinik izlemi ve farmakoterapi alan kontrol grubunu oluşturmuştur.

Çalışmaya, DSM-5'e göre şizofreni veya şizoaffectif bozukluk tanısı almış, remisyon döneminde olan, düzenli psikofarmakolojik tedavi kullanan, son 6 ayda hastane yatışı bulunmayan, 18 yaş üzeri ve gönüllü bireyler dâhil edilmiş; alkol/madde kullanım bozukluğu, grup psikoterapisine engel ciddi bedensel hastalık, demans veya ağır bilişsel yetersizlik bulunan, son 6 ayda hastane yatışı olan ya da katılımı kabul etmeyen bireyler çalışma dışı bırakılmıştır. Katılımcıların duygu düzenleme, bilişsel içgörü, klinik belirti şiddeti ve genel işlevsellik düzeylerini değerlendirmek amacıyla Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DERS-16), Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği (I-ERQ), Calgary Depresyon Ölçeği, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği (BCIS) ve Genel İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği (GAF) kullanılmıştır. Ölçekler terapi öncesinde ve terapi tamamlandıktan üç ay sonra uygulanmıştır.

Çalışma öncesinde tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmış; etik kurul onayı Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (Etik Kurul Karar No: KÜ GOKAEK – 2021/23.09 Proje No: 2021/364 2024) alınmıştır.

Metakognitif grup terapisi, Adrian Wells'in Self-Regulatory Executive Function (S-REF) modeline dayalı olarak yapılandırılmış; haftada bir kez uygulanan ve her biri yaklaşık 60 dakika süren toplam sekiz oturumdan oluşmuştur. Oturumlar psiko-eğitim, grup tartışması, deneyimsel alıştırmalar ve ev ödevlerini içerecek şekilde planlanmış ve iki terapist tarafından yürütülmüştür. Kontrol grubu çalışma süresince yalnızca rutin poliklinik izlemi ve farmakoterapi ile takip edilmiştir.

Verilerin analizi SPSS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiş; sürekli değişkenlerin dağılımı Shapiro–Wilk testi ile değerlendirilmiş ve dağılım

özelliklerine göre uygun parametrik veya non-parametrik istatistiksel testler uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

2.1. Metakognitif Grup Terapisi: Müdahale İçeriği ve Modüller

Metakognitif grup terapisi, Steffen Moritz ve Todd S. Woodward tarafından geliştirilen Metacognitive Training for Psychosis (MKT) modeline dayalı olarak uyarlanmıştır (Moritz ve Woodward, 2007; Moritz ve ark., 2014). Bireysel uygulamalar için geliştirilen MKT içeriği, bu çalışmada grup etkileşimini, akran geri bildirimini ve sosyal öğrenmeyi destekleyecek biçimde yeniden yapılandırılmıştır. Bu uyarlama ile metakognitif farkındalığın yalnızca bireysel düzeyde değil, kişilerarası bağlamda da güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Grup müdahalesi, haftada bir kez uygulanan ve her biri yaklaşık 60 dakika süren toplam sekiz yapılandırılmış oturumdan oluşmuştur. Oturumlar, duygusal güvenliği ve gizliliği destekleyen sabit ve öngörülebilir bir çerçevede; metakognitif terapi konusunda eğitim almış iki terapist ve bir psikiyatri hemşiresi eşliğinde yürütülmüştür. Her oturum, ele alınan bilişsel yanlılığa yönelik kısa bir psiko-eğitim, katılımcıların kendi yaşantılarını paylaşarak alternatif yorumlar geliştirdikleri grup tartışmaları, görsel-yazılı ya da rol canlandırma temelli deneyimsel alıştırma ve hafta boyunca izlenecek düşünce ya da durumların kaydedildiği ev ödevleri ile takip formlarını içermiştir. Terapistler süreci yapılandırıcı bir rol üstlenmiş; yorumlama ve çözüm üretme sorumluluğu katılımcılara bırakılmıştır.

Oturumlar sırasıyla atfetme biçimleri, hemen sonuca varma (I ve II), inançların esnetilmesi, empati kurma ve yüz ifadelerinin yorumlanması, bellek ve güven (metabellek), zihin kuramı, ruh hali ve özsaygı temalarını hedef alacak şekilde planlanmıştır. Her modül sonunda, ele alınan temanın günlük yaşama genellenmesini desteklemek amacıyla “alıştırma kartları” ile “dur–düşün–gözden geçir” sorularını içeren kısa materyaller kullanılmıştır. Süreç boyunca katılımcıların grup içi etkileşimleri, ev ödevi uyumu ve metakognitif farkındalık düzeylerindeki değişimler, her oturum sonrasında tutulan yapılandırılmış nitel klinik gözlem notları aracılığıyla izlenmiştir.

3.BULGULAR

Çalışmaya dâhil edilen 24 katılımcının (12 Metakognitif Grup Terapisi [MGT], 12 klinik izlem) yaş, cinsiyet ve temel sosyodemografik değişkenler açısından eşleştirilmesi sonrasında, gruplar arasında başlangıç (ön test) ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. MGT grubunda oturumlara katılım düzeyi yüksek bulunmuştur. Sekiz oturumun, en az altısına devam oranı %83 olarak saptanmıştır. Ev ödevi teslim oranı ilk haftalarda yaklaşık %70 düzeyindeyken, dördüncü oturumdan itibaren %80’in üzerine çıkmıştır. Süreç içi nitel klinik gözlemler, akran geri bildiriminin ve rol model

etkisinin artmasıyla birlikte oturumlara katılımın ve ev ödevi uyumunun belirgin biçimde yükseldiğini göstermektedir.

Terapi ve kontrol gruplarının ön test (ilk ölçüm) toplam puanları karşılaştırılmıştır. Verilerin normal dağılım varsayımını karşılamaması nedeniyle gruplar arası karşılaştırmalarda Mann–Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi $\alpha = .05$ olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) toplam puanı, Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği bileşik (composite) indeksi, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) toplam puanı, Global Değerlendirme Ölçeği (GAF) ve Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği toplam puanları açısından terapi ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu bulgular, terapi ve kontrol gruplarının başlangıç düzeylerinde eşdeğer olduğunu ve sonraki analizlerde gözlenen değişimlerin başlangıç farklılıklarından bağımsız olarak yorumlanabileceğini göstermektedir.

Ön test karşılaştırmalarının ardından, terapi ve kontrol gruplarında ölçek puanlarının zaman içindeki değişimi değerlendirilmiştir. Bu amaçla her iki grupta ölçeklerin ilk ve son ölçüm puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile karşılaştırılmıştır. Terapi grubunda kişilerarası duygu düzenleme, duygu düzenleme güçlüğü, PANSS toplam puanı ve global işlevsellik (GAF) düzeylerinde ilk ve son ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı değişimler saptanmıştır ($p < .01$). Değişimin yönü incelendiğinde, kişilerarası duygu düzenleme ve global işlevsellik düzeylerinde artış; duygu düzenleme güçlüğü ve PANSS toplam puanlarında ise azalma olduğu görülmüştür.

Kontrol grubunda ise kişilerarası duygu düzenleme ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmiş ($p < .05$), duygu düzenleme güçlüğü, PANSS toplam puanı ve global işlevsellik düzeylerinde ilk ve son ölçümler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($p > .05$). Analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Terapi ve Kontrol Gruplarında Ölçek Puanlarının Zaman İçindeki Değişimi (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi)

Ölçek	Grup	Artış (n)	Azalış (n)	Değişmeyen (n)	p
Kişilerarası Duygu Düzenleme	Terapi	11	1	0	.004
	Kontrol	8	1	3	.043
Duygu Düzenleme Güçlüğü	Terapi	0	12	0	.002
	Kontrol	2	7	3	.339
PANSS	Terapi	0	11	0	.003
	Kontrol	4	6	2	.572
Global Değerlendirme (GAF)	Terapi	12	0	0	.001
	Kontrol	4	3	5	.732

Zaman içindeki değişimin gruplar arasında farklılaşıp farklılaşmadığını değerlendirmek amacıyla, ölçeklerin değişim puanları (son ölçüm – ilk ölçüm) terapi ve kontrol grupları arasında Mann–Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda PANSS toplam puanı, Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği, Global Değerlendirme Ölçeği (GAF) ve Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği değişim puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır (tüm karşılaştırmalar için $p < .05$).

Ortalama sıralamalar incelendiğinde, terapi grubunda psikotik belirtiler, depresyon ve duygu düzenleme güçlüğünde daha belirgin bir azalma; kişilerarası duygu düzenleme, bilişsel içgörü ve genel işlevsellik düzeylerinde ise daha belirgin bir artış olduğu görülmüştür. Bu bulgular, metakognitif grup terapisinin etkilerinin grup içi değişimle sınırlı kalmayarak kontrol grubuna kıyasla anlamlı ve ayırt edici bir iyileşme örüntüsü oluşturduğunu göstermektedir. Gruplar arası karşılaştırma sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Terapi ve Kontrol Gruplarının Değişim Puanlarının Karşılaştırılması (Mann–Whitney U Testi)

Ölçek (Değişim Puanı)	Terapi Mean Rank	Kontrol Mean Rank	Mann–Whitney U	p
PANSS Toplam	Ağu.13	16.88	19.50	.002
Calgary Depresyon Ölçeği	Ağu.42	16.58	23.00	.004
Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği	Tem.58	17.42	13.00	< .001
Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği	15.71	9.29	33.50	.026
Global Değerlendirme Ölçeği (GAF)	17.21	7.79	15.50	<.001
Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği (Composite)	16.25	8.75	27.00	.008

Gruplar arası değişim farklarının ardından, gözlenen değişimlerin katılım düzeyi ve klinik değişkenlerle ilişkisi Spearman korelasyon analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, terapi oturumlarına katılım sayısı ile Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği değişim puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişki saptanmıştır ($\rho = -0.654$, $p = 0.021$). Bu bulgu, oturumlara daha düzenli katılım gösteren bireylerde depresif belirtilerde daha belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir.

Buna ek olarak, Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği değişim puanı ile Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği (Composite) değişim puanı arasında güçlü ve pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur ($\rho = 0.742$, $p = 0.006$). Bu sonuç, kişilerarası düzeyde duygu düzenleme becerilerindeki artışın, bilişsel içgörüdeki gelişimle paralel seyrettiğini ve bu iki alanın birbirini destekleyen süreçler olduğunu düşündürmektedir.

Diğer klinik ve tedaviye ilişkin değişkenler ile ölçek değişim puanları arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p > .05$). Korelasyon analizine ilişkin ayrıntılı sonuçlar Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Klinik Değişkenler ve Ölçek Değişim Puanları Arasındaki Korelasyonlar (Spearman ρ)

Değişkenler	Katılım Sayısı	Hastane Yatış Sayısı	Antipsikotik Sayısı	Calgary Değişim	PANSS Değişim	Duygu Düzenleme Güçlüğü Değişim	Kişilerarası Duygu Düzenleme Değişim	Global Değerlendirme Değişim	Beck Composite Değişim
Katılım Sayısı	—	0.550	0.075	— 0.654*	-0.179	-0.057	— 0.011	0.198	0.150
Hastane Yatış Sayısı	—	—	0.493	-0.440	-0.243	-0.287	0.020	0.390	0.121
Antipsikotik Sayısı	—	—	—	-0.051	0.077	-0.439	— 0.136	0.287	-0.210
Calgary Değişim	—	—	—	—	0.277	0.235	0.286	0.063	0.220
PANSS Değişim	—	—	—	—	—	0.423	— 0.244	-0.258	-0.395
Duygu Düzenleme Güçlüğü Değişim	—	—	—	—	—	—	0.116	-0.022	-0.157
Kişilerarası Duygu Düzenleme Değişim	—	—	—	—	—	—	—	-0.081	0.742*
Global Değerlendirme Değişim	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.246t
Beck Composite Değişim	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* $p < 0.05$ düzeyinde anlamlı, ** $p < 0.001$ düzeyinde anlamlı

4.TARTIŞMA

Bu araştırmada şizofreni ve şizoaffektif bozukluğu olan bireylerde uygulanan metakognitif grup terapisinin (MGT) depresif belirtiler, psikotik semptomlar, duygu düzenleme güçlükleri, kişilerarası duygu düzenleme becerileri, bilişsel içgörü ve genel işlevsellik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgular, üç aylık müdahale süreci sonunda metakognitif grup terapisinin hem klinik belirtiler hem de bilişsel, duygusal ve kişilerarası işlevsellik alanlarında anlamlı iyileşmeler sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar, psikoz spektrumundaki bireylerde iyileşmenin yalnızca semptom azalmasıyla sınırlı olmadığını; öznel, bilişsel ve sosyal alanları kapsayan bütüncül bir dönüşüm sürecini içerdiğini ortaya koymaktadır.

Çalışmada Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği sonuçlarına göre terapi grubunda depresif belirtilerde anlamlı bir azalma gözlenmiştir. Depresyon

puanlarının ön testten son teste belirgin biçimde düşmesi, metakognitif grup terapisinin psikozda sık görülen ve işlevselliği önemli ölçüde etkileyen depresif belirtiler üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Literatürde Moritz ve Woodward (2007), metakognitif terapinin yalnızca psikotik belirtilerle değil, depresif ve anksiyöz duygulanımla baş etmede de etkili olduğunu bildirmiştir. Mevcut çalışmanın bulguları, bu literatürle tutarlılık göstermektedir.

Psikotik belirtilerin genel şiddetini yansıtan PANSS toplam puanlarında terapi grubunda saptanan anlamlı azalma, metakognitif grup terapisinin psikotik semptomların yoğunluğunu azaltmada etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu bulgu, terapinin bireylerin düşüncelerini mutlak gerçeklik olarak ele alma eğilimini azaltarak bilişsel esnekliği artırmasıyla ilişkili olabilir. Moritz ve arkadaşlarının (2019) çalışmalarında da metakognitif müdahalelerin hezeyan şiddetini azalttığı ve paranoid düşünme biçimlerini yumuşattığı gösterilmiştir. Bu çalışmada da benzer biçimde, bireylerin düşüncelerine daha eleştirel ve mesafeli yaklaşabildikleri gözlenmiştir.

Genel işlevselliği değerlendiren Global Değerlendirme Ölçeği (GAF) puanlarında terapi grubunda elde edilen artış, müdahalenin yalnızca semptomları azaltmakla kalmadığını, bireylerin günlük yaşam işlevselliğini de anlamlı biçimde güçlendirdiğini göstermektedir. Şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta işlevsellik düzeyi; semptom şiddetinin yanı sıra duygu düzenleme kapasitesi, sosyal biliş ve bilişsel içgörüyle yakından ilişkilidir. Lysaker ve Dimaggio (2014), metakognitif süreçlerin sosyal ve mesleki işlevsellikteki iyileşmenin temel belirleyicilerinden biri olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmanın bulguları da bu görüşü desteklemektedir.

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DERS) sonuçları, terapi grubunda duygu düzenleme kapasitesinde anlamlı bir iyileşme olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle duyguları tanıma, dürtü kontrolü, hedefe yönelik davranış ve düzenleme stratejilerine erişim alanlarında kaydedilen gelişmeler, bireylerin yoğun duygular karşısında daha işlevsel baş etme yolları geliştirebildiklerini düşündürmektedir. Psikotik bozukluklarda bilişsel yanlılıklar ve metakognitif kapasite eksiklikleri, bireyin deneyimlerini anlama ve duygusal-bilişsel süreçleri bütünleştirme yeteneğini zorlaştırmaktadır (Freeman ve Garety, 2004; Lysaker ve Dimaggio, 2014). Bu çalışmada duygu düzenleme becerilerindeki artışın bilişsel içgörüdeki gelişmeyle paralel seyretmesi, bu kuramsal çerçeveye uyumludur.

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği bulguları, metakognitif grup terapisinin sosyal paylaşım, duygusal destek arama ve kişilerarası farkındalık alanlarında belirgin bir gelişim sağladığını göstermektedir. Grup ortamında diğer bireylerin duygusal deneyimlerine tanıklık edilmesi, katılımcıların kendi içsel yaşantılarını daha nesnel değerlendirebilmelerine ve empatik rezonans geliştirmelerine olanak tanımıştır. Hasson-Ohayon ve arkadaşları (2016), metakognitif temelli grup

müdahalelerinin empati ve öz-anlayışı artırarak kişilerarası ilişkileri güçlendirdiğini bildirmiştir. Bu çalışmanın bulguları da söz konusu görüşlerle örtüşmektedir.

Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği sonuçları, öz-düşünsellikte artış ve aşırı kendine güvende azalma olduğunu göstermiştir. Bu durum, bireylerin düşüncelerine mutlak doğruluk atfetme eğilimlerinin azaldığını ve bilişsel esnekliğin arttığını düşündürmektedir. Moritz ve Lysaker (2018), bu süreci “epistemik alçakgönüllülük” kavramı ile tanımlamakta ve metakognitif terapilerin bu bilişsel tutumu güçlendirdiğini vurgulamaktadır.

Korelasyon analizleri, terapi sürecine katılımın klinik ve psikolojik kazanımlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Oturumlara düzenli katılım ile depresif belirtilerdeki azalma arasında saptanan negatif ilişki, terapötik sürece aktif katılımın tedavi çıktıları üzerindeki belirleyici rolünü göstermektedir. Ayrıca kişilerarası duygu düzenleme ile bilişsel içgörü değişimleri arasındaki güçlü pozitif ilişki, içsel farkındalık ile kişilerarası işlevsellik arasındaki karşılıklı ve güçlendirici etkileşimi ortaya koymaktadır.

Güncel iyileşme modelleri, şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta iyileşmeyi klinik, işlevsel ve öznel boyutları içeren çok boyutlu bir süreç olarak ele almaktadır (Roe ve Davidson, 2005). Bu çalışmanın bulguları, metakognitif grup terapisinin bu üç boyutun tamamında etkili olduğunu ve iyileşmeyi pasif bir semptom azalması süreci olmaktan çıkararak aktif bir özneleşme deneyimine dönüştürdüğünü göstermektedir.

Nitel genelleme göstergeleri, metakognitif grup terapisinin kazanımlarının yalnızca ölçek puanlarıyla sınırlı kalmadığını, günlük yaşama da anlamlı biçimde yansıdığını göstermektedir. Üniversite öğrencisi bir katılımcının akademik dönemi ders kaybı yaşamadan tamamlaması, işsiz bir katılımcının yeni bir işe başlaması, emekli bir katılımcının düzenli yürüyüşlere ve planlı aktivitelere katılım göstermesi ve başlangıçta yalnızca ailesiyle vakit geçiren bir katılımcının akranlarıyla sosyal etkinlikler başlatabilmesi, terapötik kazanımların işlevsel alanlara genelleştigiine dair somut örnekler sunmaktadır.

Kültürel bağlam ve grup dinamikleri de bu genelleşme sürecinde belirleyici rol oynamıştır. Türkiye örnekleminde görece güçlü olan toplulukçu eğilimler ile aile ve arkadaş ağlarının koruyucu işlevi, Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği puanlarındaki artışlarla uyumlu biçimde, sosyal paylaşımın bir duygu düzenleme stratejisi olarak daha sık kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Grup sürecinde ortaya çıkan “normalleştirme”, “aidiyet” ve “akran modeli” etkileri, katılımcıların hem duygusal kabul düzeylerini hem de davranış başlatma kapasitelerini güçlendirerek katmanlı bir terapötik etki yaratmıştır.

Sonuç olarak, metakognitif grup terapisi şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta yalnızca bilişsel yanlılıkları esnetmekle sınırlı kalmamış; duygu düzenleme

becerilerini (özellikle kabul ve dürtü kontrolü), bilişsel içgörüyü ve kişilerarası duygu düzenleme stratejilerini güçlendirerek psikotik belirti yükünü azaltmış ve genel işlevselliği artırmıştır. Bu etkiler, grup faktörlerinin destekleyici rolüyle birlikte günlük yaşama genellenebilen ve sürdürülebilir terapötik kazanımlara dönüşmüştür

5.SONUÇ

Bu çalışma, şizofreni ve şizoaffectif bozukluğu olan, remisyon döneminde izlenen bireylerde poliklinik koşullarında uygulanan metakognitif grup terapisinin (MGT) yalnızca klinik belirti yükünde değil; kişilerarası duygu düzenleme ve bilişsel içgörü gibi iyileşmenin mekanizma düzeyindeki bileşenlerinde de anlamlı ve ayırt edici bir değişim örüntüsü oluşturduğunu göstermektedir. Müdahale grubunda duygu düzenleme güçlüklerinde belirgin azalma, kişilerarası duygu düzenleme becerilerinde artış, PANSS toplam puanında düşüş ve GAF puanında artışın eş zamanlı ortaya çıkması, MGT'nin psikoz spektrumunda “semptom kontrolü” ile sınırlı kalmayıp işlevselliği taşıyan temel süreçleri hedefleyebildiğine işaret etmektedir. Bu yönüyle bulgular, psikozda iyileşmenin yalnızca klinik belirtilerin gerilemesi değil; duygusal esneklik, sosyal katılım ve öznel ajansın güçlenmesiyle birlikte ilerleyen çok boyutlu bir dönüşüm olduğu görüşünü desteklemektedir.

Araştırmamızın özgün katkılarından biri, metakognitif bir grup müdahalesinin duygu düzenleme alanında yarattığı değişimi kontrol grubuna kıyasla anlamlı biçimde ortaya koymasındır. Duygu düzenleme güçlüğündeki azalma, psikotik bozukluklarda sık görülen “duygunun kendisinden çok, duyguya eşlik eden bilişsel katılık ve otomatik tepkisellik” problemine mekanizma-odaklı bir yanıt olarak değerlendirilebilir. MGT'nin hedeflediği “düşünce içeriğiyle tartışmak yerine düşünceyle ilişkiyi değiştirme” yaklaşımı, özellikle paranoid yorumlar veya katı inançlar gibi süreçlerde, doğrudan içerik tartışmasına girmeden bilişsel mesafe yaratabilmesi açısından klinik pratikte avantaj sağlayabilir. Çalışmamız, bu yaklaşımın duygu düzenleme kapasitesini artırarak psikotik belirti şiddetinde azalmaya eşlik edebildiğini göstermektedir.

İkinci önemli özgün bulgu, kişilerarası duygu düzenleme becerilerindeki artışın bilişsel içgörüdeki gelişimle güçlü biçimde ilişkili bulunmasıdır (I-ERQ değişimi ile BCIS composite değişimi arasındaki güçlü pozitif korelasyon). Bu sonuç, metakognitif kazanımların yalnızca “içe dönük bir farkındalık” olarak kalmadığını; sosyal bağlamda duygu paylaşımı, destek arama ve kişilerarası geri bildirim süreçleri üzerinden pekişerek bilişsel içgörüyü güçlendirebildiğini düşündürmektedir. Bizim yorumumuza göre, grup formatı burada yalnızca “destek” sağlayan bir çerçeve değil; metakognitif becerilerin gerçek zamanlı sosyal etkileşim içinde test edildiği ve düzeltilindiği bir “öğrenme laboratuvarı” işlevi görmüş olabilir. Bu mekanizma, psikozda sık görülen sosyal geri çekilme

ve ilişkisel kopuklukların iyileşme sürecini neden yavaşlattığını da açıklayıcı bir perspektif sunmaktadır.

Üçüncü olarak, oturumlara katılım düzeyi ile depresif belirtilerdeki azalma arasındaki anlamlı negatif ilişki, müdahalenin etkisinin “doz–yanıt” benzeri bir örüntü gösterebileceğine işaret etmektedir. Klinik uygulama açısından bu bulgu, MGT’nin etkinliğinin yalnızca içeriğe değil, katılımın sürdürülmesine de duyarlı olduğunu; dolayısıyla randevu hatırlatmaları, motivasyonel mikro-görüşmeler, aile ile iş birliği ya da TRSM temelli destek gibi devamlılığı artıracak yapıların tedavi çıktıları açısından kritik olabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçların pratik karşılığı şudur: Poliklinik izleminde, remisyon dönemindeki şizofreni/şizoafektif bozukluk hastalarında yalnızca farmakoterapiyle sürdürülen izlem, duygu düzenleme ve sosyal işlevsellik alanındaki kalıntı güçlükleri her zaman yeterince hedefleyemeyebilir. MGT’nin grup formatında uygulanması ise hem maliyet-etkin bir çerçeve sunabilir hem de sosyal öğrenme, normalleştirme ve akran geri bildirimi gibi grup faktörleri aracılığıyla duygu düzenleme süreçlerinin günlük yaşama genellenmesini kolaylaştırabilir. Çalışmamızın bulguları, MGT’nin standart izleme entegre edilebilecek uygulanabilir bir psikososyal müdahale olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte bulgular, bazı sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir: örneklem büyüklüğünün sınırlı olması, tek merkezli tasarım ve üç aylık takip süresinin uzun dönem kalıcılık hakkında sınırlı çıkarım sunması, genellenebilirliği azaltabilir. Buna rağmen, grupların başlangıçta eşdeğer olması ve müdahale sonrasında çoklu alanlarda (klinik belirti, duygu düzenleme, kişilerarası düzenleme, içgörü ve işlevsellik) kontrol grubuna kıyasla tutarlı bir değişim örüntüsü gösterilmesi, MGT’nin etki potansiyelini güçlendirmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma metakognitif grup terapisinin psikoz spektrumunda duygu düzenleme ve ilişkili metakognitif süreçleri iyileştirerek klinik belirtileri azaltma ve işlevselliği artırma yönünde bütüncül bir katkı sunabileceğini göstermektedir. Bizim özgün önerimiz, MGT’nin psikozda “duygu düzenleme–bilişsel içgörü–kişilerarası düzenleme” üçgenini aynı anda hedefleyen bir mekanizma odaklı iyileşme modeli olarak ele alınmasıdır. Gelecek çalışmaların daha geniş örneklemle, çok merkezli tasarımlarla, daha uzun izlem süreleriyle ve özellikle (i) katılımı artıran uygulama stratejilerinin, (ii) duygu düzenlemedeki değişimin PANSS/GAF üzerindeki aracılık rolünün ve (iii) grup faktörlerinin (normalleştirme, akran modeli, geri bildirim) tedavi yanıtına katkısının test edilmesiyle bu modelin daha net biçimde doğrulanabileceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Freeman, D., & Garety, P.A. (2004). *Paranoia: The Psychology of Persecutory Delusions* (1st ed.). Psychology Press.
<https://doi.org/10.4324/9780203508633>
- Brüne, M., Abdel-Hamid, M., Lehmkämpfer, C., & Sonntag, C. (2011). Mental state attribution, neurocognitive functioning, and psychopathology: What predicts poor social competence in schizophrenia best? *Schizophrenia Research*, 130(1–3), 204–209. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2011.05.006>
- Davidson, L., O’Connell, M., Tondora, J., Styron, T., & Kangas, K. (2005). The top ten concerns about recovery encountered in mental health system transformation. *Psychiatric Services*, 56(5), 640–645. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.56.5.640>
- Durmaz, O., & Akkişi Kumsar, N. (2020). Toplum ruh sağlığı merkezi uygulamalarının şizofreni hastalığının sürecine klinik değişkenler temelinde etkisi. *Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi*, 2(2), 82-88. <https://doi.org/10.35365/ctjpp.20.02.12>
- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271>
- Hasson-Ohayon, I., Gumley, A., McLeod, H., Lysaker, P. H., & Dimaggio, G. (2016). Metacognitive training and social functioning in schizophrenia: A systematic review. *Clinical Psychology Review*, 48, 32–45. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.07.003>
- Kring, A. M., & Bachorowski, J. A. (1999). Emotions and psychopathology. *Cognition & Emotion*, 13(5), 575–599.
- Lysaker, P. H., & Dimaggio, G. (2014). Metacognitive capacities for reflection in schizophrenia: Implications for developing treatments. *Schizophrenia Bulletin*, 40(3), 487–491.
- Moritz, S., Klein, J. P., Lysaker, P. H., & Mehl, S. (2019). Metacognitive and cognitive-behavioral interventions for psychosis: New developments. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 21(3), 309–317.
- Moritz, S., & Lysaker, P. H. (2018). Metacognition, insight, and delusions: A critical review. *Schizophrenia Bulletin*, 44(3), 552–561. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbx182>
- Moritz, S., Veckenstedt, R., Andreou, C., Bohn, F., Hottenrott, B., Leighton, L., Roesch-Ely, D. (2014). Sustained and “sleeper” effects of group metacognitive training for schizophrenia: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, 71(10), 1103–1111.

- Moritz, S., & Woodward, T. S. (2007). Metacognitive training in schizophrenia: From basic research to knowledge translation and intervention. *Current Opinion in Psychiatry*, 20(6), 619–625.
- Roe, D., & Davidson, L. (2005). Self and narrative in schizophrenia: time to author a new story. *Medical humanities*, 31(2), 89–94. <https://doi.org/10.1136/jmh.2005.000214>
- Strauss, G. P., Sandt, A. R., Catalano, L. T., & Allen, D. N. (2012). Negative symptoms and depression predict lower psychological well-being in individuals with schizophrenia. *Comprehensive Psychiatry*, 53(8), 1137–1144. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2012.05.009>
- Wells, A. (2011). *Metacognitive therapy for anxiety and depression*. Guilford Press.
- Wells, A., & Matthews, G. (1994). *Attention and emotion: A clinical perspective*. Lawrence Erlbaum Associates.
- World Health Organization. (2013). *Mental health action plan 2013–2020*. WHO Press.
- World Health Organization. (2019). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics* (11th ed.). <https://icd.who.int/>

BÖLÜM 9

Çocuk Ruh Sağlığının Desteklenmesinde Doğa Temelli Müdahaleler: Bir Derleme*

**Öznur Elçelik² & Nigar Çankaya³ & Nesrin Arslan³ &
Nurcan Gebeşoğlu⁴**

^{1*} Bu çalışma aynı adla 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde bildiri özeti olarak sunulmuştur.

²Hemşire, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Türkiye

³ Hemşire, Esentepe Aile Sağlığı Merkezi, Karabük, Türkiye,

³ Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye,

⁴ Uzm. Hemşire, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Türkiye

1. GİRİŞ

Çocukluk dönemi, bireyin ruhsal, duygusal ve sosyal gelişiminin temellerinin atıldığı en kritik evredir. Bu dönemde yaşanan çevresel, ailevi veya toplumsal faktörler, çocukların ruh sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabilmektedir. Günümüzde şehirleşme, dijital bağımlılık, akademik baskı ve doğadan uzak yaşam biçimi gibi etkenler, çocuklarda kaygı, dikkat eksikliği, depresif belirtiler ve sosyal izolasyon gibi sorunları artırmaktadır (Tillmann ve ark., 2018).

Erken yaşlarda doğa ile temas halinde olmak sağlıklı ruhsal gelişime olumlu etkiler sağlamaktadır. Doğa ile temas, çocuklarda duygusal denge, dikkat, merak ve özgüven gelişimini destekleyen; tarih boyunca iyileştirici gücü kabul edilmiş bir yaklaşımdır. Doğada zaman geçirmek çocuklarda benmerkezciliği azaltarak çocukların sağlıklı kişilik gelişimine katkı sunmaktadır (Wolsko ve Lindberg, 2013). Pouya, Bayramoğlu ve Demirel (2016) açık yeşil alanların çocuklardaki özgürlük duygusunu beslediğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle doğa temelli etkinlikler, çocuk ruh sağlığını güçlendirmede etkili ve yenilikçi bir halk sağlığı aracıdır (Chawla, 2015). Dünya Sağlık Örgütü, çocukların doğa ile temasının ruhsal iyi oluş için temel bir çevresel determinant olduğunu vurgulamaktadır (WHO, 2022). Son yıllarda yapılan sistematik derlemeler ve meta-analizler, çocukluk döneminde doğa ile temasın ruh sağlığı üzerindeki koruyucu ve destekleyici etkilerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Özellikle yeşil alanlara erişimin sınırlı olduğu kentsel yaşam koşullarında büyüyen çocuklarda kaygı, dikkat sorunları ve davranışsal problemler daha sık görülmektedir (Tillmann ve ark., 2018; McCormick, 2017). Buna karşılık doğa temelli etkinliklerin, çocukların stresle baş etme becerilerini güçlendirdiği, duygusal dengeyi desteklediği ve sosyal uyumu artırdığı bildirilmektedir (Chawla ve ark., 2014; Mygind ve ark., 2019).

Bu derleme çalışmasının amacı, doğa temelli müdahalelerin çocuk ruh sağlığı üzerindeki etkilerini tartışmak ve okul sağlığı hemşireleri ile sağlık profesyonellerine uygulanabilir öneriler sunmaktır.

Doğa Temelli Müdahalelerin Kavramsal Çerçevesi

Doğa temelli müdahaleler (nature-based interventions), bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyilik hâllerini desteklemek amacıyla doğa ile kurdukları etkileşimi bilinçli olarak artıran yapılandırılmış uygulamalardır (Bratman ve ark., 2019). Bu yaklaşım; yalnızca bireyin doğa içinde bulunmasını değil, aynı zamanda doğa ile aktif bir ilişki kurmasını da hedefler. Bahçe terapisi, ekosanat etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, yeşil okul projeleri ve orman okulları bu müdahale türleri arasında yer alır. Avrupa’da “green care” olarak tanımlanan bu kavram, özellikle çocuk ve genç ruh sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve destekleyici bir model olarak benimsenmiştir. Green care uygulamaları; bireyin doğa ile bütünleşmesini sağlayarak stres düzeyini azaltmayı, sosyal ilişkileri

güçlendirmeyi ve öz farkındalığı geliştirmeyi amaçlamaktadır (van den Bosch ve Bird, 2018).

Bu çerçevede ekosanat (eco-art), çocukların çevreden topladıkları doğal materyalleri (yaprak, taş, dal, tohum gibi) kullanarak özgün sanat ürünleri oluşturdukları bir öğrenme biçimidir. Böylece çocuklar hem doğa ile duygusal bir bağ kurar, hem de yaratıcılıklarını, çevre farkındalıklarını ve estetik duyarlılıklarını geliştirirler (Inwood, 2008). Ekosanat etkinlikleri, doğanın iyileştirici yönüyle sanatın duygusal ifade gücünü birleştirerek çocukların kendilerini ifade etme, dikkatini toplama ve duygusal regülasyon becerilerini destekler. Uzun vadede bu tür doğa temelli yaklaşımların eğitim programlarına sistematik biçimde entegre edilmesi, çocuklarda çevreye yönelik olumlu tutum ve davranışların gelişmesini sağlayarak toplumsal düzeyde çevre okuryazarlığının artmasına katkıda bulunabilir (Bratman ve ark., 2019). Özellikle doğal çevrelerin sunduğu güvenli ve uyarıcı olmayan yapının, çocukların psikolojik yenilenme süreçlerini desteklediği ve ruhsal dayanıklılığı artırdığı bildirilmektedir (Frumkin ve ark., 2017). Ayrıca doğa temelli yaklaşımların, çocukların çevreyle kurdukları ilişkiyi anlamlandırmalarına yardımcı olarak öz farkındalık ve aidiyet duygusunu güçlendirdiği; bu yönüyle ruh sağlığını destekleyen koruyucu bir çerçeve sunduğu vurgulanmaktadır (Liu ve Green, 2023).

Doğa ve Çocuk Ruh Sağlığı İlişkin Bulgular

Çocuklar iç mekanlarda daha fazla zaman geçirirken, çocuklarda ruhsal ve davranışsal sağlık sorunları da artmaktadır. Yeşil alanlara düzenli erişimin çocukların ruh sağlığına faydaları vardır (Mc Cormick, 2017). Literatürde doğa ile temasın çocuklarda çok yönlü olumlu etkiler yarattığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bu olumlu etkiler;

Dikkat ve bilişsel işlevler: Yeşil alanlarda geçirilen zaman, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerini hafifletir ve konsantrasyonu artırır (Faber Taylor ve Kuo, 2009).

Sosyal beceriler: Grup halinde yapılan doğa etkinlikleri, çocuklarda empati, paylaşma ve iş birliği becerilerini geliştirir (Mc Cormick, 2017).

Duygu düzenleme ve öz farkındalık: Doğa ile düzenli temas, duygusal farkındalığı artırır ve içsel sakinliği destekler (Richardson ve ark., 2022).

Yaratıcılık ve özgüven: Ekosanat ve bahçe çalışmaları, çocukların üretkenlik ve kendini ifade becerilerini güçlendirir (Inwood, 2008).

Doğa ve çocuk ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen güncel çalışmalar, yeşil alanlara maruziyetin çocukların dikkat, davranışsal gelişim ve duygusal iyilik hâli üzerinde belirgin etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Amoly ve arkadaşları (2014), okul çağındaki çocuklarda yeşil alanlarla çevrili ortamlarda

bulunmanın davranışsal gelişimi olumlu yönde etkilediğini bildirirken; Dadvand ve arkadaşları (2015) yeşil alan maruziyetinin bilişsel gelişim ve dikkat kapasitesi ile anlamlı biçimde ilişkili olduğunu göstermiştir. Bir başka çalışmada Markevych ve arkadaşları (2017), doğa ile temasın çocuk ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin stres azalması, dikkat yenilenmesi ve sosyal etkileşim mekanizmaları üzerinden açıklanabileceğini vurgulamaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra Mygind ve arkadaşları (2019), okul temelli açık hava programlarının çocukların akademik motivasyonunu, öz yeterlik algısını ve öğrenmeye yönelik tutumlarını güçlendirdiğini belirtirken; Tillmann ve arkadaşları (2018) doğa ile temasın kaygı ve depresif belirtiler üzerinde koruyucu bir rol üstlendiğine dikkat çekmektedir. Benzer şekilde, McCormick (2017) yeşil alanlara erişimin çocukların ruhsal iyi oluşunu desteklediğini ve davranışsal sorunları azalttığını rapor etmiştir. Ayrıca, Faber Taylor ve Kuo (2009) doğada geçirilen zamanın dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerini hafiflettiğini ortaya koymuştur. Richardson ve arkadaşları (2022) ise doğayla kurulan bilinçli etkileşimin, çocukların öz farkındalıklarını ve içsel sakinlik düzeylerini artırarak duygusal dengeyi desteklediğini vurgulamaktadır.

Okul Temelli Uygulamalar

Okul ortamları, doğa temelli uygulamaların sürdürülebilir biçimde yerleştirilebileceği en uygun ve etkili alanlardır. Çocuklar okulda geçirdikleri uzun zaman dilimi boyunca, doğayla bütünleşik öğrenme deneyimleri aracılığıyla hem bilişsel hem de duygusal gelişimlerini destekleyebilirler. Bu bağlamda okul bahçesi projeleri, çocukların doğa ile doğrudan temas kurarak gözlem yapma, sorumluluk alma, sabır gösterme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmelerine olanak tanır (Ohly ve ark., 2016). Bitki yetiştirme, toprakla uğraşma ve çevre düzenlemesi gibi etkinlikler çocukların doğaya karşı empati geliştirmesini, canlılara karşı duyarlılık kazanmasını ve çevresel sorumluluk bilincini artırır. Ayrıca, bu tür uygulamalar çocukların stres düzeylerini azaltarak okul bağlılığını güçlendirmekte ve özsaygılarını desteklemektedir.

Yeşil sınıf uygulamaları veya dış mekân dersleri, çocukların yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda öğrenmeye yönelik motivasyonlarını da artırmaktadır. Doğayla bütünleşik öğrenme, öğrencilerin dikkat sürelerini uzatmakta, öğrenme süreçlerine aktif katılımı teşvik etmekte ve derslerde kalıcı öğrenmeyi desteklemektedir (Becker et al., 2017). Nitekim, okul öncesi dönem çocuklarıyla yarı deneysel bir araştırma yürüten Kaya ve Özyürek (2022), açık alanda eğitim gören çocukların sosyal becerilerinde anlamlı artış, problem davranışlarında ise belirgin azalma tespit etmişlerdir. Benzer biçimde, Chawla ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada çocukların doğal açık hava deneyimlerinin fen, yaratıcı yazarlık ve sanat gibi derslerde bilişsel esneklik ve yaratıcılık üzerinde olumlu etkiler yarattığı; ayrıca sağlık, tarih ve toplum bilinci gibi diğer ders alanlarına da kolaylıkla entegre edilebildiği ortaya konmuştur.

Ekosanat gibi sanat temelli doğa etkinlikleri, öğrencilerin duygusal ifadelerini güçlendirmekte, empati düzeylerini artırmakta ve sosyal uyumlarını desteklemektedir (Inwood, 2008). Bu etkinlikler, çocukların çevresel farkındalığını sanat yoluyla içselleştirmelerine olanak tanır; aynı zamanda duygusal rahatlama, öz-yansıtma ve iş birliği becerilerini geliştirir. Okul ortamında yürütülen doğa temelli sanat etkinlikleri, öğrencilerin sadece bireysel yaratıcılıklarını değil, aynı zamanda grup içi etkileşimlerini de güçlendirerek sosyal bağlılığı artırır. Okul hemşireleri, doğa temelli uygulamaların ruh sağlığına katkı sağlayacak biçimde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde merkezi bir role sahiptir. Hemşireler; öğrencilerin ruhsal iyilik halini, stres düzeylerini ve sosyal ilişkilerini izleyerek risk altındaki grupları belirleyebilir; öğretmenler ve ailelerle iş birliği içinde bütüncül bir sağlık yaklaşımı geliştirebilir (McCormick, 2017). Ayrıca okul hemşireleri, doğa temelli programların sağlık eğitimi içerikleriyle bütünleştirilmesinde disiplinler arası bir köprü işlevi görür.

Türkiye’de doğa temelli uygulamalara yönelik çalışmalar henüz sınırlı sayıda olsa da bu alanda ilginin giderek arttığı görülmektedir. Mevcut araştırmalar çoğunlukla okul öncesi düzeyde kısa süreli müdahalelere odaklanmış olup, doğa temelli programların uzun dönemli etkilerini ve kültürel bağlamla uyumunu inceleyen kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır. Özellikle okul sağlığı hemşireliği, eko sanat ve toplum temelli çevre eğitimi uygulamalarının bütüncül biçimde entegre edildiği modellerin geliştirilmesi, çocukların hem ruhsal hem çevresel farkındalıklarını artırmada önemli bir adım olacaktır (Öztürk ve Öztürk, 2023; Yıldırım ve Şimşek, 2022). Bu tür çalışmalar, Türkiye’de doğa temelli eğitimin sağlık, çevre ve sanat ekseninde yeniden yapılandırılmasına bilimsel katkı sağlayacaktır.

Toplum Sağlığı Perspektifi

Doğa temelli programlar yalnızca okul ortamında değil, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinde de etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir araç olarak kullanılabilir. Özellikle dezavantajlı topluluklarda, doğal çevreyle temas çocukların hem bireysel hem de sosyal düzeyde iyileşme süreçlerini destekleyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Doğal ortamların sakinleştirici etkisi, çocuklarda duygusal regülasyonu kolaylaştırmakta; açık hava etkinlikleri ise sosyal etkileşimi, paylaşımı ve aidiyet hissini artırmaktadır. Travma yaşamış, göçmen veya sosyoekonomik olarak dezavantajlı çocuklarda doğayla temas, güven duygusunun yeniden inşa edilmesine, travmatik deneyimlerin etkilerinin azaltılmasına ve stresle baş etme becerilerinin güçlenmesine katkı sağlar (Gidlow ve ark., 2016). Bu tür müdahaleler, çocukların hem bireysel dayanıklılığını hem de topluluk içinde işlevselliğini artırarak uzun vadede ruhsal iyilik halini destekler. Aile katılımı, çocuğun doğa deneyiminin sürdürülebilirliği ve kalıcılığı açısından belirleyici bir faktördür. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte doğada

vakit geçirmesi, yalnızca ebeveyn-çocuk bağına güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ebeveynlerin doğanın terapötik gücüne dair farkındalığını da artırır. Ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı bahçe çalışmaları, doğa yürüyüşleri veya eko sanat etkinlikleri gibi etkinlikler; iletişimi, duygusal paylaşımı ve karşılıklı güveni teşvik eder (Gray et al., 2019). Böylece doğa, aile içi ilişkilerin onarılmasına ve çocukların duygusal güven ortamında gelişmesine katkı sağlayan bir bağ kurma alanı haline gelir.

2. SONUÇ VE ÖNERİLER

Doğa temelli müdahalelerin çocuk ruh sağlığı üzerindeki etkileri son yıllarda artan bir ilgiyle ele alınmakta; mevcut araştırmalar bu yaklaşımların çocukların ruhsal iyilik hâlini çok boyutlu biçimde desteklediğini ortaya koymaktadır. Çocukların doğayla düzenli temasının stres, kaygı ve depresif belirtileri azalttığı; dikkat, öz düzenleme ve duygusal dayanıklılık gibi temel psikososyal becerileri güçlendirdiği görülmektedir (Tillmann ve ark., 2018; Mygind ve ark., 2019; Liu ve Green, 2023). Özellikle ekosanat, bahçe terapisi ve açık hava öğrenme ortamları gibi yapılandırılmış doğa temelli uygulamalar, çocukların kendilerini ifade etmelerine, sosyal ilişkilerini geliştirmelerine ve çevreyle sağlıklı bir bağ kurmalarına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda doğa temelli müdahaleler, yalnızca çocuk ruh sağlığını destekleyen tamamlayıcı uygulamalar değil; aynı zamanda okul sağlığı hemşireliği ve halk sağlığı uygulamalarında bütüncül, sürdürülebilir ve önleyici bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.

Literatür bulguları, doğa temelli yaklaşımların yalnızca bireysel ruhsal iyilik hâlini değil, aynı zamanda okul bağlılığını ve öğrenmeye yönelik motivasyonu da artırdığını ortaya koymaktadır. Bu durum, doğa temelli müdahalelerin eğitim ve sağlık alanları arasında köprü kuran bütüncül bir yaklaşım sunduğunu göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuk ruh sağlığına ilişkin stratejileri de doğa ile temasın koruyucu bir çevresel faktör olduğunu vurgulamaktadır (World Health Organization, 2022). Uygulama açısından değerlendirildiğinde, okul sağlığı hemşireleri ve eğitimciler doğa temelli etkinlikleri çocukların ruhsal iyilik hâlini destekleyen tamamlayıcı bir araç olarak kullanabilirler. Okul bahçesi projeleri, açık hava dersleri ve ekosanat etkinliklerinin eğitim programlarına entegre edilmesi; çocukların hem ruhsal hem de çevresel farkındalıklarını artırmada önemli bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca aile katılımının teşvik edilmesi, doğa temelli deneyimlerin sürdürülebilirliğini güçlendirecek ve çocukların sosyal destek sistemlerini zenginleştirecektir.

Gelecekte yapılacak araştırmalarda, doğa temelli müdahalelerin farklı yaş grupları, sosyoekonomik düzeyler ve kültürel bağlamlar üzerindeki etkilerinin uzun vadeli izleme çalışmalarıyla değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca Türkiye koşullarına özgü, okul temelli doğa etkinlikleriyle harmanlanmış modellerin geliştirilmesi, sağlık eğitimi ve halk sağlığı politikalarına yenilikçi bir katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Amoly, E., Dadvand, P., Forns, J., López-Vicente, M., Basagaña, X., Julvez, J., ... Sunyer, J. (2014). Green and blue spaces and behavioral development in Barcelona schoolchildren: The BREATHE project. *Environmental Health Perspectives*, 122(12), 1351–1358. <https://doi.org/10.1289/ehp.1408215>
- Becker, C., Lauterbach, G., Spengler, S., Dettweiler, U., & Mess, F. (2017). Effects of regular classes in outdoor education settings: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 8, 305. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.0305>
- Bratman, G. N., Anderson, C. B., Berman, M. G., Cochran, B., De Vries, S., Flanders, J., ... & Daily, G. C. (2019). Nature and mental health: An ecosystem service perspective. *Science Advances*, 5(7), eaax0903.
- Chawla, L. (2015). Benefits of nature contact for children. *Journal of Planning Literature*, 30(4), 433-452.
- Chawla, L., Keena, K., Pevec, I., & Stanley, E. (2014). Green schoolyards as havens from stress and resources for resilience in childhood and adolescence. *Health & Place*, 28, 1-13.
- Dadvand, P., Nieuwenhuijsen, M. J., Esnaola, M., Forns, J., Basagaña, X., Alvarez-Pedrerol, M., ... & Sunyer, J. (2015). Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(26), 7937-7942.
- Faber Taylor, A., & Kuo, F. E. (2009). Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. *Journal of Attention Disorders*, 12(5), 402–409.
- Frumkin, H., Bratman, G. N., Breslow, S. J., Cochran, B., Kahn Jr, P. H., Lawler, J. J., ... & Wood, S. A. (2017). Nature contact and human health: A research agenda. *Environmental Health Perspectives*, 125(7), 075001.
- Gidlow, C. J., Jones, M. V., Hurst, G., Masterson, D., Clark-Carter, D., Tarvainen, M. P., ... & Nieuwenhuijsen, M. (2016). Where to put your best foot forward: Psycho-physiological responses to walking in natural and urban environments. *Journal of Environmental Psychology*, 45, 22-29.
- Gray, C., Gibbons, R., Larouche, R., et al. (2019). What is the relationship between outdoor time and physical activity, sedentary behaviour, and mental health in children? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12(6), 6455–6474.
- Inwood, H. (2008). Mapping Eco-Art Education. *Canadian Review of Art Education: Research and Issues*, 35, 57-73.
- Liu, J., & Green, R. J. (2023). The effect of exposure to nature on children's psychological well-being: A systematic review of the literature. *Urban Forestry & Urban Greening*, 81, 127846.

- Markevych, I., Schoierer, J., Hartig, T., Chudnovsky, A., Hystad, P., Dzhambov, A. M., ... & Fuentes, E. (2017). Exploring pathways linking greenspace to health: Theoretical and methodological guidance. *Environmental research*, 158, 301-317.
- McCormick, R. (2017). Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, 37, 3-7.
- Mygind, L., Kjeldsted, E., Hartmeyer, R., et al. (2019). Effects of outdoor education programs on students' learning and wellbeing: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(22), 4293.
- Ohly, H., White, M. P., Wheeler, B. W., et al. (2016). Attention restoration theory: A systematic review of the attention restoration potential of exposure to natural environments. *Journal of Toxicology and Environmental Health*, 19(7), 305–343.
- Öztürk, M., & Öztürk, G. (2023). Okul öncesi dönemde doğa temelli öğrenme yaklaşımlarının çocuk gelişimine etkileri. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 11(2), 450–468.
- Pouya, S., Bayramoğlu, E., & Demirel, Ö. (2016). Doğa ile uyumlu fiziksel engelli çocuk oyun alanları. *Journal of Architectural Sciences and Applications*, 1(1), 51-60.
- Richardson, M., Hamlin, I., Butler, C. W., Thomas, R., & Hunt, A. (2022). Actively noticing nature (not just time in nature) helps promote nature connectedness. *Ecopsychology*, 14(1), 8-16.
- Tillmann, S., Tobin, D., Avison, W., & Gilliland, J. (2018). Mental health benefits of interactions with nature in children and teenagers: A systematic review. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 72(10), 958–966.
- Van den Bosch, M., & Bird, W. (Eds.). (2018). *Oxford textbook of nature and public health: The role of nature in improving the health of a population*. Oxford University Press.
- Wolsko, C., & Lindberg, K. (2013). Experiencing connection with nature: The matrix of psychological well-being, mindfulness, and outdoor recreation. *Ecopsychology*, 5(2), 80-91.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Urban green spaces and health: A review of evidence*. WHO Regional Office for Europe.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2022). Türkiye’de doğa temelli eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi: Güncel durum ve öneriler. *Milli Eğitim Dergisi*, 51(234), 1203–1220.

Modern Ruh Saęlıęı Uygulamaları: Klinik Bulgular, Terapötik Yöntemler ve Psikososyal Müdahaleler

Editör

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Adem KILIÇ



Platanus Publishing

ISBN

978-625-8519-48-3